

16

Turvallisuus

Tässä luvussa

- Tapaturmariski
- Potilasturvallisuusstrategia
- Rajoittaminen
- Laiteturvallisuus
- Lääketurvallisuus (ks. luku 8)



Potilasturvallisuuden edistäminen on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien tehtävä. Työyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Potilasturvallisuus ei perustu vain yksittäisen henkilön ammattitaitoon vaan syntyy organisaation osien yhteisvaikutuksesta. Huolellisinkin työntekijä saattaa tehdä virheen, jos hänen työkuormansa on suuri tai hänen tarkkaavaisuutensa häiriintyy. Jos virhe tapahtuu ja potilasturvallisuus vaarantuu, työntekijää ei syyllistetä vaan tarkastellaan koko työyksikön toimintaa ja niitä seikkoja, jotka johtivat potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Tärkeintä on oppia tapahtuneesta tilanteesta, jottei vastaavaa enää sattuisi.

Sairastuminen aiheuttaa usein pelkoa ja epävarmuutta. Turvallisen hoitoympäristön luominen taas lisää potilaan turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi liukkaat lattiat ja korkeat kynnykset vaarantavat potilaan fyysisen turvallisuuden. Ulkoisella turvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä kaikissa hoitoympäristöissä.

16.1 Turvallisen ympäristön järjestäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti vuonna 2009 ensimmäisen suomalaisen potilasturvallisuusstrategian. Uusin potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia on vuosille 2017–2021.

➔ Potilasturvallisuusstrategia: www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1383571

Potilashoidossa tapahtuneesta tapaturma- tai vaaratilanteesta käytetään termiä **poikkeama**. Sen lisäksi käytetään termiä **vaaratapahtuma**. Eri-laiset vaaratapahtumat taas jaetaan läheltä piti-tapahtumiin ja haittatapahtumiin. Poikkeaman selvittelyssä painopiste on tilanteen syyn analysoinnissa. Tilanteesta opitaan ja etsitään keinoja poikkeaman ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Potilasturvallisuus jaetaan laiteturvallisuuteen, hoidon turvallisuuteen ja lääkehoidon turvallisuuteen.



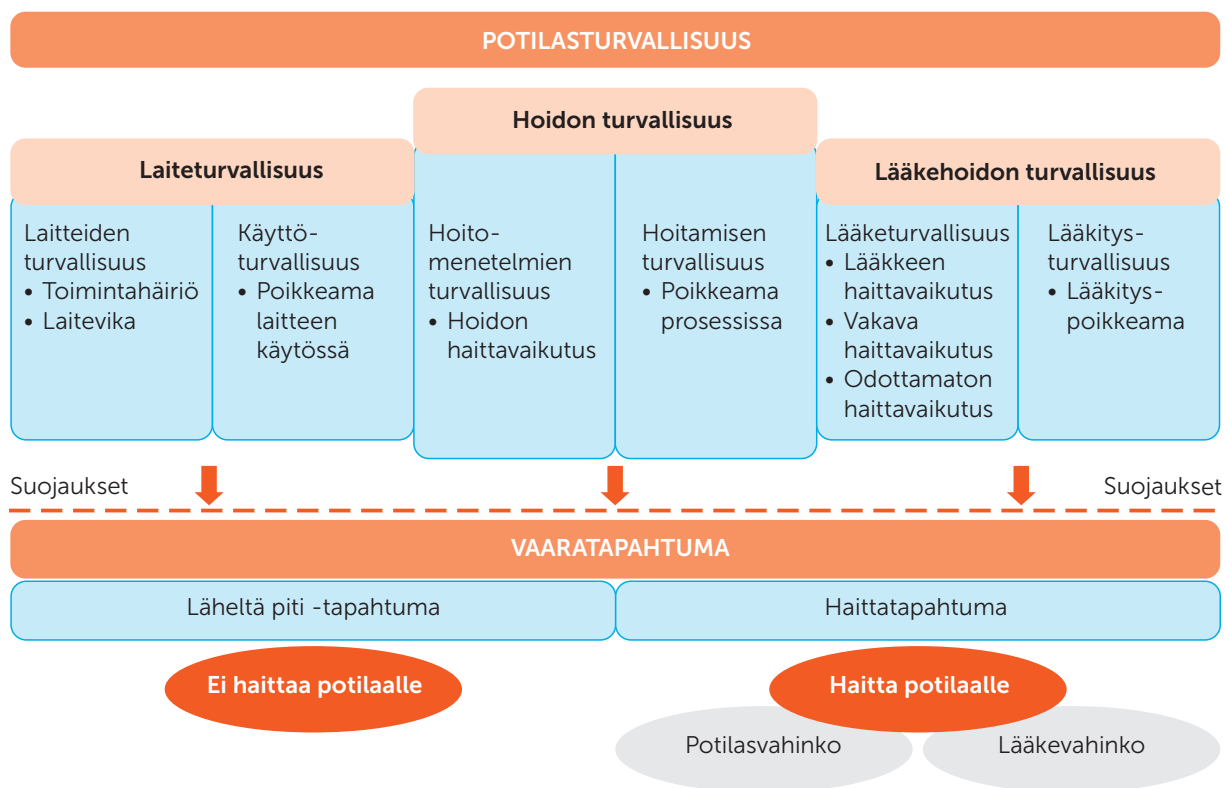
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017–2021 tavoitteet:

- Potilas, asiakas ja läheiset osallistuvat aktiivisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.
- Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa.
- Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita vaaratapahtumilta.
- Turvallisen hoidon ja hoivan edellyttämät voimavarat ja osaaminen on varmistettu.
- Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen on varmistettu.
- Potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään kansallisesti.

Hoidon turvallisuus voidaan vielä jakaa hoitomenetelmien turvallisuuteen ja hoitamisen turvallisuuteen.

Hoidon turvallisuus korostuu kaikessa toiminnassa. Suurin osa potilaille tapahtuvista putoamis- ja kaatumistapaturmista sattuu potilaan vuoteen läheisyydessä ja suihku- ja WC-tiloissa. Näihin tapaturmiin liittyy usein sekavuutta ja huimausta. Kosteissa tiloissa tapaturmille altistaa vedestä ja saippuasta johtuva liukkaus. Jokaisessa hoitotilanteessa ja -ympäristössä on sille tyypillisiä tapaturmille altistavia tekijöitä. Hoitajan onkin muistettava ottaa huomioon tapaturman mahdollisuus. Työyksiköjen on järjestettävä perehdytystä ja koulutusta, jotta henkilökunta kykenee luomaan turvallisen ympäristön kaikissa hoitotilanteissa.

➔ THL toteutti yhdessä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten ja muiden kansallisten kumppaneiden kanssa **Potilasturvallisuutta taidolla** -ohjelmaa (2011–2015). **Potilasturvallisuusportti** on THL:n kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Ohjelman päämääränä on hoidon aiheuttamien haittatapahtumien vähentäminen puoleen vuoteen 2020 mennessä.



Kuva 16.1 Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet

Laiteturvallisuutta ohjaa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Laki edellyttää, että terveydenhuollossa käytettävät välineet ovat sekä potilaalle että käyttäjälle turvallisia.

Pelastussuunnitelman laatimisesta on säädetty pelastuslaissa (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Jokai-

sessä organisaatiossa on oltava pelastussuunnitelma. Uuden työntekijän perehdytysuunnitelmaan kuuluu työyksikön palo- ja pelastussuunnitelmaan tutustuminen sekä alkusammutusvälineiden käytön opettelu ja säilytyspaikkoihin perehtyminen.

Potilaan henkilökohtainen omaisuus

Potilasta vastaanotettaessa sovitaan, mitä omaisuutta hänellä voi olla mukanaan sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Jos potilas ei voi pitää kaikkia henkilökohtaisia tavaroita mukanaan, säilytettäväksi luovutetut tavarat luetteloidaan potilaan läsnä ollessa ja luettelon allekirjoittavat potilas sekä kaksi henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Jos potilas ei itse kykene allekirjoittamaan luetteloa, siihen pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan potilaan omaisen tai läheisen allekirjoitus. Ennen allekirjoitusta luetteloon tulee myös merkitä potilaan suostuminen tavaroiden säilyttämiseen. Kun tavaroita luovutetaan potilaalle säilytyksestä, poti-

Laiteturvallisuutta edistävät

- laitteiden käyttöön perehdytys ja koulutus
- laitteiden säännöllinen huolto
- rikkoutuneiden ja viallisten laitteiden poistaminen käytöstä
- selkeä vastuunjako
- suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet ja -merkinnät
- vaaratilanteista Lääkelaitokselle annetut ilmoitukset.

las kuittaa vastaanottaneensa luetteloon yksilöidyt tavarat ja kaksi henkilökuntaan kuuluvaa todistaa asian allekirjoituksillaan.

Mielenterveyslain (laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001) mukaan potilaalta voidaan **ottaa toimintayksikköön haltuun** sellaista omaisuutta, joka vaarantaa hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Tällaista omaisuutta voivat olla muun muassa päihteet tai huumausaineiden käyttöön soveltuvat välineet. Samoin saadaan ottaa haltuun muut hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä vakavasti haittavat aineet ja esineet. Myös rahaa tai muita maksuvälineitä voidaan ottaa sairaalan haltuun, jos on todennäköistä, että potilas sairautensa vuoksi hävittäisi ne. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä, millaista omaisuutta on otettu haltuun ja miksi. Päätöksen omaisuuden haltuunotosta tekee viime kädessä vastaava lääkäri. Päätös annetaan tiedoksi potilaalle ja hänen lailliselle edustajalleen. Jos potilas kieltäytyy luovuttamasta omaisuuttaan, vastentahtoisin tarkastuksen tekee poliisi. Jos potilas kieltäytyy allekirjoittamasta omaisuuden haltuunottoa, maketta, haltuunoton tiedoksi antamisen todistaa kaksi sairaalan henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Jos potilaalla on **alkoholia**, vastaava lääkäri päättää sen käsittelystä. Jos vankilaan tai muuhun suljettuun laitokseen tai päihdehuollon yksikköön otettavalla tai siellä hoidettavana olevala on alkoholijuomaa tai muuta alkoholipitoista ainetta, laitoksen henkilökuntaan kuuluva saa ottaa sen häneltä pois ja hävittää.

Jos alkoholi hävitetään, asiakirjoihin merkitään sen hävittämisaika ja -paikka, hävittämistapa, hävittämisen suorittaja ja todistaja sekä alkoholin tyyppi ja määrä. Potilaalta tavatun **huumausaineen** tai sellaiseksi epäillyn osalta toimitaan lääkärin ohjeen mukaan ja asiasta ilmoitetaan viipymättä poliisille. Aine ja huumetta hallussa pitäneen potilaan henkilötiedot luovutetaan poliisille. Sairaala ei saa hävittää huumausaineita. Löydetty **huumausaineet, ampuma-aseet ja teräaseet** luovutetaan poliisille. Jos on pienikin epäily, että sairaalaan on tuotu räjähteitä, asiasta on ilmoitettava viipymättä vastuunalaiselle lääkärille, joka päättää kiireellisestä yhteydenotosta poliisiin.

16.2 Potilaan liikkumisen rajoittaminen ja seuranta

Potilaan liikkumisvapauden mahdollisesta rajoittamisesta lääkäri päättää yksilöllisesti, ja siitä on tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin.

Muissa kuin tahdosta riippumattomissa hoitotilanteissa potilas saa milloin tahansa poistua hoidosta. Potilaan tulee allekirjoituksellaan vakuuttaa, että hän on tietoinen hoidosta poistumisensa riskeistä. Tällöin potilas poistuu **omalla vastuullaan**.

Hoitohenkilökunta saa potilaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen käyttää tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina potilaan oman edun näkökulmasta. Hoi-



Suoria rajoitusmuotoja (fyysisiä rajoitteita) voivat olla erilaiset laitteet, varusteet, apuvälineet ja keinot, kuten

- sängynlaidat
- geriatrinen tuoli ja pyörätuoli, jossa on pöytälevy
- pyörätuoli tai tavallinen tuoli, jossa on vyökiinnitys
- huoneen oven sulkeminen tai lukitseminen
- turvaliivit
- rannepidikkeet
- magneettivyö ja vuodevaatteet
- hoitohenkilöstön toimet, kuten fyysisen voiman käyttö, jolla estetään potilaan liikkuminen.

Epäsuoria rajoittamismuotoja ovat muun muassa

- liikkumisen apuvälineen poistaminen
- soittokellon poistaminen
- hoitaja ei anna potilaalle vaatteita
- hoitaja ei auta potilasta liikkumisessa
- hoitaja ei vastaa soittokellon kutsuun.

tohenkilökunta saa pitää potilasta kiinni estääkseen häntä poistumasta sairaalasta ja lääkärin määräämistä sairaalan ulkopuolella tapahtuvista tutkimus- ja hoitotilanteista, jos lääkäri on arvioinut, että potilaan poistumisesta aiheutuu vaaraa potilaan tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle.

Fyysinen rajoite määrittellään joko potilaan vartalossa kiinni olevaksi tai vartalosta irrallaan olevaksi menetelmäksi, fyysiseksi tai mekaaniseksi keinoksi, jonka käytön tarkoituksena on liikkumisen rajoittaminen. Liikkumisen rajoittamisesta käytetään myös käsitteitä pakotteiden käyttö ja fyysinen sitominen. Tutkimustulosten pohjalta voidaan fyysisten rajoitteiden käyttö laitoshoidossa määrittellä potilaan liikkumisen suoraksi tai epäsuoraksi rajoittamiseksi, jossa aloitteentekijänä voi olla potilas itse, omainen tai hoitaja.

Liikkumista tai toimintaa voidaan rajoittaa myös kemiallisesti. **Kemiallisella rajoittamisella** tarkoitetaan, että lääkäri määrää potilaalle lääketta siten, että sen yksinomaisena tarkoituksena on rajoittaa potilaan liikkumista tai muuta toimintaa tai hillitää käyttäytymistä. Kun lääkettä käytetään asianmukaisesti sairauden hoitoon oikealla annoksella, ja muu lääkitys huomioiden, kyse ei ole kemiallisesta rajoittamisesta.

➔ Kehitysvamma- ja mielenterveyspotilaiden osalta fyysisten rajoitteiden käyttöä säännellään lailla, mutta vanhusten osalta sitä koskeva lainsäädäntö puuttuu vielä. Suosituksia fyysisten rajoitteiden käytöstä vanhusten laitoshoidossa ovat antaneet valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE 2008), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira 2009) ja eduskunnan oikeusasiamies (Paunio 2005). Asiasta on valmisteilla laki.

Lisätietoa itsemääräämisoikeudesta: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 27/2018. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavilla osoitteessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM_R_27_Asiak_itsemaaramisoikeus_sos_terv_huollossa.pdf

Rajoitteiden käytöllä pyritään lisäämään **potilaan turvallisuutta**, estämään häntä häiritsemästä ympäristöään ja mahdollistamaan hoitotoimenpiteiden



Suosituksissa korostetaan, että jokaisessa rajoittamistilanteessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Tilanne arvioidaan yksilöllisesti.
- Vanhusta tai hänen omaistaan kuullaan.
- Päätöksen tekee lääkäri.
- Rajoituksen haittoja ja hyötyjä puntaroidaan.
- Rajoittamiseen käytetään vain asianmukaisia välineitä ja niiden käyttöohjeita noudatetaan.
- Rajoittaminen dokumentoidaan potilasasiakirjoihin.
- Rajoitettua vanhusta valvotaan riittävästi.
- Rajoittaminen lopetetaan heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.

tekemistä. Fyysisten rajoitteiden käyttö on potilaalle **usein haitallista**, koska se voi heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi se on laitoshoidossa eettisesti pulmallista, koska rajoitteiden käyttö vastoin potilaan tahtoa rikkoo ihmisoi-keuksia sekä potilaan itsemääräämisoikeutta ja perustuslaillisia oikeuksia, kuten oikeutta henkilökoh- taiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Jos vanhustenhoitoyksiköissä ei satu vahinkoja, esimerkiksi vanhusten kaatumisia, on todennäköistä, että kysymys on vanhusten pitämisestä liikkumattomina. Sekä omaisten että hoitavan yksikön pitäisi pystyä hyväksymään tosiasiaksi myös se, ettei kaikkea voida estää. Lisäksi tulisi tarkastella asiaa vanhuksen näkökulmasta ja miettiä, onko hänen kannaltaan parempi vaihtoehto viettää aikaa vyökiinnityksessä vai päästä liikkumaan siihen liittyvine kaatumisriskeineen.

Hoitotyössä **pyritään vähentämään** fyysisten rajoitteiden käyttöä. Hoitaja voi kokea potilaan fyysisen rajoittamisen ahdistavaksi ja ihmisarvoa loukkaavaksi. Fyysinen rajoittaminen on sidoksissa hoitolaitoksen hoitokulttuuriin. Usein hoitajat eivät tiedosta, että he rajoittavat potilasta, vaan he luulevat toimivansa potilasturvallisuuden nimissä.

Taulukko 16.1 **Potilaalle aiheutuvat negatiiviset seuraukset fyysisten rajoitteiden käytöstä**
(mukailtu teoksesta Saarnio 2009)

Fyysiset vaikutukset	Psyykkiset vaikutukset
- Fyysisen toimintakyvyn heikentyminen - Ääreisverenkierron heikentyminen - Infektioherkkyyden lisääntyminen - Aggressiivisuuden lisääntyminen - Kardiovaskulaariselle stressille altistuminen - Mahdollinen virtsanpidätyskyvyttömyys - Lihasten surkastuminen - Painehaavojen lisääntyminen - Tapaturmien lisääntyminen - Kuolleisuuden lisääntyminen	- Kognitiivisen toiminnan heikentyminen - Passiivisuuden ja hoitajista riippuvaisuuden lisääntyminen - Levottomuuden ja sekavuuden lisääntyminen - Depressiivisyyden lisääntyminen - Verbaalisen aggressiivisuuden lisääntyminen - Toivottomuus ja avuttomuus - Epämukavuus, pelko ja viha, tunne vangittuna olemisesta, tunne ylisuojelusta ja lapsenomaisesta kohtelusta - Tottuminen fyysisiin rajoitteisiin ja riippuvaisuus niistä - Itsemääräämisoikeuden loukkaamiselle ja kaltoinkohtelulle altistuminen
Sosiaaliset vaikutukset	
Sosiaalisen toimintakyvyn heikentyminen	



Fyysisten rajoitteiden käytön vähentämiseen liittyvät tekijät (mukailtu teoksesta Saarnio 2009)

Hoitajaan liittyvät tekijät

- Koulutus ja ohjaus
- Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
- Potilaan taustan tunteminen
- Haasteellisesti käyttäytyvän potilaan kohtaaminen ymmärtävästi, ystävällisesti ja vastuullisesti
- Levottoman potilaan siirtäminen kanslian läheisyyteen
- Tarpeettomien hoitojen lopettaminen
- Potilaan kaatumisriskin arviointi
- Potilaan kunnollisista jalkineista ja liikkumisen apuvälineistä huolehtiminen
- Fyysisten rajoitteiden käytöstä aiheutuvien haittojen tiedostaminen
- Tietoisuus fyysisten rajoitteiden käyttöön liittyvistä ohjeista ja säännöistä

Työyhteisöön liittyvät tekijät

- Yhteinen keskustelu
- Hoitokulttuurin muuttaminen
- Moniammatillinen yhteistyö
- Yhteinen toimintatapa
- Omaisten mukaan ottaminen päätöksentekoon
- Fyysisten rajoitteiden käytön kirjaaminen
- Luovien hoitomenetelmien hyödyntäminen
- Tieteellisten tutkimusten hyödyntäminen
- Asiantuntijoiden hyödyntäminen

Organisaatioon liittyvät tekijät

- Hoidon laadun arviointi
- Tutustuminen muiden organisaatioiden toimintatapoihin
- Henkilökuntamäärän lisääminen
- Kuntouttavan henkilökunnan osallistuminen hoitoon
- Johdon tuki
- Selkeät ohjeet fyysisten rajoitteiden käyttämisestä
- Hoitoympäristön muokkaaminen turvallisemmaksi
- Apuvälineiden hyödyntäminen
- Potilaiden hoito tarkoituksenmukaisessa yksikössä

Yhteiskuntaan liittyvät tekijät

- Lainsäädännön selkeyttäminen fyysisten rajoitteiden käytöstä kaikkien potilaiden hoidossa

Vaihtoehtoja rajoitteiden käytölle

- Potilaan toiveiden kuunteleminen
- Potilaan lähellä oleminen
- Potilaan rauhoittaminen esimerkiksi koskettamalla
- Moniammatillisessa ryhmässä toimiminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittäminen
- Johtajien tuki
- Täydennyskoulutus

16.3 Tapaturmariskin huomioiminen

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta ja ulkoista tapahtumaa, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta ja aiheuttaa henkilövahingon. Potilasvakuutuksesta tapaturma korvataan vain, jos se liittyy suoraan hoito- tai tutkimustoimenpiteeseen. Yleisiä tavalliseen elämään liittyviä tapaturmia ei korvata. Vaikkei vahinko olisi tapaturmana korvattava, se voi kuitenkin olla hoitovahinkona korvattava, jos potilaan asianmukainen valvonta tai avustaminen on laiminlyöty, vaikka se käytävissä olevat resurssit huomioiden olisi ollut mahdollista. Tyypillisin tapaturma hoitolaitoksessa on **potilaan kaatuminen**. Hoitolaitoksissa tapahtuvat kaatumiset voivat olla erilaisin keinoin ennakoitavissa, minkä vuoksi kaatumisia on mahdollista myös ehkäistä. Tapaturmien altistavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.

16.4 Tapaturmariskin vähentäminen

Henkilökunnan vankka sitoutuminen ja myönteinen suhtautuminen työhön vähentävät potilaiden tapaturmariskiä. Kaatumisriski ei riipu ainostaan henkilökunnan määrästä vaan myös sen tavoitettavuudesta. Hoitohenkilökunnan pitää miettiä potilaiden huonesijoitusta myös siitä näkökulmasta, että huonosti liikkuvat ja nopeasti apua tarvitsevat potilaat saavat apua mahdollisimman nopeasti.

Hoitolaitoksissa, joissa potilaiden tarpeet on ennakoitu ja niihin on vastattu, sattuu tapaturmia harvemmin kuin muualla. Jokaiselle tapaturma-alttiille potilaalle on varsinkin pitkäaikaishoitolaitoksessa hyvä laatia henkilökohtainen **tapaturmien ehkäisyohjelma**. Apuna voi käyttää esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen julkaisemaa kaatumisvaaran arviointilomaketta.

 IKINÄ-opas ikäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn:
www.thl.fi

Jokaisessa työyksikössä tulee olla **tapaturmarekisteri**, josta ilmenevät tapaturmien tiedot. Sen perusteella voidaan arvioida, kenelle, milloin ja missä tapaturmia sattuu, ja suunnitella hoitohenkilöstön työvuorot tarkoituksenmukaisiksi. Hoitolaitoksissa voidaan erilaisten toimenpiteiden avulla ehkäistä kaatumisia. Ensimmäinen askel riskin pienentämisessä ovat tapaturmarekisterin pito ja sen pohjalta tehty riskitilanteiden arviointi. Henkilökunnalle voidaan antaa tietoa riskitilanteista ja siten kouluttaa heitä **tunnistamaan riskitilanteet**. Myös potilasta on hyvä opastaa **ennakoimaan** riskitilanteet ja toimimaan niissä varovaisesti. Hoitolaitos voi lisäksi järjestää riskiryhmille (esim. nivelsairaille, Parkinson-potilaille ja aivohalvauspotilaille) hälytysrannekkeet ja huolehtia, että ulkoiset riskitekijät on huomioitu niin, että tapaturmariski on mahdollisimman pieni. Tilat tulee suunnitella hoitolaitosten rakennusvaiheessa esteettömiksi ja turvallisiksi.

Potilaan asianmukaisesta ja **turvallisesta vaa-**
tetuksesta ja apuvälineiden kunnosta huolehtiminen lisää potilasturvallisuutta. Tapaturma-alttiille potilaille voidaan hankkia erilaisia ”suojavaatteita”, esimerkiksi kypärä tai lonkkasuojain. Myös kien turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja niiden tulee olla tukevat ja turvalliset. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut lomakkeen turvallisten jalkineiden valinnasta. Sängyn korkeuden alentaminen, liukastamattomat lattiatapinnat, riittävä valaistus, yksilölliset istuimet ja sängyn lukitus vähentävät tapaturmia. Huonekalujen sijoittelua ja myös värejä tulisi miettiä yksilöllisesti, ja tarvittaessa tulee ottaa huomioon potilaan heikko näkö. Tapaturmia voidaan ehkäistä myös pitämällä potilaan henkilökohtaiset apuvälineet, kuten silmälasit ja kuulolaitteet, potilaan ulottuvilla, toimivina ja puhtaina.

Kylpyhuoneessa ja WC-tiloissa tulee olla riittävästi tilaa tarvittavien apuvälineiden käyttämiseen liikkumisen apuna. Kylpyhuoneen lattiamateriaalin tulisi olla märkänäkin liukumaton. Tukikahvojen, WC-istuimen korotuksen, suihkutuolin ja ammeistuimen avulla voidaan lisätä kylpytilojen turvallisuutta. Pesuaineet on hyvä pitää käden ulottuvilla, jotta potilas kykenee ottamaan ne helposti.

Taulukko 16.2 Yleisimmät kaatumisen sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät (mukailtu teoksesta Mänty ym. 2007)

SISÄISET TEKIJÄT	ULKOISET TEKIJÄT
Näkökyvyn heikkeneminen • silmäsairaudet • ikääntyminen	Kävelypinnat • hiekoittamattomat jäiset tiet • märkä tai liukas lattia • tavarat kulkuväylillä • epätasainen alusta • kynnykset • mattojen reunat • johdot ja kaapelit
Asento- ja kosketustunnon heikkeneminen • jalkapohjan ja niskan alueen asentoreseptorien muuttuminen • sisäkorvan tasapainoelimen heikkeneminen	Huonekalut • matalat tai huterat tuolit • käsi- ja selkänojattomat tuolit • vuoteen väärä korkeus • pyörälliset vuoteet • huterat pöydät • liukkaat pöydänreunat • korkeat kaapit tai hyllyt
Lihassoiman heikkeneminen • fyysisen aktiivisuuden väheneminen • heikko ravitsemustila • hormonaaliset muutokset	Jalkineet • liukkaat tai paksut kengän pohjat • sopimattomat tai liian suuret jalkineet • korkeakorkoiset kengät • avonaiset kantaosat
Nestevajaus ja aliravitsemus • janon tunteen heikkeneminen • ruokahaluttomuus	Kylpyhuone ja WC • liukas lattia • tukikahvojen puuttuminen • WC-istuimen väärä korkeus • tilanpuute
Pitkäaikaissairaudet • halvaus • inkontinenssi • mielenterveyden häiriöt • neurologiset sairaudet • diabetes • nivelrikko • infektio • muistisairaudet	Portaat • kapeat tai huonosti erottuvat askelmat • askelmien liukkaus • tukikaiteiden puuttuminen
Huimaus • asentohuimaus • tulehdustaudit • rytmihäiriöt • unihäiriöt • anemia • aivoverenkierron häiriöt	Valaistus • heikko valaistus • yövalojen puute • valaistuksen voimakkuuden äkillinen muutos
Lääkkeet • lääkkeiden yhteisvaikutus • väsyttävä vaikutus • verenpainetta alentava vaikutus • nesteenpoistovaikutus	Apuvälineet • väärin mitoitettu apuväline • kävelykepin kulunut kumitulppa tai jääpiikki • pyörätuolin tai rollaattorin viallinen lukitusmekanismi • kaksiteholasit
Alkoholi • yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa	Vuorokaudenaika • yöllä klo 23–07 eniten kaatumistapaturmia • nukahtamislääkkeet altistavat



Potilasturvallisuutta lisääviä työkaluja ovat muun muassa

- potilaan tunnistaminen organisaatiossa sovittujen yhteisten käytäntöjen mukaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikilta potilailta, jotka kykenevät vastaamaan, on kysyttävä: ”Mikä on teidän nimenne ja syntymäaikaanne?”
- tiimien tilanapäivitys, jolloin kokoonnutaan yhteen ennen tiettyä työvaihetta ja suunnitellaan työvaiheen toteuttaminen kriittisine vaiheineen ja riskeineen
- systemaattinen, strukturoitu suullinen raportointi, jolloin potilaasta raportoitessa tai konsultoitessa tieto välitetään aina systemaattisesti saman kaavan mukaan
- tarkistuslistat, jotka sisältävät toimintoja tai kriteerejä, joiden toteuttaminen tarkistetaan systemaattisesti joka kerta samalla tavalla
- kuittauskäytäntö eli kaksisuuntainen viestintä, jolloin vastaanottaja kuittaa saamansa tiedon sen lähettäjälle. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi suulliset tutkimus- ja hoito-ohjeet.

Inhimillisiä virheitä ei pystytty koskaan kokonaan välttämään, mutta jos tilanne havaitaan ajoissa, selvittää läheltä piti -tapahtumalla eikä varsinaista haittatapahtumaa synny. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi on kehitetty työkaluja. Niistä käytetään myös käsitettä suojaus (ks. kuva 16.1). Ammattitaitoinen henkilökunta ottaa ulkoisen turvallisuuden parantamisen huomioon kaikissa hoitotilanteissa.

Potilasturvallisuutta vaarantavat myös muun muassa tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset. Suomessa on käytössä ISBAR-menetelmä, joka on sovellettu terveydenhuoltoon sopivaksi. ISBAR-menetelmä on apuväline yhdenmukaiseen ja selkeään tiedonvälitykseen. ISBAR koostuu sanoista I = identify- potilaan tiedot, S = situation- tilanteen tiedot, B = background- potilaan taustatiedot, A = assessment- arvio nykytilanteesta,

R = recommendation- suositus. Menetelmä mahdollistaa yhdenmukaisen kommunikaation terveydenhuollossa.

ISBAR – kiireetön tilanne

1. IDENTIFY Tunnista	• Nimesi, ammatti, yksikkö • Potilaan nimi, ikä ja sosiaaliturvatunnus
2. SITUATION Tilanne	• Syy raportointiin
3. BACKGROUND Tausta	• Nykyiset sekä aikaisemmat oleelliset sairaudet, hoidot ja ongelmat • Allergiat • Tartuntavaara/eristys
4. ASSESSMENT Nykytilanne	• Vitaalielintoiminnot • Oleelliset asiat potilaan tilaan liittyen
5. RECOMMENDATION Toimintaehdotus	Ehdota • Tarkkailun lisäämistä • Toimenpidettä • Siirtoa toiseen yksikköön • Hoitosuunnitelman muutos Varmista • Kuinka kauan...? • Kuinka usein...? • Koska otan uudelleen yhteyttä...? • Onko vielä kysyttävää? • Olemmeko samaa mieltä?

ISBAR – kiireellinen tilanne

1. IDENTIFY Tunnista	• Nimesi, ammatti, yksikkö • Potilaan nimi, ikä ja sosiaaliturvatunnus
2. SITUATION Tilanne	• Syy raportointiin
3. BACKGROUND Tausta	• Lyhyesti nykyiset sekä aikaisemmat oleelliset sairaudet, hoidot ja ongelmat • Allergiat • Tartuntavaara/eristys
4. ASSESSMENT Nykytilanne	Raportoi • Vitaalielintoiminnot - A Ilmatie - B Hengitys, saturaatio - C Pulssi, verenpaine - D Tajunnan taso (GCS), kipu - E Lämpötila, iho, väri, vatsa, virtsaneritys, ulkoiset, näkyvät merkit • Oleelliset asiat potilaan tilaan liittyen
5. RECOMMENDATION Toimintaehdotus	Ehdota • Välitöntä toimenpidettä • Tarkkailun lisäämistä • Toimenpidettä • Siirtoa toiseen yksikköön Varmista • Kuinka kauan...? • Kuinka usein...? • Koska otan uudelleen yhteyttä...? • Onko vielä kysyttävää? • Olemmeko samaa mieltä?

Kuva 16.2. ISBAR-kortit: kiireettömän ja kiireellisen tilanteen raportointi. © Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

➔ Tutustu aiheeseen liittyviin väitöskirjoihin

Jylhä, V. 2017. Information management in health care: a model for connecting information culture and patient safety. Tiedonhallinta terveydenhuollossa: Malli tietokulttuurin ja potilasturvallisuuden yhteydestä. Itä-Suomen yliopisto.

Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä tiedonhallinnassa potilasturvallisuuden näkökulmasta. Eri-tyisesti potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi ja liitit toiminnolla tai käsin on riskialtista. Puutteellinen kirjaaminen lisää myös tiedon häviämistä potilassiirtojen yhteydessä. Tutkimuksessa käytetyn rekisteriaineiston perusteella tiedon siirto vaikuttaakin olevan virhealttein vaihe tiedonhallinnassa.

Kanerva, A. 2015. "Minusta potilasturvallisuus on potilaan oikeus ja meidän velvollisuus". Potilasturvallisuuden kehittäminen systeeminäkökulmasta psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköissä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen tuloksista voidaan nostaa esiin neljä keskeistä potilasturvallisuuden kehittämisessä huomioitavaa tekijää. Ensinnäkin terveydenhuollon johtajien toiminta vaikuttaa merkittävästi potilasturvallisuuden kehittämiseen. Toiseksi ymmärrystä potilasturvallisuudesta on tärkeä kehittää koko organisaatiota ja eri ammattiryhmiä koskevana asiana. Kolmas tärkeä asia on kiinnittää huomiota aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen niin moniammatillisen henkilökunnan kuin eri yksiköiden välillä. Neljäs huomioitava tekijä on turvallisuuskriittisen organisaation näkökulman hyödyntäminen terveydenhuollon organisaation potilasturvallisuuden kehittämisessä.

Kuronen, M. 2017. Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross sectional study in home care and residential care. Iäkkäiden muistipotilaiden käytösoireet, psyykenlääkkeet sekä fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen mukaan hoitolaitoksissa käytetään runsaasti psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita iäkkäille muistihäiriöpotilaille. Hoitoympäristö voi olla merkittävä käytösoireiden syntyyn vaikuttava tekijä. Lisätutkimusta niin sanottujen lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä tarvitaan psyykenlääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käytön vähentämiseksi. Hoitohenkilökuntaa ja omaisia tulisi kouluttaa yksilöllisten lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöön.

Tella, S. 2015. Learning about patient safety in pre-registration nursing education: comparing Finnish and British nursing students' evaluations. Potilasturvallisuuden oppiminen hoitotyön koulutuksessa – suomalaisten ja englantilaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioiden vertailua. Itä-Suomen yliopisto.

Sairaanhoitajaopiskelijat sekä Suomessa että Isossa-Britanniassa kokevat, ettei potilasturvallisuus saa opetuksessa tarkeyttään vastaavaa painoarvoa. Esimerkiksi itsenäiseen virheistä raportointiin ja niistä oppimiseen tarjotaan niukasti mahdollisuuksia käytännön harjoittelussa. Potilasturvallisuutta tulisi opettaa omana aiheenaan, mutta potilasturvallisuuden opit on tärkeää integroida myös osaksi koko opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi selkeä kommunikointi, tehokas tiimityö, vaaratapahtumien tunnistaminen, raportointi ja analysointi sekä niistä oppiminen ovat keskeisiä potilasturvallisuuden varmistamisessa, ja niiden tulisi kuulua hoitotyön opiskelijoiden eri opintojaksoihin.

➔ Tutustu ikääntyvien naisten kaatumiseen liittyviin riskitekijöihin:

Keskin, D., Borman, P., Ersöz, M., Kurtaran, A., Bodur, H. & Akyüz, M. 2008. The risk factors related to falling in elderly females. Geriatr Nurs 29 (1), 58–63. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. Saatavissa osoitteesta <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18267178>

Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi: www.hotus.fi

Luvun kertaustehtävät



17

Ihmisen voimavarojen tukeminen

Tässä luvussa

- Ihmisen heikentyneet voimavarat
- Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan
- Potilaan voimavarojen tukeminen: Elinympäristö, eläimet ja muistot
- Potilaan selviytymisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen: Kommunikaatio, läheisyys ja potilaan kohtaaminen



Kaikki me tiedämme, että elämä ei aina suju suunnitelmien mukaan. Pyrimme kuitenkin aina säilyttämään oman elämämme hallinnan. Silloin, kun joudumme kohtaamaan epäonnistumisia, menetyksiä ja ongelmia, pyrimme psyykkisten itsesäätelykeinojen avulla palauttamaan hyvinolontuntemme. Meillä jokaisella on omat itsesäätelykeinomme, joita käytämme toistuvasti. Psyykkisen itsesäätelyn yhteydessä puhutaan sekä puolustuskeinoista että hallintakeinoista.

Psyykkiseen itsesäätelyyn kuuluvat tunteet, itsensä tarkkailu ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyy tunteiden tasapaino, joka on mielihyvän ja ahdistuksen kohtuullista tasapainoa. Ihminen voi hallita tunteitaan, kun hän kykenee kanavoimaan tunteensa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ja sietää tunteiden aiheuttamat reaktiot itsessään. Omalla päättelykyvyllämme voimme hallita tunteitamme kognitiivisella tasolla.

Hyvinvointiamme uhkaavat tekijät, kuten ihmissuhteiden tai elämäntilanteen muutokset, menetykset ja sairastuminen, koetaan yksilöllisesti. Se, millä tavalla ihminen kokee muutokset elämässään, riippuu hänen sisäisistä voimavaroistaan. Joskus ihmisen omat selviytymiskeinot eivät riitä, ja tällöin hoitajan tehtävänä on auttaa häntä selviytymään tilanteesta esimerkiksi keskustelemalla.

Selviytymisellä tarkoitetaan yksilön jatkuvaa, muuttuvaa tiedollista ja toiminnallista valmiutta sekä sellaisten ulkoisten ja sisäisten vaatimusten hallintaa, joiden arvioidaan kuluttavan hänen voimavarojaan tai ylittävän ne. Selviytyminen on yhteydessä yksilön biologisiin tekijöihin, luovuuteen, motivoituneisuuteen ja mielekkyyden kokemiseen sekä kognitiivisiin ja toiminnallisiin kykyihin.

Hoitotyössä potilaan selviytyminen tarkoittaa hänen kykyään selviytyä terveyteen liittyvistä jokapäiväisistä tilanteista joko tarjotun avun turvin tai itsenäisesti. Selviytyminen on tiedollinen prosessi, joka perustuu potilaan arvioon omasta tilanteestaan ja henkilökohtaisista resursseistaan, joiden avulla hän yrittää hallita stressiä. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka auttavat potilasta vahvistamaan voimavarojaan ja saavuttamaan sisäisen eheyden ja elämänhallinnan.

17.1 Ihmisen heikentyneet voimavarat

Ihmisen selviytymiskyky voi olla heikentynyt oppimisvaikeuksien tai muistihäiriön vuoksi, tai hänen päätöksentekokykynsä, aloitekykynsä tai keskittymiskykynsä voi olla heikentynyt esimerkiksi sairauden vuoksi. Jotta potilas ja hänen perheensä kykenisivät käsittelemään ongelmiaan tai sopeutumaan niihin sekä hoitamaan velvollisuutensa ja tehtävänsä, he saattavat tarvita fyysistä tai psyykkistä tukea. Monet tekijät vaikuttavat uuden oppimisen kykyyn ja muistin toimintaan. Esimerkiksi stressi, uupumus, masennus, runsas alkoholin käyttö ja eräät sairaudet voivat heikentää oppimiskykyä ja muistia. Esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsivät suoriutuvat normaalia heikommin vaativista tehtävistä ja muistitehtävistä, ja heillä on vaikeuksia keskittyä.

Muistihäiriö on varsin yleinen oire, ja kaikki ihmiset unohtelevat joskus asioita. Muistihäiriöiden syynä voi myös olla aivoverenkierron paikallinen vaurio, jolloin häiriö vaikuttaa oppimiseen, muistissa pitämiseen ja mieleen palauttamiseen.

Masennus ja työuupumus ovat tavallisimpia syitä esimerkiksi työikäisen muistivaikeuksiin, ja jos potilaalla on lisäksi esimerkiksi juuri todettu vakava sairaus, muistivaikeus voi muuttua entistä vaikeammaksi. **Oppimisvaikeudet**, kuten luki- ja kirjoitushäiriöt, voivat myös vaikeuttaa potilaan selviytymistä esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa. Hoitajan tulee huomioida potilaan oppimisen muutokset, ja hänen on tarjottava tälle asianmukaista tukea. Jos oppimisvaikeudet jäävät tunnistamatta eikä potilas saa tukea ongelmissaan, ne voivat johtaa mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen.

Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan

Ihmisen minäkuva voidaan määritellä monin eri käsittein, joiden merkitys vaihtelee ja jotka osin ovat päällekkäisiä: minäkuva, identiteetti, persoonallisuus, minä itse ja minuus. Sairaus voi muuttaa minäkuvaan varsinkin silloin, kun se rajoittaa ihmi-

sen toimintaa ja kun hänen mahdollisuutensa itsenäiseen elämään vähenevät.

Esimerkiksi potilaille, jotka ovat saaneet aivohalvauksen, sairastuminen aiheuttaa kehonkuvan muutoksia, kontrollin menettämisen tunteita ja erilaisia pelkoja. **Kehonkuvan muutokset** voivat olla potilaille niin vaikeasti kohdattavia, että heidän kykynsä vastaanottaa ja ymmärtää informaatiota on rajoittunut. Potilaiden avuntarve on moninainen. Etenkin intiimeissä asioissa avun pyytäminen koetaan vaikeammaksi kuin esimerkiksi avun tarvitseminen liikkumisessa, koska intiimeihin toimintoihin liittyy arvokkuuden ja kunnian tunteita. Riippuvuus auttajista aikaansaa helposti **itsenäisyyden menettämisen** tunteen.

Myös erilaiset leikkaukset ja elinten poistot ovat uhka kehon eheydelle ja tuttuudelle, ja syöpätauteihin liittyvien hoitojen ja taudin aiheuttamat muutokset kehossa voivat muuttaa kehonkuvaa. Kiinteästi sukupuolisuuteen liittyvät sairaudet ja sairauksien hoitoon liittyvät toimenpiteet vaikuttavat **seksuaalisuuteen, miehisyyteen ja naisuteen**. Minäkuvaan vaikuttavat myös hiusten ja ihokarvojen lähtö, lihominen, laihtuminen, kalpeus, muut sairauden aiheuttamat näkyvät merkit ja kehon toiminnalliset muutokset. Hoitotyössä hoitajan tulee tukea potilasta niin, että tämä säilyttää omanarvontunteensa, vaikka kehonkuvassa tapahtuisi muutoksia.

Kehon muutosten kokeminen on **yksilöllistä**, ja siihen vaikuttaa myös oma aikaisempi kehonkuva. Joku tuntee haikeutta ja surua jonkin aikaa mutta kykenee sitten eheytymään melko nopeasti. Useimmilla kehonkuvan muodostuminen vie jonkin aikaa, ja osalla siitä tulee pysyvä ongelma. Avoin puhuminen tunteista läheisten ihmisten kanssa on tärkeää.

Aina ihminen ei kuitenkaan halua puhua tunteistaan kenenkään kanssa. Syynä voi olla se, ettei hän halua kuormittaa ketään. Tämä lisää ihmisen sisäistä jännitystä, levottomuutta tai jopa paniikkia. Tällaista tilannetta kutsutaan **ahdistuneisuudeksi**. Se eroaa pelosta siinä, että pelon kohde on jokin todellinen ulkoinen vaara. Ahdistuksen kohdetta on vaikea määrittää, ja juuri ahdistuksen epä-määräisyys on tuskallista.

Vähänkin voimakkaampi ahdistuneisuus aktivoi elimistön sympaattisen hermoston, minkä vuoksi ahdistuneisuuteen liittyy usein erilaisia somaattisia oireita, kuten sydämentykytystä, verenpaineen kohoamista, suun kuivumista, hengenahdistusta, hikoilua, ruokahaluttomuutta, palan tunnetta kurkussa, vapinaa, huimausta ja silmäterien laajenemista. Kyky tuntea pelkoa ja ahdistuneisuutta on terve ominaisuus, koska se varoittaa ihmistä uhkaavasta tilanteesta.

Muun muassa iäkkäillä ahdistuneisuuden taustalla ovat usein yksinäisyys, tarkoituksettomuus ja kuoleman pelko. **Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö** on kyseessä, jos ahdistus on pitkäaikaista ja jatkuva. Jokainen on ahdistunut joskus, mutta pitkään jatkuessaan ahdistuneisuus saattaa heikentää ihmisen toiminta- tai vuorovaikutuskykyä.

17.2 Potilaan voimavarojen tukeminen

Jokainen joutuu joskus ahdistuksen valtaan tai pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Ihmissuhteet eivät aina toimi kitkattomasti, ja jokainen joutuu kokemaan luopumista, pettymyksiä ja pahaa oloa. Paha olo voi ilmetä masennuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsetuhoisuutena. Apua tilanteeseen on haettava silloin, kun paha olo alkaa rajoittaa tai heikentää toimintakykyä ja ahdistavat ajatukset ja tunteet alkavat vaatia niin paljon huomiota, että työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Ihmisillä on taipumus pysytellä tutuissa ihmissuhteissa ja entisissä elämäntavoissa syvästä tuskastaan välittämättä, sillä tuttu tuntuu kaikesta huolimatta ainakin jollain tavalla myös turvalliselta.

Potilaan auttamisen lähtökohtana voi olla potilaan kyvyttömyys selvittää esimerkiksi perustarpeidensa tyydyttämisestä, kuten ruokailusta tai puhtaudesta huolehtimisesta. Hoitotyössä kohdataan potilaita, jotka ovat aggressiivisia, ahdistuneita, toivottomia, yksinäisiä, kaavamaisia ja eristäytyneitä ja jotka kärsivät syyllisyydestä, ikävästä, epäluottamuksesta, riippuvuussuhteista ja menetyksistä. Hoitotyön tehtävänä on auttaa potilasta tie-

dostamaan omaa käyttäytymistään ja löytämään siihen uusia rakentavia ratkaisuja.

Ihmiselle ja hänen ympäristölleen kärsimystä aiheuttavaan **käyttösoireeseen** pitää puuttua pian. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi kotona asuvan muistisairaana siirtymistä ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon. Nopea puuttuminen ja tilanteen vähäisenkin lievittyminen ovat tärkeitä potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan jaksamisen kannalta. Jokainen työntekijä on velvollinen käynnistämään käyttösoireiden selvittelyn, joka tähtää tilanteen monipuoliseen ymmärtämiseen ja mahdollisimman oikeiden tuki- ja auttamiskeinojen löytymiseen. Käyttösoireen esiintymistä voidaan ehkäistä hyvällä lääketieteellisellä hoidolla, fyysisellä perushoidolla, liikkumisella, toiminnallisuuden tukemisella ja turvallisilla ja arvostavilla ihmisuhteilla sekä elämäntilannetta tukevalla elinympäristöllä. (Elämäntilannetta tukeva elinympäristö voi toteutua esimerkiksi palvelutalossa).

Potilaan kokonaisvaltaisen auttamisen ja voimavarojen aktivoimisen kannalta on merkityksellistä, että **omaiset** saadaan ja hyväksytään mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä edellyttää potilaan hoidosta vastaavilta usein uudenlaista suhtautumista omaisiin. **Voimavarakeskeinen ajattelu** tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Omaisten voimavaroja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi niin, että heiltä kysytään neuvoa sen sijaan että heille annetaan neuvoja. Jos omaiset eivät osaa neuvoa, he valitsevat tai hyväksyvät ratkaisuideoita. Tärkeintä on omaisten pitäminen ajan tasalla. Omaisille annetaan tunnustusta onnistumisen yhteydessä.

Omahoitajakeskusteluissa mietitään yhdessä vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Hoitajan pyrkimys on auttaa potilasta tukemalla tämän kykyä huolehtia itsestään. Hoitaja hyödyntää työryhmää ja keskustelee muiden hoitajien kanssa hoitosuhteen luonteesta. **Perhekeskeisellä työskentelyotteella** keskitytään jokapäiväisten ongelmien ratkaisuun. Tavoitteena on sekä potilaan että perheen näkökulmasta katsottuna mahdollisimman itsenäisen selviytyminen. Hoitohenkilökunta auttaa perhettä dialogisessa keskustelussa, jossa puhe ja kuuntelu vuorottelevat. Perhetapaamisissa voi tulla

esille voimakkaita tunnereaktioita, ja niillekin tulee antaa tilaa riittävästi. Työntekijöiden suhtautumisen tulee olla perhettä kunnioittavaa, arvostavaa ja empaattista.

Keskustelujen avulla hoitaja saa ymmärrystä potilaan kulloisestakin tilanteesta ja todellisuudesta. Hän pyrkii keskittämään vuorovaikutuksen **nykyhetkeen**. Tämä auttaa ja ehkä ohjaa potilasta kommunikoimaan muiden ihmisten, esimerkiksi läheistensä kanssa. Toivo merkitsee yhteisen ymmärryksen ja yhdessä hyväksytyjen päämäärien löytymistä dialogin avulla. Keskustelussa aitous ja rehellisyys auttavat potilasta löytämään omat voimavaransa.

Hoitajan ja potilaan välisessä hoitosuhteessa etsitään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla potilas voi löytää elämäntilanteessaan omista lähtökohdistaan mahdollisuuden selviytyä. Empowerment-käsitettä käytetään kuvaamaan voimavarakeskeistä ajattelutapaa, jossa ihminen ottaa vastuuta omasta tilastaan. Se mahdollistaa omaan elämään vaikuttavien tekijöiden hallinnan ja oman itsensä hoitamiseen sitoutumisen, minkä avulla ihminen saa **kokemuksen selviytymisestä** vaikeassakin elämäntilanteessa. Tutulle hoitajalle tunteiden esiin tuominen on merkki siitä, että hoitosuhde on hyvä. Kipeitä asioita voidaan käsitellä ja niiden tarkastelussa päästään eteenpäin, mutta keskustelut etenevät potilaan ehdoilla.

Saadessaan **vaikuttaa** oman terveytensä ja sairautensa hoitamiseen ihmiset kiinnostuvat enemmän ylläpitämään terveyttään. Tunteiden ilmaiseminen ja terveys liittyvät toisiinsa. Kielteiset tunteet suurentavat sairastumisen riskiä, kun taas myönteisiä tunteita pidetään terveyttä edistävinä ja taudeista parantavina. Tunteiden säätelyyn vaikuttavat kulttuuritekijät, sosiaalinen tilanne ja tunteiden ilmaisun oppiminen. Erilaiset tutkimukset ja arkikokemuksin osoittavat, etteivät ihmiset aina kykene jakamaan tunteitaan. He kuitenkin tietävät, että tunteista puhuminen henkilöille, joita he pitävät luottamuksensa arvoisina, helpottaa oloa.

Potilaan selviytymisessä keskeisiä ovat hänen voimavaransa, joita hoitotyössä tuetaan. Tunnistaessaan potilaansa voimavaroja hoitaja pyrkii vahvistamaan niitä ja siten edistämään potilaan



Ympäristön voimavaroja ovat

- erilaisten palveluiden läheisyys ja saatavuus asuinympäristössä
- kodin varustus ja tilat
- potilaan ja perheen varallisuus.

Sosiaalisia voimavaroja ovat ihmissuhteiden kautta saatava tuki, joka voi olla

- konkreettista
- emotionaalista
- tiedollista.

Yksilön omia voimavaroja ovat

- terveydentila, ikä ja yleiskunto
- kognitiiviset taidot, esimerkiksi muisti, ajattelu, oppimiskyky, itsearvostus, tunte säätelyn taito sekä
- hengellinen vakaumus tai maailmankatso-mus.

terveyttä. Potilaan **sisäisiä voimavaroja** ovat usko avun saamiseen, positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen, motivoituneisuus, aktiivinen itsensä hoitaminen, pyrkimys arjen normaaliuteen, yhteisen hyvinvoinnin vahvistuminen ja yhteinen luottamus hoidon hyvytyteen.

Hoitajalta edellytetään, että hän osaa tukea ja aktivoida yksilöä, perhettä ja yhteisöä terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Ihmisen voimavarat voidaan jakaa **ympäristön** ja yksilön voimavaroihin sekä **sosiaalisiin voimavaroihin**.

Terveyden heikentyessä ihmisen voimavaratkin vähenevät. Ihminen altistuu koko elämänsä ajan erilaisille kuormittaville tekijöille, joiden kohtaamiseen hän käyttää voimavarojaan. Voimavaroja vähentävät monet biologis-fysiologiset ongelmat, kuten kipu, pahoinvointi, hengitysvaikeudet, verenkierron häiriöt ja levon puute. Näiden vaivojen poistaminen tai lievittyminen taas lisää voimavaroja. Kognitiivisesta näkökulmasta tietämättömyys pienentää potilaan voimavaroja ja rajoittaa toimintavaihtoehtoja.

Ihmisen toimintakyky on selviytymistä niin arjen askareista kuin elämän suurista haasteista. Toimintakykyä on siten hankala määritellä tai mitata yksiselitteisesti ja kattavasti. Toimintakyky voidaan määritellä esimerkiksi kyvyksi tai mahdollisuudeksi selviytyä kulloisessakin elämäntilanteesta ja -vaiheessa jokapäiväisen elämän haasteista: itsestä huolehtimisesta, työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista. Toimintakyky on myös selviytymistä omalle elämälle asetetuista tavoitteista ja toiveista: lapsena leikitä, työikäisenä työstä ja vanhuusiässä mahdollisimman itsenäisestä elämästä. Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilaksi kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä. Todellisuudessa toimintakyky on **fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen suorituskyvyn summa**. Siitä aletaan puhua usein vasta silloin, kun se on heikentynyt. Silloin kun potilaan toimintakykyä selvitetään, on tärkeää huomioida potilaan sosiaalinen selviytyminen sekä toimintakyky työssä ja arkipäivän eri tilanteissa. Hoitotyön kohteena on aina potilas, ei häiriö tai sen yksittäinen oire.

Käytännössä toimintakykyä tarkastellaan ihmisen fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina edellytyksinä selviytyä päivittäisistä askareista. Toisaalta toimintakyky ei ole ainoastaan yksilön mahdollisuus suoriutua jostakin toiminnasta vaan olennais-ta on se, miten tärkeäksi hän kokee suoriutumisen-sa. Usein toimintakyvyn heikkenemisen taustalla on jaksamattomuus tai motivoitumattomuus eikä fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen.

Lihassoima alkaa heiketä noin 50. ikävuoden jälkeen suunnilleen yhden prosentin vuosivauhtia, mutta vasta noin 80 vuoden iässä heikkenemä on niin suuri, että siitä on haittaa toimintakyvylle. Osa heikkenemisestä johtuu sairauksista ja niihin liittyvistä tulehdusprosesseista ja ravitsemus-tilan häiriöistä, kuten anemiasta, ja oireiden aiheuttamasta fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä. Osa heikkenemisestä johtuu muissa elinjär-jestelmässä tapahtuvista muutoksista, kuten hormo-naalisista muutoksista. Myös hermolihasarj-estelmässä itsessään tapahtuvat vanhenemismuutok-set alentavat lihasvoimaa.

Toivo on tärkeä selviytymiskeino. Ihmisen elä-mässä toivo on keskeinen tekijä. Toivon merkitys

korostuu, kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hänen omat voimavaransa ovat vähäiset ja jossa hän itse voi vaikuttaa omaan tilanteeseensa hyvin vähän. Sairastuessaan ihminen toivoo selviytyvänsä ja parantuvansa sairaudestaan. Erityisesti toivoa tarvitaan sairauteen liittyvän kärsimyksen ja epä-mukavuuden sietämisessä. Toivon puuttuminen, toivottomuus ja masennus voivat vaikuttaa kielteisesti sairauteen, kun taas toivon ja elämänhalun säilyttäminen auttavat sairauden voittamisessa, pidentävät elinikää ja parantavat samalla elä-misen laatua. Tunneperäiset tekijät, kuten toivo, elä-mänhalu ja taistelutahto, voivat vaikuttaa sairau-teen elimistön vastustuskyvyn ja immunologisten mekanismien kautta.

Lisäksi **tiedollinen tuki** on tärkeää, ja hoito-henkilökunnan rehelliset vastaukset lisäävät luot-tamusta hoitoihin ja hoitohenkilökuntaan. Toiveet voinnin pysymisestä ennallaan tai paranemisesta ovat osa toivon tunnetta. Esimerkiksi lasten ja las-tenlasten elämän seuraaminen on toivoa tuovaa. Tukea voi saada myös ennen sairastumista raken-tuneelta tukiverkostolta: suvulta, työtovereilta ja ystäviltä. Sairasta perheenjäsentään kotona hoita-vat perheet kokevat tehtävänsä raskaaksi, ja tutki-musten mukaan potilaan läheisillä ilmenee masen-nusta ja ahdistusta. He tuntevat olevansa voimat-tomia, ja heillä on vähän mahdollisuuksia hallita olosuhteita. Voimattomuuden kokemus vaikuttaa **läheisen omaan** fyysiseen ja psyykkiseen **tervey-teen**. Läheisten tunne siitä, etteivät he selviydy po-tilaan tilan muutoksesta ja toimintakyvyn mene-tyksestä, aiheuttaa masennusta. Läheiset tarvitse-vat tietoa perheenjäsenensä sairaudesta, sen vaiku-tuksista toimintakykyyn ja ennusteesta.

Henkisen tuen tarve korostuu ihmisen sairas-tuessa tai vammautuessa. Sairastuttuaan ihminen tarvitsee lähelleen toisen ihmisen, jolle voi puhua ja jakaa tuntemuksiaan ja pelkojaan. Sairastunut tar-vitsee myös tietoa sairauden etenemisestä, tutki-muksista, hoidosta ja paranemiseen vaikuttavista tekijöistä. Monelle potilaalle tuo helpotusta saada puhua sairaudestaan myös toistamiseen. Puhumi-nen samassa tilanteessa olevien kanssa helpottaa. **Vertaistuella** tarkoitetaan toimintaa, jossa saman-kaltaisissa ongelmallisissa elämäntilanteessa ole-

vat ihmiset keskustelevat heitä koskevista asiois-ta ja jakavat kokemuksiaan. Jokainen voi tulla ryh-mään omana itsenään ja tuoda siihen niitä asioita, joita katsoo voivansa kulloinkin jakaa. Ryhmässä arvostetaan toisia tasavertaisina ihmisinä, ja jokai-sen elämäkokemukset ovat merkityksellisiä. Ver-taisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan kunnioituk-seen. Kaikkia ryhmään osallistujia koskee vaiti-olovelvollisuus.

Noin kaksi kolmasosaa ihmisistä selviytyy useimpien äkillisten järkyttävien kokemusten jäl-keen omin voimin ja läheistensä tuella ilman ulko-puolista asiantuntija-apua. Ihmiset kokevat erilai-sia järkytyksiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilan-teissa. Selviytymisen polut ja keinot ovat myös yk-silöllisiä, ja enemmistö ihmisistä löytää oman pol-kunsa, joka ei johda häiriöön ja kärsimykseen vaan toipumiseen. Hyvin suuri joukko ihmisiä kuitenkin tarvitsee tukea ja apua. Hoitajan tehtävä on havain-noida potilaan tilaa ja olla läsnä.

 www.toimeksi.fi/fi/tietolaari/toiminnanjarjestajat/yhdistykset/potilasyhdistykset/

Sairastuessaan ihminen saattaa pohtia, olisiko hän voinut välttää sairastumisen, jos hän olisi elänyt toisella tavalla. Mitä olisi tapahtunut, jos hän oli-si syönyt terveellisemmin, liikkunut enemmän tai hakeutunut tutkimuksiin aikaisemmin? Ihminen myös etsii syytä tai syyllisiä tapahtuneeseen. Usein syytä kysytään myös hoitajalta ja lääkäriltä. Vas-tauksien tarjoamisessa ei tule kiirehtiä. Kuunnel-lessaan potilasta hoitaja tarvitsee lämpöä ja herk-kyttä sekä kykyä myötätuntoon. Toimimalla näin hän tekee tilaa potilaalle ja omaisille, jotta he voivat itse löytää vastauksia myös syyllisyyskysymyksiin. **Syyllisyys** liittyy ihmissuhteisiin ja jumalasuhtee-seen. Jos syyllisyyttä ei käsitellä, se saattaa johtaa ahdistukseen ja masennukseen. Terveessä syylli-syydessä ihminen tietää väärän tekonsa tai laimin-lyöntinsä, joka painaa mieltä. Anteeksisaaminen merkitsee toivoa ja tulevaisuutta. Sairaus voi puh-jeta hyvin eletystä elämästä huolimatta ja nostaa esiin vihan tunteita. Sairaudet kuuluvat elämään, mutta kun ne sattuvat omalle kohdalle, ihminen

voi kokea voimattomuutta ja lamaanusta, koska hän ei ole voinut estää sairautta. Kun ihminen kokee syyllisyyttä siitä, että hän on loukannut toista tai tuhonnut omaa elämäänsä, hän osoittaa vastuullisuutta itsestä ja lähimmäisistä. Jotkut ihmiset eivät koe syyllisyyttä eivätkä kykene kokemaan empatiaa. Myös hoitaja voi tuntea itsensä avuttomaksi potilaan kokemuksen ja reaktioiden edessä. Hoitajakin saattaa ahdistua, eikä hän ehkä kykene kuulemaan ja vastaanottamaan voimakkaita tunnepurkauksia, kuten syyttelyä väärästä hoito-toimenpiteestä tai huonosta hoidosta.

Suru ilmenee, kun ihminen saa tietää sairastavansa vaikeaa, parantumatonta sairautta. Elämään tulee tällöin jotakin peruuttamatonta ja ennakoivan surun aika alkaa. Suru valmistaa ihmistä kohtaamaan edessä olevan muutoksen. Elämän tapahtumia seurataan ikään kuin jatkumolla, joka kuvaa, mitä tapahtui ennen sairastumista ja elämänmuutosta ja mitä niiden jälkeen. Elämänarvot saattavat muuttua, kun tärkeät ja elämää ylläpitävät asiat tulevat entistä tärkeämmiksi ja toisarvoiset asiat jäävät pois. Samalla ihmissuhteet saattavat muuttua. Tilanne on uusi perheelle ja läheisille. Heillä ei ole välttämättä valmiuksia kohdata sairautta, ja sairauden myötä muuttunut arki voi olla heille järkytys.

Elisabeth Kübler-Ross luokittelee surun viiteen vaiheeseen: kieltämiseen, vihaan, kaupan-käyntiin, masennukseen ja hyväksymiseen. Vaiheet menevät sisäkkäin ja limittäin ja toistuvat uudelleen. Vaiheet ilmentävät sitä, että suru ilmenee hyvin eri tavoin ja siinä tulee esiin tunteiden kirjo. Kieltäminen kipeän tosiasian edessä on suo-jautumista. Ihminen epäilee tietoa ja kiistää sen. Tuntiessaan vihaa hän saattaa kohdistaa sen hoito-henkilökuntaan. Hän kyselee ja etsii vastausta, miksi juuri hänelle tapahtui niin kuin tapahtui. Sairauteen, kärsimykseen ja voimien vähenemiseen on vaikea suostua. Kaupankäynti taas on ihmisen yritystä saada lisää aikaa ja lykätä sitä, mikä uhkaa hänen terveyttään. Hän saattaa tehdä lupauksia, joilla yrittää lepyttää kohtaloaan, Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa. Lupausten taustalla voi olla syyllisyyttä, josta tulisi päästä puhumaan. Peruuttamattomat muutokset ja niiden kohtaaminen johtavat masennukseen, joka voi sisältää toi-

veen kuolemasta, myös itsemurhasta. Sen myötä mielenkiinto läheisiä ja elämää kohtaan vähenee: sairastunut kokee luopumista ja suurta väsymystä. Masennuksen aika kuitenkin valmistaa sairauden mukanaan tuomien lopullisten muutosten ja rajoitusten hyväksymiseen.

Kuoleman pelko saa ihmisessä aikaan monia kysymyksiä, ahdistusta ja pelkoa. Näitä tunteita aiheuttaa tietämättömyys tulevasta ja siitä, millainen kuolema tulee olemaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Kun tieto väistämättömästä kuolemasta tulee, ihminen tarvitsee aikaa sen hyväksymiseen. Ihminen voi oireilla somaattisesti, ja joskus oireita ei osata liittää kuolemanpelkoon. Hoitohenkilökunnan on tartuttava potilaan hätään ja keskusteltava siitä, mikä häntä ahdistaa ja pelottaa. Potilaan pelkoja voivat olla turvattomuus, tuntemattoman pelko, elämättömän elämän pelko, yksinäisyyden pelko, menetyksen pelko, kivun pelko, lisääntyvän avuttomuuden aiheuttama pelko, kuolinhetken pelko ja pelko siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kun potilas voi keskustella mieltään painavista asioista, hän uskaltaa hyväksyä tilanteensa paremmin ja saa mielenrauhan. Jokaisella on oikeus kuolla levollisena ja tuntea olonsa turvallisiksi kuoleman hetkellä. Olemalla läsnä hoitaja voi tuoda turvaa niin potilaalle kuin omaisillekin.

Hengellisten tarpeiden kohtaaminen hoitotyössä voidaan kokea yksityiseksi ja hyvin intiimiksi asiaksi, johon ei rohjeta kajota. Hengellisten tarpeiden tunnistaminen on ammatillista toimintaa, jossa työntekijä antaa tilaa potilaan ihmisenä olemisen kysymyksille kunnioittaen hänen arvomaailmaansa. Hengellisyydellä tarkoitetaan ihmisen kiinnostusta elämän tarkoitukseen, elämän perimmäisiin arvoihin ja oman olemassaolonsa kysymyksiin. Potilaalta olisi hyvä kysyä, tarvitseeko hänen hoidossaan huomioida uskonnon harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Työntekijän ei tulisi tätä tarvetta kieltää eikä myöskään tuputtaa sitä potilaalle. Hengellisyyden huomioiminen merkitsee potilaan vakaumuksen kunnioittamista, ja se näkyy potilaan mahdollisuutena harjoittaa uskoaan valitsemallaan tavalla. Ihmisen sairastuessa ja elämän kriisitilanteissa hengelliset tarpeet aktivoituvat. Jos ihminen on elämänsä aikana tottu-



Ikali Karvisen AVAUS-malli jäsentää niitä toimenpiteitä, joita hoitaja voi käyttää tukiessaan potilaan henkisten tarpeiden toteutumista.

- Arvot ja vakaumus: Selvitetään, mitkä arvot tai periaatteet, esimerkiksi uskonto, luonto tai kasvisruokavalio, ovat potilaalle tärkeitä. Kysytään, kokeeko hän, että sairastumisella on jonkin selitys tai merkitys.
- Voimavarat: Rohkaistaan potilasta kertomaan, mistä hän saa voimaa tai toivoa. Voiman ja toivon lähteitä voivat olla esimerkiksi musiikin kuuntelu, keskustelu, kirjoittaminen, lukeminen, rukoulu ja mietiskely.
- Arvio henkisistä ja hengellisistä tarpeista: Pyydetään potilasta arvioimaan, miten hänen vakaumustaan tulisi huomioida hoidon aikana ja miten vakaumus näkyy hänen elämässään. Arvioidaan myös potilaan psyykkinen hyvinvointi.
- Ulkopuolinen tuki: Potilaan toiveet kirjataan hoitosuunnitelmaan. Lisäksi selvitetään, haluaako hän tavata esimerkiksi papin, imaamin, rabbin tai vapaa-ajattelijan.
- Spiritualiteettia tukevat hoitotyön toimenpiteet: Potilasta pyydetään kertomaan kulttuuriinsa tai vakaumukseensa liittyvästä erityisruokavalion tarpeesta. Samalla selvitetään, haluaako hän kieltäytyä vakauksensa vuoksi tietyistä hoitotoimenpiteistä. Lisäksi häntä pyydetään kertomaan toiveensa elämänsä päättymistä koskevista toimenpiteistä, kuten viimeisestä voitelusta ja ehtoollisen saamisesta.

nut turvautumaan jumalaan, se on hänelle luonnollista kaikissa elämän vaiheissa.

Hengellisyydellä voidaan tarkoittaa osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin, oman uskonnon kirjallisuuden lukemista ja yhteyden pitoa samoin

ajattelevien kanssa. Ihmisillä on erilaisia hengellisiä tarpeita, ja heidän yksityisyyttään hengellisissä asioissa tulee kunnioittaa. Hengellisyyden huomioiminen hoitotyössä tukee potilasta oman elämän eheyden ja viisauden löytämisessä. Hengellisen hoidon tarkoituksena on auttaa ihmistä pohdimaan kysymyksiä, jotka hän kokee merkitykselliseksi, ja suhdettaan elämän tarkoitukseen, ihmissuhteisiin ja jumalaan. Ihmisen rinnalla kulkeminen hänen iloihsaan ja suruissaan sekä hänen kysymystensä, kipujensa ja pelkojensa kohtaaminen ovat henkistä tukemista arjessa.

Hoitajan tehtävä on lievittää potilaan ja omaisten henkistä hätää ja luoda toivoa. Jos hoitaja huomaa potilaassa pelkoa, hänen tulisi ottaa asia puheeksi. Hoitajan tehtävä on luoda turvallinen ja luottavainen hoitosuhde, jolloin potilas voi vapautuneesti kysyä ja puhua sairauteen, elämäänsä ja kuolemaan liittyvistä asioista. **Hengellinen tuki** voi olla läsnäoloa, kädestä pitämistä, keskustelua ja joskus puhumista pidättäytymistä, muistelua, yhdessä rukoulemista, virsien tai hengellisten laulujen laulamista, lukemista, muistelmien ja elämäntarinoiden kuuntelua tai runojen-, tekstin ja raamatunlukua.

Elinympäristö

Elinympäristöä kehittämällä voidaan edistää ihmisen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä arkipäivässä. Oma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Erityisen merkittäviä ne ovat silloin, kun ihmisen toimintakyky on tavalla tai toisella heikentynyt esimerkiksi sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi.

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ilman puhtaus, veden laatu ja melu. Terveelliseen ympäristöön kuuluu myös esteettömyys. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhukset, lapsiperheet sekä näkö- ja kuulovammaiset pystyvät liikkumaan ympäristössä. Esteettömät ympäristöt ja palvelut tukevat itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Luonnolla ja kasveilla on elvyttävä ja positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, ja sen lisäksi puutarhassa työskentely kehittää fyysisiä taitoja. Kotoa laitosasumiseen siirtyminen vie vanhuksen pois omista tottumuksista ja altistaa vieraantumiselle. Etenkin dementoivissa sairauksissa kasveihin liittyvät toimet rauhoittavat ja herättävät muistoja vanhoista ajoista, esimerkiksi oman kasvipuutarhan hoidosta. Ne voivat antaa potilaalle intoa toimia samalla tavoin kuin aikaisemmin elämässään. Tutut kasvit luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja niistä keskustelemisella on helppo herättää toisten ihmisten mielenkiinto. Ihminen haluaa tuntea itsensä hyödylliseksi ikään katsomatta. Puutarhanhoito sopii terveysliikunnaksi kaikenikäisille, ja siitä voi saada helpotusta tyhjyyden tunteeseen. Terveys sosiologi Aaron Antonovskyn teorian mukaan ihminen voi hyvin, kun hänen elinympäristönsä täyttää kolme ehtoa: ympäristön tulee olla ymmärrettävä, siihen pitää voida vaikuttaa ja sen pitää olla merkityksellinen.

➡ Rappe, E. 2005. Kasvien hoitamisen ja viherympäristön vaikutus laitoksissa asuvien vanhusten koettuun hyvinvointiin. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Aineisto kerättiin haastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla. Aineiston avulla tutkittiin, minkälaisia merkityksiä vanhukselle liittyvät kasvien kasvatukseen, miten kasvit vaikuttivat dementiaan sairastuneiden vanhusten hyvinvointiin ja millaisia kokemuksia henkilökunnalla oli muistisairaiden vanhusten hoitoympäristöön liittyvistä kasveista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten vanhukselle ulkoilu, millaisia vaikutuksia he kokivat ulkoilulla olevan ja mitkä seikat viherympäristössä olivat heille tärkeitä. Tutkimukseen osallistuneet vanhukselle liittyivät kasvien kasvattamiseen merkityksiä, jotka voitiin yhdistää heidän psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Tuloksista voidaan todeta, että kasvien ja kehityksen seuraaminen tuottivat iloa ja myönteistä odotettavaa osallistujien elämään. Henkilökunnan havaintojen mukaan kasvit edistivät muistisairaiden vanhusten hyvinvointia tuottamalla aistivirikkeitä, synnyttämällä myönteisiä tunteita ja luomalla mahdollisuuksia palkitsevaan toimintaan. Viherympäristössä ulkoilu myös vahvisti naisosallistujien hyvinvointia, palautti voimavaroja ja rauhoitti mieltä.

Eläimet yksinäisyyden ehkäisijöinä

Eläimen koskettaminen ja silittäminen koetaan yleensä miellyttäväksi. Hoivaamalla eläintä ihminen tuntee usein hoivaavansa itseään, ja näin se rauhoittaa, rentouttaa ja ruokkii hyvänolon tunnetta. Lemmikki myös lohduttaa, ja usein eläin pysyy lievittämään pahaa oloa. Lisäksi eläimen koskettaminen lievittää läheisyyden kaipausta. Kosketuksen kautta syntyy vilpittömyyden tunne toiseen elolliseen ja tuntevaan olentoon. Tämä asia tiedetään ja tunnustetaan erilaisissa hoitolaitoksissa. Niissä vierailee säännöllisesti koiria, joita asukkaat saavat helliä, ja tällä on todettu olevan asukkaiden **elämänlaatua parantava vaikutus**. Useissa vanhainkodeissa asustaa myös kissoja, joiden tehtäviä voidaan pitää hoidollisina.

➡ Vartiovaara, I. 2006. Lemmikkieläimet ja ihmisen terveys. Terveyskirjasto. Duodecim.

Erilaisissa hoitokodeissa ja vanhainkodeissa moni vanhus mielellään taputtelee eläimiä ja juttelee niiden kanssa. Tämän on havaittu saavan heidät liikkeelle ja olemaan kontaktissa muiden ihmisten



Lemmikkien vaikutuksia ihmisen voimavaroihin:

- Masennus lievittyy.
- Ystävystyminen muiden ihmisten kanssa helpottuu, koska sosiaalisia tilaisuuksia syntyy enemmän.
- Vanhusten yleinen aktiivisuus kasvaa.
- Lemmikin osoittama kiintymys ja ehdoton rakkaus lisäävät näitä tunteita myös ihmisessä ja tuottavat iloa ja energiaa.
- Lemmit vähentävät yksinäisyyden tunnetta ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.

kanssa, mikä sitten mahdollistaa erilaisia virkistys- ja harrastetoimintoja.

Joskus lemmikkieläin, etenkin **koulutettu koira**, pystyy auttamaan ortopedisiä toipilaita liikkumaan leikkauksen jälkeen siinä vaiheessa, jolloin varovainen käveleminen olisi eduksi.

Muistisairaat potilaat voivat olla tavallista rauhallisempia, kun heidän seuranaan on lemmikkieläin, ja eläimiä onkin alettu käyttää eri maissa dementiapotilaiden hoidossa. Eläimet muun muassa alentavat verenpainetta ja hidastavat pulssia.

Näyttää vahvasti siltä, että lemmikkieläimet myös auttavat tehokkaasti toipumaan sairauksista. Erään tutkimuksen mukaan sydäninfarktin saaneiden potilaiden kuolleisuus oli jopa kolmanneksen pienempi, jos heillä oli jokin lemmikkieläin. Liian hygieenisissä olosuhteissa elävillä ihmisillä elimistön normaali puolustusjärjestelmä häiriintyy, ja seurauksena voi olla allergia. Itse asiassa altistuminen eläinpölylle voi estää elimistöämme sairastumasta allergioihin ja astmaan.

➡ Lotta Lumiala kuvaa tutkimuksessaan vuonna 1909 syntyneen Siirin tilannetta. Siirillä on useita sairauksia ja sydämentahdistin. Siiri lopetti voimistelussa käymisen, kun lääkäri kielsi häntä nostamasta käsiään pään yläpuolelle. Henkilökunnan ja omaisten kiellot ovat vähitellen saaneet hänet luopumaan myös portaiden kiipeämisestä. Siiri kokee henkilökunnan painostavan häntä passiivisuuteen ja kiinnittävän liioitellusti huomiota riskeihin. Johtaja oli myös sanonut Siirille, ettei tämä saa mennä ulos, jollei sinne ole ehdottoman tärkeää asiaa. Personal trainer -kokeilun aikana Siiri aktivoitui ja omaksuu voimisteluohjelman. Hän alkaa säännöllisesti noudattaa ohjelmaa ja kokee hyötyvänsä siitä. Omaiset kuitenkin pitävät Siirin liikuntaharrastusta turhanpäiväisenä ja vaarallisena. Myös 95-vuotiaalla on oikeus tehdä aivan mitä haluaa. Siiri peseekin itse mattonsa – salaa omaisiltaan.

Lumiala, L. 2006. "Laiskamato pysyy kauempana, kun ei ota sitä mukkaan": neljä tapauskertomusta ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonnasta. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto



Kuva 17.1 Hyvä olo



Kuva 17.2 Mun kaveri



Kuva 17.3 Miten tästä eteenpäin



Kuva 17.4 Esteetön luontoelämys



Kuva 17.5 Toiminnallinen puutarha

Muistelu ja muistot

Ihmisiä voidaan auttaa muistelulla, joka tuo esiin muistoja ja mielihyvää. Muistelu on tapahtuma, jossa ihminen palauttaa mieleensä unohduksissa olleita kokemuksiaan yksin tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Muistelemalla tuotetaan kerronnallisesti **omaa elämäntarinaa**: tulkitaan menneisyyden tapahtumia ja luodaan tulevaisuuden kuvitelmia. Muistelu antaa ihmiselle mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää elettyä elämää ja itseä menneisyyden tapahtumien kautta. Muistelemisen voi tuottaa ihmiselle toivoa, mielihyvää, lohdutusta sekä vahvoja aistimuistoja, kuten kuvia, värejä, tuoksua ja makuelämyksiä. Muistamiseen liittyy nostalgia, tunne menneen kadottamisesta ja halu palata sinne. Nostalgisissa muistoissa aiempi elämä näyttää yksinkertaisemmalta ja turvallisemmalta. Muistelu vahvistaa ihmisen **identiteettiä** ja ainutlaatuisuuden tunnetta sekä antaa hänelle ymmärrystä omasta itsestä ja oman elämän merkityksestä.

Jokaisen ihmisen tarina on ainutkertainen, ja jokaisen elämässä on jotain arvokasta. Esimerkiksi vanhus voi saada muistoista apua rappeutuvan kehonsa hyväksymiseen ja sairauksien kanssa elämiseen. Spontaani muistelu lisääntyy erityisesti elämän isoissa käännekohtissa. Muistelun ei aina tarvitse olla erityisen suunniteltu ja ohjattu tilanne. On tärkeä tarttua arjen pienten muistelututkoiden mahdollisuuteen. Kun omaiset ovat tietoisia **muistelun merkityksestä**, he jaksavat ehkä paremmin kuunnella omaisensa toistuvia kertomuksia. Muistelua voidaan toteuttaa kertomalla, kirjoittamalla ja maalaamalla. Tutut valokuvat, laulut ja esineet herättelevät muistoja. Esineistä voi koota esimerkiksi muistelurasian, johon voi kerätä tärkeitä esineitä, valokuvia ja lehtileikkeitä.



Tutustu seuraaviin verkkosivuihin:

www.omaishoidonverkosto.fi

www.omaishoitajat.fi

www.esteeton.fi

www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys

www.muistiliitto.fi

17.3 Potilaan toimintakyvyn ja selviytymisen ylläpitäminen

Tutkimusten mukaan potilaat ja heidän läheisensä saavat hoitajilta emotionaalista ja tiedollista tukea. Hoitajat tunnistavat tuen tarpeen havainnoiden potilasta, luottamalla intuitioon ja rakentamalla hyvän hoitosuhteen potilaan ja perheenjäsenen kanssa. **Tuen tarpeiden tunnistamisessa** keskeistä on kokonaiskuvan muodostaminen potilaan ja perheenjäsenten tilanteesta. Hoitajien keskinäinen yhteistyö, omahoitajana toimiminen ja tutkitun tiedon käyttö helpottavat potilaan ja omaisten tuen tarpeen tunnistamisessa. Potilas ja hänen läheisensä tulisi ottaa mukaan hoidon suunnitteluun ja potilaan ohjaustilanteisiin. Perheenjäsenen osalta tukemisen kehittämishaasteet liittyvät toivon ylläpitämiseen, myötäelämisen kokemusten vahvistamiseen, tiedon aktiiviseen antamiseen sekä perheenjäsenten henkilökohtaisen jaksamisen ja tunteiden tukemiseen. Myös perhe voi tukea sairastunutta läheistään osastolla konkreettisesti hoitamalla, olemalla läsnä ja pitämällä yllä toivoa.

Tukeakseen ja selviytyäkseen paremmin läheisensä hoitamisesta ja auttamisesta toimintakyvyn ylläpitämisessä potilaan perheenjäsenet tarvitsevat hoitajien kanssa keskustelua ja tiedon jakamista. Potilaat arvostavat hoitajien saatavilla oloa, aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja yhteydenottoja.

Potilaalla voi olla **keskittymiskyvyn ongelmia**, jotka osaltaan vaikeuttavat hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. Keskittymiskyky ja tarkkaavuus liittyvät keskeisesti muun muassa aivojen otsalohkon etuosan toimintaan. Jos kyseisten alueiden toiminnassa on poikkeavuutta, seurauksena voi olla erilaisia oireita, esimerkiksi aloitekyvyttömyyttä, ilmaisukyvyttömyyttä, ylivilkkausta, muistihäiriöitä ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Nämä ongelmat voivat johtaa siihen, että potilaalle itselleen tai hänen perheelleen on ylivoimaista selviytyä sairaudesta ja sen hoidosta ja niiden aiheuttamista elämänmuutoksista. Hoitotyössä potilasta ohjatesaan hoitajan tulisi ottaa huomioon edellä mainitut potilaan selviytymistä haittaavat tekijät.



Potilaan selviytymistä voidaan tukea eri terapioiden avulla:

Psykoterapia kohdistuu mielenterveydenhäiriöiden ja kriisien hoitamiseen.

Kognitiivinen psykoterapia lähestyy ihmistä oppivana ja tulkitsevana olentona, jolloin syvään juurtuneet toimintatavat tulevat esille

Perheterapiassa terapeutit tapaavat perheenjäseniä samanaikaisesti ja sama terapeutti tapaa kutakin perheenjäsentä erikseen.

Traumaterapiassa trauman kokeneet ihmiset käsittelevät terapeutin avulla muistin ulottumattomissa olevia traumaattisia tapahtumia.

Toimintaterapiassa pyritään löytämään ihmiselle luontaiset toimintatavat ja tukemaan niitä.

Musiikkiterapiassa musiikki toimii kommunikatiota edistävänä välineenä. Esimerkiksi musiikin kuuntelun jälkeen keskustellaan tuntemuksista.

Kirjallisuus- ja runoterapiassa lukeminen ja kirjoittaminen auttavat potilaan omien ongelmien käsittelyssä.

Kuvataideterapiassa potilas kertoo itsestään esimerkiksi maalaamalla. Tällä pyritään potilaan luovuuden herättämiseen ja ahdistuksen lievittämiseen.

Ohjaus on keskeinen alue hoitotyössä: se on asiakassuhteen punainen lanka koko hoitoprosessin ajan. Potilaiden tarpeet tulee kohdata ja ohjausta tulee antaa niin, että potilas ymmärtää itse hoito-ohjeet ja selviää kotona. Ohjauksella tuetaan potilaan omia voimavaroja, jotta hänen oma aktiivisuutensa lisääntyy ja hän pystyy ottamaan enem-

män vastuuta omasta hoidostaan ja terveydestään. Ohjauksella myös autetaan potilasta saavuttamaan asetetut **hoitotavoitteet**. Ohjaus ei kuitenkaan ole riittävän tuloksellista ilman potilaan lähipiiriä, johon kuuluvat perhe ja muut läheiset, ja myös he tarvitsevat tukea ja ohjausta.

Sairaalahoidossa keskitytään tutkimuksen mukaan käsittelemään tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, mutta yksilöllisestä elämäntilanteesta ja voimavaroista keskustellaan vähän. **Potilaan yksilöllisyys** tulee huomioida. Ohjaustilanteen tulisi myös olla kiireetön, ja ohjausta tulisi antaa potilaan tilanteen kannalta oikeaan aikaan. Tutkimusten mukaan potilaat tarvitsevat kokonaisvaltaista ja yksilöllisen elämäntilanteen huomioon ottavaa ohjausta itsehoidon onnistumiseksi. Konkreettisten ohjeiden saaminen arjen tilanteisiin luo potilaalle tunteen mahdollisuudesta hallita sairauden oireita. Potilaat toivovat myös tietoa potilasyhdistystoiminnasta. Potilaan hyvän ohjauksen varmistamiseksi yksi mahdollisuus on seurata ohjauksen toteutumista **ohjauslomakkeella**, johon jokainen hoitaja merkitsee asiasisällöt, joista on potilaan kanssa keskustellut.

Sairauteen sopeutuminen on tärkeää potilaan omahoidon kannalta. Esimerkiksi juuri todettu pitkäaikaissairaus on sokki ihmiselle: hänen mielessään risteilee kaikenlaisia kysymyksiä ja uhkakuvia. Sopeutuminen tapahtuu hiljakseen, kun aikaa on kulunut ja potilas on saanut ohjausta ja tukea hoitotiimiltä ja perheeltään. Tietyissä pitkäaikaissairauksissa potilaalle on tarjolla erityisiä sopeutumisvalmennuskursseja, joihin voivat osallistua myös hänen perheenjäsenensä. Sopeutumista helpottavat potilaan hyvä ohjaus ja rehellisen tiedon antaminen.

Puhekyvyn ongelmat ja kommunikaatio

Ihmisen kielellinen ilmaisukyky on tiiviissä yhteydessä psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen sekä hyvinvointiin. Puheen tuoton ongelmien taustalla voi olla jokin **neurologinen sairaus tai vamma**. Se voi olla synnynnäinen tai myöhemmin kehittynyt. Puhekyvyn menetykseen liittyy

potilasta että hänen läheisiään. Lapsilla häiriöt voivat johtua esimerkiksi CP-vammasta, kehitysvammasta tai puheen ja kielen kehitykseen liittyvästä erityisvaikeudesta. Aikuisilla taas aivoverenkiertohäiriöt ja tietyt neurologiset sairaudet aiheuttavat puhehäiriöitä. Kommunikaatiovaikeuksia voi tulla sekä elimellisistä että toiminnallisista äänihäiriöistä, jotka voivat kehittyä hitaasti.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut voi olla ahdistunut ja jännittynyt, ja hänen mielialansa vaihtelevat. Sureminen auttaa käsittelemään sairauden aiheuttamia menetyksiä. Lääkitystä tai terapiaa ei välttämättä tarvita. Moni aivoverenkiertohäiriön sairastanut masentuu. Hän voi tarvita muiden apua.

Sairastuminen aiheuttaa vamman sijainnista ja tyypistä riippuvia muutoksia ihmisen vuorovaikutustaitoihin. Potilaan ääni voi muuttua monotoniseksi ja honottavaksi. Puhe voi myös hidastua tai muuttua vaikeaselkoiseksi, tai potilas saattaa menettää kokonaan puhekykynsä. Omaiset ja läheiset ymmärtävät vaikeutunutta puhetta helpommin kuin vieraat ihmiset.



www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
www.oppimisvaikeus.fi
www.nuortennetti.fi



Kommunikointia haittaavia sairaustiloja:

Afasia: osittainen tai täydellinen kielellisen toiminnan häiriö

Dysartria: mongerteleva puhe

Dysfonia: vain äänen muodostus on häiriintynyt

Dyspraksia: puhe-elinten kyvyttömyys tuottaa suun alueen liikesarjoja

Dysfasia: laaja-alainen kielellinen hahmotamishäiriö

Dysfagia: nielemishäiriö

Dysleksia: lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukihäiriö



Puheen tuottamisen häiriöitä voivat olla esimerkiksi

- puheen suunnittelun vaikeus
- aloitteellisuuden ja alkuunpääsyn vaikeus
- puheen äänneohjelmoinnin häiriö
- sanan löytämisen vaikeus
- sananvalintahäiriö
- puheen juuttuminen
- lauseiden tuoton vaikeus.

Puheen ymmärtämisen häiriöitä voivat olla esimerkiksi

- äänteiden erottelun ja hahmottamisen vaikeus
- sanojen merkityksen ymmärtämisen vaikeus
- heikentynyt puheen mielessä pitäminen
- kielipillisten suhteiden ymmärtämisen häiriö
- puheen takertuvuushäiriö.

Kielellinen häiriö voi ilmetä sanavaraston pienuutena, aikamuotovirheinä, sanojen muistamisen vaikeutena tai riittävän pitkien tai monimutkaisten lauseiden muodostamisen vaikeutena. Oireina ilmenee kielelliselle ilmaisuhäiriölle ominaisten oireiden ohella vaikeutta ymmärtää lauseita tai tiettytyypisiä sanoja, kuten tilakäsitteitä. Änkyttäminen ilmenee erilaisina puheen sujuvuutta hankaloittavina häiriöinä, kuten äänteiden, tavujen tai yksitavuisten sanojen toistona, äänteiden pidentymisenä, äännähdyksinä, katkonaisina sanoina, talketteluna tai vaikeiden sanojen korvaamisena erilaisin kiertoilmaisuin.

Potilaan ajattelu- ja puhehäiriöiden tunnistaminen on oikeanlaisen tuen ja avun antamisen edellytys. **Kognitiiviset häiriöt** ilmenevät ihmisen tarkkaavuuden, keskittymiskyvyn ja muistamisen muutoksina, tiedon käsittelyn nopeudessa ja kielellisissä taidoissa. Häiriöt voivat olla ohimeneviä tai pysyviä. Uupumus, masennus ja stressi pahentavat oireita.

Kognitiiviset muutokset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja siinä selviytymiseen. Neurologiset häiriöt ja vammat tulee selvittää neuropsykologisin tutkimuksin. Potilaan kanssa käydään läpi arkielämän tilanteita ja häntä ohjataan tunnistamaan heikkoutensa ja vahvuutensa, jotta hän osaisi asettaa vaatimustasonsa oikeassa suhteessa voimavaroihinsa. Potilaan läheiset voivat **tulkita** potilaan **käyttäytymisen virheellisesti** esimerkiksi välinpitämättömyydeksi, vaikka kyse voi olla siitä, ettei potilas ymmärrä muiden ihmisten antamia signaaleja. Läheisten tulisi tietää, miksi omaisen käyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia. Arkipäivän asioista selviytymisen helpottamiseksi potilas voi käyttää kalenteria ja muistilappuja. Potilaan tulee osata levätä, ettei hän uupuneena joudu pinnistelemään arjen asioiden kanssa. Toisten ihmisten ymmärtäminen ja itsensä ymmärretyksi tekeminen on joskus hyvin vaikeaa. Viestin perille menoon tarvitaan ihmissuhdetaitoja. Viestinnässä tunteet ovat hyvin tärkeitä. Jos tunteita ei ymmärrä, viestikin menee huonommin perille. Perustunteita ovat viha, ahdistus, suru ja ilo.

Voidakseen toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä puhevammaisen tarvitsee **tulkin apua** kommunikointiinsa. Jos hänen kykynsä ilmaista itseään on puutteellinen tai puuttuu lähes kokonaan, hänen mahdollisuutensa keskustella ilman kommunikaatioapua ovat vähäiset. Valtaväestö ei välttämättä ilman selvennystä ymmärrä puhevammaisten ilmaisua. Ilman tulkkipalvelua puhevammaiset joutuvatkin eriarvoiseen asemaan muihin nähden ja vaaraan syrjäytyä yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Onnistunut kommunikaatio tulkin avulla taas voi merkittävästi lisätä puhevammaisen tunnetta oman elämän hallinnasta ja itsemääräämisestä. Hoitajan tulee huolehtia siitä, että potilas, jolla on oikeus tulkkipalveluun, saa tietoa sairautestaan ja hoidostaan. **Laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta** (19.2.2010/133) määritellään, että oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on,

että henkilö kykenee ilmaisemaan oman tahtonsa tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Ihmissuhteet ja läheisyys

Yksin oleminen on joillekin vaikeaa. **Yksinäisyyden kokemus** voi syntyä monista lähtökohdista. Toisilla yksinäisyys liittyy luonteenpiirteisiin ja temperamenttiin. Arka, hiljainen, jäykkä tai huomion herättämistä välttelevä voi tahtomattaan jäädä ulkopuoliseksi seurassa. Omassa elämässä voi myös tapahtua muutoksia, jotka muuttavat ihmistä ja hänen ajatuksiaan ja arvojaan, mikä aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta. Oma tai läheisen ihmisen sairaus voi myös saada aikaan pelkoja, mikä tekee yksin olemisesta vaikeaa.

Ihminen tarvitsee läheisyyttä. Kokemus itsensä syntyä, kun ihminen on **vuorovaikutuksessa** toisten ihmisten kanssa ja opettelee tunteiden jakamista. Ihmisten kohtaamisessa ja hoitamisessa ei riitä pelkästään yksilöllisyyden huomioiminen vaan aina on muistettava ihmiselle tärkeä yhteisöllisyys. Yhdessä olemalla ja toimimalla on mahdollista saada vertaistukea, uusia ystäviä ja uusia virikkeitä. Yhdessä tekeminen opettaa ihmisiä välittämään toisistaan, ja parhaimmillaan yksilö saa sen avulla kokea, että hänestä välitetään.

Läheisyys toimii kuin lääke: fyysinen kosketus, kuten hieronta, rentouttaa ja lievittää kipua. Kun toinen ihminen koskettaa johonkin muualle kuin sinne, missä varsinainen kipu on, fyysinenkin kipu saattaa lievitä. Kosketus ja läheisyys toiseen ihmiseen auttavat tunne-elämän kipuihin ja kokemuksiin itsestä. Jo vauvakin muodostaa kuvaa kehostaan ja itsestään kosketuksen ja läheisyyden pohjalta. Tarve saada tuntoaistimuksia toisen kosketuksen kautta säilyy läpi elämän. Kosketus ja hieronta voivat laukaista yllättäviäkin tunnereaktioita, kun ihmisen lihaksisto on jännittynyt tunne maailman takia. Useimmiten psyykinen läheisyys riittää. Se voi olla hiljaista läsnäoloa, vuorovaikutamista elein ja ilmein tai keskustelua.

Todellinen yhteys toiseen ihmiseen vaatii aikaa. Kuulluksi tuleminen ei ole pelkästään tunnetta siitä, että joku vain kuuntelee, vaan se on lisäksi



Kuva 17.6 **Läheisyys**

tunnetta siitä, että kuuntelija ymmärtää tai haluaa ymmärtää, mitä toinen ihminen kertoo. Kokemus siitä, että joku ymmärtää ihmistä tämän vaikeassa tilanteessa, voi äärimmäisissäkin tilanteissa olla parantavaa ja lievittää psyykkistä ja fyysistä kipua. Yhteys hengelliseen maailmaan tuntuu joistakuista hyvältä ja antaa voimia silloin, kun muut eivät kykene ymmärtämään.

Sairastuminen muuttaa ihmisen tilannetta, ja mahdollisuudet oman yksityisyyden säätelyyn vähenevät. **Yksityisyys ja intimitteettisuoja** saataan usean hengen potilashuoneessa kokea puutteelliseksi ja uhatuksi. Yksityisyyden puuttumista sairaalaloissa on sellaisten henkilöiden läsnäolo, joiden ei toivoisi olevan läsnä intiimeissä tilanteissa. Myös ihmisten inhimillinen kiinnostus toisten ihmisten tilannetta kohtaan heikentää yksityisyyttä. Useimmat ihmiset arvostavat yksityisyyden suojaa, koska tietyt seikat kuuluvat vain itselle. Ihminen voi päättää itse siitä, mitä tietoja hän itsestään muille antaa, ja persoonan yksityisyyttä kuuluu kunnioittaa. Kunnioittamalla yksityisyyttä vältetään noloja tilanteita ja häpeän ja kärsimyksen aiheuttamista.

Autonomisen persoonan kehittyminen edellyttää yksityisyyttä, ja ilman oikeutta yksityisyyteen ihmisestä tulee mukautuja, joka sopeutuu ryhmä-

paineeseen. Ihmiseltä, joka pakotetaan elämänsä jokaisena hetkenä olemaan toisten seurassa ja jonka jokainen tarve, ajatus, halu, unelma tai mielihyvän kokemus on yleisen silmälläpidon alaisena, on riistetty hänen yksilöllisyytensä ja ihmisarvonsa. Sosiaaliset suhteet ja yksityisyyden suoja liittyvät toisiinsa monin tavoin. Potilaita ei koske vaitiolovelvollisuus, mikä hoitohenkilökunnan on syytä huomioida toimiessaan potilaiden parissa. Itsetunnoltaan vahvat tarvitsevat vähemmän henkilökohtaista tilaa kuin ahdistuneet, jotka saattavat kokea omaan sairauteen liittyvän epävarmuuden tunteen ahdistavana ja pelottavana.

Potilaan hoitoympäristö pyritään järjestämään niin, että hänen yksityisyytensä huomioidaan ja sitä kunnioitetaan. Sairaalassa väliverhot ovat suojana ja potilaan oman tilan rajoina. Oma alue antaa turvaa ja mahdollistaa yksityisyyden, identiteetin ja autonomian. Sen sijaan dreenit ja eritepusit koetaan helposti epäesteettisiksi ja uhkaksi yksityisyydelle. Tutkimusten mukaan potilaat kokevat, että heidän yksityisyytensä erilaisissa hoitotoimenpiteissä ei välttämättä toteudu. Potilaat myös toivovat, että väliverhoja ja sermejä käytettäisiin enemmän ja ettei heidän asioistaan puhutaisi muiden kuullen.

Potilaan saama sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen aktiivisuus vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja ehkäisevät eristäytymisen ja yksinäisyyden kokemuksia. Potilaan sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, elämäkatsomus ja vakaumus eivät saa vaikuttaa potilaan saaman tuen määrään. Hoitajan on oltava objektiivinen, puolueeton ja tasapuolinen.

Muutokset terveydessä ja toimintakyvyssä saattavat muuttaa ihmisen aktiivisuutta sosiaalisissa suhteissa. Myös puolison toimintakyvyn heikkeneminen ja sairaudet voivat vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista. Tutkimuksissa on havaittu, että fyysisen toimintakyvyn heikentyessä avunantajien määrä kasvaa, kun taas kognitiivisen tason lasku johtaa avunantajien vähenemiseen. Myös kroonisten sairauksien vaikeusasteella on todettu olevan vaikutusta vuorovaikutussuhteisiin. Lievempiä sairauksia sairastavilla on vähemmän tukea antavia ihmisiä lähellä kuin vakavas-

ti sairailta. **Psyykkiset sairaudet ja mielialaongelmat** taas saavat usein ihmisen vetäytymään ihmismuhteista, ja ystävät voivat jättää psyykkisesti sairaan. Vastavuoroisuus vuorovaikutussuhteissa voi myös muuttua yksisuuntaiseksi auttamissuhteeksi, mikä heikentää potilaan kokemusta siitä, että hän on hyväksytty ja arvostettu, ja lisää masentuneisuutta. Ystävien ja sukulaisten puuttuminen saat-
taa olla syynä sairaalahoitoon joutumiseen ja pitkittää sairaalassaoloaikaa.

Potilaan kohtaaminen

Hoitajalla on ammattitaitoa luoda **inhimillinen yhteys** potilaaseen missä tahansa tilanteessa ja minikälaisen potilaan kohdalla tahansa. Yhteyden ilmenemismuotoja ovat kosketus, eleet, ilmeet, sanat ja puhe, hoitotoimenpiteet sekä hoivaaminen, huolehtiminen ja välittäminen. Ne vaikuttavat oleellisesti kaikissa kohtaamisissa. Erityisesti sanat ovat ilmaisukeinoja, jotka kuvastavat ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat eettisesti hoitamisen keskeisiä taitoja. Hoitajan tulee myös tiedostaa, että sairas ihminen ja hänen omaisensa tarvitsevat myötätuntoista kohtaamista. Vaarana on kuitenkin kärsimyksen poistajaksi ja pelastajaksi ryhtyminen. Hoitaja ei voi koskaan ymmärtää täydellisesti toisen ihmisen kokemuksia ja tarpeita, mutta hän voi olla läsnä ja tukea yrittämättä olla kaikkivoipa.

Hoitosuhte on ymmärtävä, ja silloin siinä on vahva toivon näkökulma. Kaikki elämänvarrella koettu muokkaa ihmisen ajattelua ja toimintaa. Jokapäiväinen hyvinvointi riippuu yksilön voimavaroista eli siitä, miten hän kestää paineita ja osaa tunnistaa ja ilmaista tunteitaan ja miten hän on vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Hoitajan käymät keskustelut potilaan kanssa ja hoitajan antama ohjaus lisäävät potilaan turvallisuuden tunnetta ja vähentävät avuttomuuden kokemusta. Toisen henkilön läsnäolo ja saatavilla olo tuovat turvaa potilaalle. Hoitajan rauhallinen käytös rauhoittaa. **Läsnäolo** tarkoittaa sitä, että hoitaja tarkistaa potilaan voinnin usein ja reagoi nopeasti potilaan kutsuun. Saatavilla oleminen, potilaan tarpeiden huomioiminen ja tarkoituksenmukainen

reagointi tilanteen vaatimusten mukaan merkitsevät potilaalle huolenpitoa. Sylissä pito tarkoittaa ihmisen fyysistä koskettamista, kädestä pitämistä tai muulla tavoin lohduttamista. Henkinen sylissä pito on sairauden tai kriisin vuoksi ahdistuneen ihmisen tunteiden hyväksymistä ja henkistä tukea.

Vaikeuksien keskellä ihminen kaipaa **lohtua**. Oikeita sanoja tai vastauksia ei tarvitse etsiä. Riittää, kun on läsnä ja kuuntelee. Hyvä lohduttaja ei koskaan kritisoi tai vähättele vaan kuuntelee empaattisesti. Häneltä vaaditaan myös kykyä ja rohkeutta tulla toista lähelle. Myös hoitajan kosketuksella ilmaistaan, että potilas voi tuntea olonsa turvallisiksi ja että hänestä pidetään huolta. Yhtä oikeaa tapaa lohduttaa ei ole.

Toivoon liittyy tunteita, realismia sekä suhteita muihin ihmisiin ja jumalaan. **Toivo** voi saada aikaan toimintaa ja luottamusta siihen, että selviää eteenpäin. Lisäksi toivoon ja luottamukseen eteenpäin selviämisestä vaikuttavat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä ihmisestä itsestään johtuvat ja hänen ympärillään olevat tilannetekijät. Toivo voi olla epärealististakin, jos ihminen kieltää esimerkiksi väistämättömän lähestyvän kuoleman. Hyväksyessään potilaan tunteet ja ilmaisut ja antaessaan aikaa hänen kysymyksilleen hoitaja jakaa potilaan huolia ja luo toivoa.

Ihmisen on hyvä elää sovussa itsensä kanssa ja tietää, mitä hän kestää ja mitä ei. Omien sisäisten normien vastainen elämä aiheuttaa ahdistuneisuutta, joka helpottuu, kun tasapaino oman itsen ja ympäristön kanssa löytyy. Tasapainoa ja sopeutumista tarvitaan myös suhteessa toisiin ihmisiin. Terve itsekunnioitus on mielenterveyden perusta. Tasapainoinen ihminen ei kiusaa heikompiin. Avoimuus edistää mielenterveyttä, joten hoitajan tehtävänä on rohkaista potilasta puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan.

Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia. Tärkeintä on vain mennä lähelle. Väliä. Minulla on aikaa ja minua koskettaa se, mitä sinulle kuuluu.

Hilja Aaltonen

17.4 Saattohoito

Kuolevan potilaan hoitoa nimitetään saattohoidoksi. **Saattohoito** on vaikeasti sairaan hoitamista, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu eikä sairauden etenemiseen enää voida vaikuttaa. Saattohoito on potilaan toiveiden huomioon ottamista, mahdollisimman hyvää oireiden hoitoa, lähestyvään kuolemaan valmistamista ja potilaan läheisten huomioimista ja tukemista. Saattohoidon päämäärä on kärsimyksen lievitys ja tavoitteena yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Ihminen voi laatia hoitotahdon, jossa hän tuo esille, miten hän haluaa tulla hoidetuksi vaikean sairauden aikana ja kuoleman lähestyessä. Hoitotahto pitää aina kirjata potilaan tietoihin, ja sitä pitää kunnioittaa. Saattohoitopäätös tehdään yhteisymmärryksessä hoitoneuvottelussa potilaan kanssa. Potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat monipuolista ja ymmärrettävää tietoa, jotta he kykenevät ottamaan osaa hoitopäätösten tekoon. Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri. Kuolevaa potilasta voidaan hoitaa kotona, saattokodissa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Jokaiselle kuolevalle taataan arvokas, rauhallinen ja kivuton kuolinhetki.

Palliativinen hoito on WHO:n määritelmän mukaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantumaton, kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle kärsimystä ja heikentää hänen elämänlaatuaan.



Lisätietoa saattohoidosta:

Saarto T. & asiantuntijatyöryhmä 2017 Palliativisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen

Työryhmän suositus osaamis- ja laatuksikriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle sphy.fi Suomen palliativisen hoidon yhdistys

Etene. Elämän loppu

Sand, H. 2003. Sateenkaaren päästä löytyy kultaa: Tutkimus Suomalaisesta saattohoidosta. Väitöskirja

Käypä hoito -suositus. 2019. Palliativinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliativisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä



Palliativinen hoito

- Palliativisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.
- Saattohoito on osa palliativista hoitoa, joka ajoittuu viimeisiin elinviikkoihin tai päiviin, jolloin potilaan toimintakyky on yleensä merkittävästi heikentynyt.
- WHO:n arvion perusteella elämän loppuvaiheessa palliativista hoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain ainakin 30 000 henkilöä.

Potilaan toiveiden toteuttaminen kuoleman lähestyessä

Saattohoidon lähtökohta on potilaan kunnioittaminen. Hoitosuhteessa on tärkeä puhua ja paneutua potilaan toivomuksiin ja miettiä, miten ne toteutetaan. Potilaiden toivomukset voivat olla erilaisia. Toiset haluavat ennen kuolemaansa mennä kotiin ja toiset esimerkiksi ravintolaan, ulkomaille tai kirkkoon. Hoitotyöntekijän tulisi toteuttaa kaikki mahdolliset viimeiset toiveet. Hoitokokouksissa pohditaan, miten potilaan toiveen voi toteuttaa ja kuka vastaa sen toteuttamisesta. Hoitajan on kunnioitettava potilaan tunteita (vihaa, ahdistusta, luopumisen tuskaa) ja huomioitava, että lähestyvä kuolema voi muuttaa ihmistä. Potilaalle pyritään takaamaan oikeus kuolla hänelle mieluisassa ympäristössä.

Kuolevan potilaan hoidossa korostuu usein **kipuvuhoito**, jossa käytetään vahvoja opioideja ja erilaisia lääkeyhdistelmiä. Potilas on oman kipunsa asiantuntija. Hoitotyöntekijän on huolehdittava kuolevan potilaan kivuttomuudesta, sillä kuoleva potilas ei missään tapauksessa saa kärsiä kivusta.

Kuoleva potilas tuntee usein kuolemanpelkoa, ja hoitotyöhön tulee sisältyä potilaan **hengellinen tai henkinen tukeminen**. Hengellisen ja henkisen tukemisen toimintoja ovat muun muassa läsnäolo, kuuntelu, hyväksyvä suhtautuminen, toivon ylläpitäminen, potilaan mahdollisten uskonnollisten tarpeiden huomioiminen ja tapaamisten järjestäminen esimerkiksi sairaalateologin kanssa. Hoitaja on avainasemassa potilaan ja sairaalateologin välisen yhteyden luomisessa. Potilas voi toivoa sielunhoitoa, joka tarkoittaa rukoilemista, hengellisten laulujen laulamista tai kuuntelua ja uskonnollisten kirjojen tai Raamatun lukemista sekä papin antamaa rippiä ja ehtoollista. Jos sairaalassa ei ole saatavilla potilaan toivomaa hengellistä tai henkistä tukea, hoitajan pitää yrittää järjestää potilaan toivomaa ja vakaumuksen mukaista tukea esimerkiksi yhteistyössä omaisten kanssa.

Hengellisten tarpeiden ilmaisu voi olla potilaalle vaikeaa, koska se vaatii oman sisimmän paljastamista. Niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa myös hoitotyöntekijälle. Hoitajalla on omasta elämänskatsomuksestaan tai uskostaan riippumatta velvollisuus kuunnella ja vastata kuolevan potilaan hengellisiin tarpeisiin.

Vakaumuksen kunnioittaminen:

www.kirkkohallitus.fi

Kirkkohallitus on julkaissut vakaumuksen kunnioittamiseen liittyvän ohjeen, jossa käsitellään eri uskontokuntia ja etnisiä ryhmiä koskevia asioita, jotka on syytä huomioida. Ohjeessa mainitaan, jos jonkin ryhmän osalta pitää ottaa huomioon jotain erityistä hoitotoimenpiteissä, ruokailuissa, sosiaalisissa tavoissa, pyhissä toimituksissa, kuolevan potilaan tai vainajan käsittelyssä tai obduktiossa. Ohjeessa käsiteltäviä uskonnollisia tai etnisiä ryhmiä ovat muun muassa vapaiden kristillisten suuntien edustajat, Jehovan todistajat, mormonit, juutalaiset ja islaminuskaiset.

Potilaan **perustarpeista huolehtimisen** lisäksi hoidossa korostuu **mielihyvän** tuottaminen arjen pienissä asioissa. Se voi näkyä mieliruokien ja -juomien tarjoamisena, kampauksesta ja vaatetuksesta huolehtimisena ja viihtyisän hoitoympäristön luomisena. Kuoleva potilas voi olla myös äkillisesti

sairastunut tai onnettomuuden tai väkivallan uhri. Tällaisissa tilanteissa on mahdollista käyttää potilaan elimiä vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoon, jos se on lääketieteellisesti aiheellista. Siirrettäviä elimiä ovat muun muassa sarveiskalvot, munuaiset, sydän, keuhkot ja maksa. Elinaikanaan ihminen voi tehdä myös elintestamentin, jonka avulla

hän ilmaisee tahtonsa siitä, että hänen elimiään voidaan käyttää hänen kuolemansa jälkeen. Elin testamentteja saa muun muassa sairaaloista ja apteekkeista, ja kaikki halukkaat voivat täyttää sen ja säilyttää sitä esimerkiksi lompakossa.



Kuolevan potilaan hyvä perushoito:

- kivunhoito. Kivun lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti ja kivun arvioinnissa käytetään erilaisia kipumittareita, kuten VAS-kipujanaa. Hoitaja voi lievittää potilaan kipua antamalla kylmä- ja lämpöhoitoa, rentoutushoitoa ja hierontaa. Tavoitteena on kivuttomuus.
- ravinnon ja nesteen tarpeeseen liittyvä kokonaisvaltainen hoito. Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, kuivuminen ja ummetus ovat kuolevilla potilailla tavallisia oireita. Niitä voidaan lievittää erilaisin keinoin. Ruokahaluttomuutta voidaan vähentää esimerkiksi tarjoamalla mieliruokia ja riittävän pieniä annoksia ja kattamalla ateriat kauniisti. Raikasta juotavaa on aina oltava tarjolla. Pahoinvointia voidaan vähentää muun muassa pahoinvointilääkkeillä. Jos potilas ei halua tai voi syödä ja juoda, saattohoidossa edetään potilaan ehdoilla ja useimmiten tyydyttään siihen, mitä potilas normaalisti pystyy syömään ja juomaan.
- suolen toimintaan ja virtsaamiseen liittyvä hoito. Saattohoitovaiheessa ummetus on tavallista. Syynä voivat olla eri lääkkeineet, jotka hidastavat suolen toimintaa, tai elintoimintojen hidastuminen kuoleman lähestyessä. Ummetusta ehkäistään ja hoidetaan aktiivisesti esimerkiksi kuitupitoisella ravinnolla ja suolen toimintaa parantavilla lääkkeil-

lä. Saattohoitopotilaalla virtsanpidätyskyvyttömyys on tavallinen ongelma. Virtsanpidätyskyvyttömyyttä hoidetaan yksilöllisesti ja ihon, vaatteiden ja vuoteen puhtaudesta huolehditaan hienotunteisesti.

- hengittämisen helpottaminen. Usein saattohoitopotilas on paljon vuoteessa ja hänen hengitystoimintansa heikkenee makuuasennon vuoksi. Lisäksi eri sairaudet aiheuttavat hengittämiseen ongelmia. Hengenahdistuksesta kärsivää potilasta autetaan kohoasennolla, muulla asentohoidolla, lisähapen antamisella, liman imemisellä hengitysteistä ja huolehtimalla huoneilman raikkaudesta. Hengenahdistuksesta kärsivää potilasta ei koskaan saa jättää yksin. Hengenahdistuksesta johtuvia oireita voidaan lievittää myös läkehoidolla.
- unettomuuden hoito. Potilaan riittävä uni ja lepo turvataan läkehoidolla ja hoitotyön keinoilla ja unettomuuden syyt pyritään selvittämään ja poistamaan. Esimerkiksi epä mukava vuode, äänet, pelot, kipu, painajaisunet ja selvittämättömät asiat voivat aiheuttaa saattohoitopotilaalle unettomuutta.
- hygieniasta huolehtiminen. Hyvään hygieniaan kuuluvat puhtaus, hyvä suun hoito, ihon hoito, puhtaat ja raikkaat vaatteet ja vuodevaatteet sekä ympäristön siisteys.

- ➔ Elämän loppuvaiheen hoito, Hoitotahto, Palliatiivinen hoito, saattohoito, päätös elvyttämättä jättämisestä www.valvira.fi

ETENE. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. www.etene.fi/elaman_lopun_teenasta

Rukoushetki kuolevan luona www.evl.fi/kirkkokasikirja

- ➔ Anttonen, M-S. 2016. Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa Tampereen yliopisto. Väitöskirja. Johtopäätöksenä esitetään, että saattohoitoa tulee kehittää huomioimalla potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan muodostama kokonaisuus, jossa potilaan yksilöllinen saattohoito voi toteutua.

Terkamo-Moisio, A. 2016. Complexity of attitudes towards death and euthanasia. Itä-Suomen yliopisto. Suomalaiset sairaanhoitajat ja muu väestö asennoituvat kuolemaan neutraalisti. Kuolemaa pidetään luonnollisena osana elämää, jota ei voimakkaasti pelätä tai vältellä. Kuolema nähdään myös pakokeinoksi kärsimyksen täyhteisestä elämästä.



Älä pelkää, sinulla on lämpimät kädet
lämpimiin käsiin ota kylmenevät sormet
ei sinun muuta tarvitse tehdä
ole ihminen ihmiselle loppuun asti
Ei kuolema sinua vie, älä pelkää
ole kuolevan vieressä lämpimin käsin
älä yksin jätä
ei kuolema sinua vie
sinulla on lämpimät kädet

Kaija Sailo (Kuolevan potilaan hoito)

Vierihoitossa hoitaja on koko ajan potilaan lähellä, mikä lisää potilaan turvallisuuden tunnetta kuoleman lähestyessä. Vierihoido on todellista läsnäoloa, hoivaa ja huolenpitoa. Kuolevaa ei jätetä milloinkaan yksin, ellei hän sitä itse halua. Potilaan pitää voida olla varma siitä, ettei hänen tarvitse olla yksin ja että hänen vierellään on toinen ihminen kuoleman hetkellä. Potilas ei saa tuntea hylätyksi tulemisen pelkoa. Vierihoidon alku on hyvästä hoito- ja vuorovaikutussuhteesta, joka on ainutkertainen ja perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, välittämiseen ja turvallisuuteen. Kuoleman lähestyessä potilaan hoidossa korostuu hoitajan oma persoonallisuus. Kohtaamiseen vaikuttaa se, miten hoitaja itse on muodostanut suhteensa kuolemaan. Kuolevan potilaan kohtaamisen valmiudet kehittyvät kokemuksen myötä, ja työyhteisössä on tärkeää keskustella potilaan hoitoon ja kuoleman kohtaamiseen liittyvistä asioista. Lääkärin on oltaava mukana potilaan hoitamisessa loppuun asti, eikä läheisten ja omaisten tukemista saa unohtaa potilaan kuoleman jälkeen.

- ➔ Romppanen, M. 2011. Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä. Väitöskirja. Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset liittyvät ensimmäisessä harjoittelussa kuolevan potilaan vierihoidajana olemiseen yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Tilanteet ovat emotionaalisesti erittäin vaativia. Haasteita tuovat potilaan tilassa tapahtuvat muutokset, omaisten reagointi, opiskelijan oma epävarmuus ja pelko sekä kokemus ajan hitaasta kulumisesta.

Jos kuolevan potilaan omaiset eivät halua tai voi olla läsnä kuoleman lähestyessä, hoitotyöntekijällä on velvollisuus olla potilaan vierellä kuoleman hetkellä. Eri uskontokunnilla ja kulttuureilla on erilaisia kuolemaan liittyviä tapoja ja tottumuksia. Hoitotyöntekijöiden on selvitettävä ne keskustelemalla potilaan ja hänen läheistensä kanssa ja perehtymällä niihin eri lähteiden avulla.



Suositukses hyvästä saattohoidosta (STM 2011, mukailtu):

1. Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.
2. Saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus. Saattohoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa.
3. Hoitolinjauksista keskustellaan potilaan ja – jos potilas sen sallii – hänen omaistensa kanssa. Asiat kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan.
4. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava lääkäri. Lisäksi nimetään henkilöt, jotka vastaavat saattohoidosta vuorokauden eri aikoina. Potilaan hoidon jatkuvuus varmistetaan ja hoitoa arvioidaan jatkuvasti.
5. Hoitopäätökset perustuvat lääke- ja hoitotieteelliseen näyttöön sekä potilaan ja hänen omaistensa toiveisiin ja tarpeisiin. Saattohoito toteutetaan potilaan, hänen omaistensa ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä.
6. Lääkärit ja hoitajat ovat saattohoitoon koulutettuja, ja heiltä saa eri vuorokaudenaikoina konsultaatio- ja muuta tarvittavaa apua.
- Muu henkilökunta ja vapaaehtoiset työntekijät täydentävät osaltaan moniammatillista työryhmää. Työryhmälle tarjotaan saattohoitoon liittyvää säännöllistä täydennyskoulutusta, työnohjausta ja tarvittaessa jälkikäteen keskustelua saattohoitotilanteista.
7. Osaamisalueet saattohoidossa ovat kyky arvioida, hoitaa ja soveltaa tietoa systemaattisesti ja riittävin taidoin
 - kärsimykseen ja sitä aiheuttavien oireiden hoitamiseen
 - psykososiaalisiin, fyysisiin, henkisiin, hengellisiin, eksistentiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä niiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa
 - lähestyvän kuoleman merkkeihin ja kuoleman hetkeen
 - omaisten tukemiseen potilaan kuoleman jälkeen.
8. Saattohoitoa järjestävä hoitolaitos sitoutuu potilaan tarpeisiin ja toiveisiin, toiminnan hyvään laatuun ja Käypä hoito -suositusten noudattamiseen.

Kuoleman merkkien toteaminen

Kuoleman eli exituksen toteamista ja vaikutuksia koskevia säännöksiä sisältyy lakiin (459/1973) ja asetukseen (948/1973) kuolemansyyn selvittämisestä, asetukseen kuoleman toteamisesta (27/2004) sekä lakiin ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2009). Ihminen katsotaan kuolleeksi, kun kaikki hänen aivotointiansa on pysyvästi loppunut. Kuoleman toteaa aina viime kädessä lääkäri. Kuoleman toteaminen edellyttää aina hengityksen ja verenkierron loppu-

mista ja toissijaisten kuolemanmerkkien tunnistettavuutta. Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava sille lääkärille, jonka hoidossa potilas viimeisen sairautensa aikana oli, kuolinpaikan terveyskeskuksen lääkärille tai poliisille. Kuoleman todennut lääkäri huolehtii siitä, että kuolemansyyn selvittäminen käynnistyy. Jos kuolema on tapahtunut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä, lääkärin tulee todeta kuolema mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kuoleman toteamisessa noudatettavista menettelytavoista on toimintayksikkökohtaiset ohjeet, joihin hoitajan on perehdyttävä. Kun ihminen kuolee, hänen elin-

toimintonsa lakkaavat: sydämen ja aivojen toiminta loppuu, tajunta sammuu, ihminen ei reagoi kipuun, silmät eivät reagoi valoon ja hengitys lakkaa. Kuolemanmerkit jaetaan ensisijaisiin eli primaariin ja toissijaisiin eli sekundaarisiin.



Ensisijaiset kuolemanmerkit ovat

- sydämen toiminnan loppuminen: Syke ei tunnu, eivätkä sydänäänet kuulu stetoskoopilla kuunneltaessa. EKG:ssä näkyy vain suora viiva.
- hengityksen loppuminen: Hengityslihakset eivät toimi, eli rintakehä ei nouse eikä laske. Hengitysäänet eivät kuulu stetoskoopilla kuunneltaessa.
- kudostumien heikkeneminen ja lihasten veltostuminen: Muun muassa peräsuolen ja virtsarakon pidätyskyky lakkaa, eivätkä lihakset reagoi ärsykkeisiin.
- tunnottomuus: Potilas ei reagoi kipuun.
- heijasteiden eli refleksien sammuminen: Muun muassa lihasrefleksit ja venytys-, suoja-, iho- ja asentoheijasteet lamaantuvat, eikä sarveiskalvo reagoi esimerkiksi valoon tai kosketukseen.

Ihminen voidaan todeta kuolleeksi, kun hänen sydämensä on lakannut sykkimästä, toissijaiset kuolemanmerkit ovat ilmaantuneet ja hengitys ja verenkierto ovat pysähtyneet. Pelkkä sydämen toiminnan lakkaaminen ei siten vielä sinänsä merkitse kuolemaa.



Toissijaiset kuolemanmerkit ovat

- lautumien ilmaantuminen: Lautumat ovat iholle ilmaantuvia violetinpunaisia läiskä, jotka syntyvät, kun veri laskeutuu kehossa alaspäin, hemolysoituu ja imeytyy kudoksiin. Lautumat ilmaantuvat 15–20 minuttin kuluttua kuolemasta. Kuolleen kasvot ovat kalpeat ja vahamaiset.
- kuolonkankeus: Leukanivel ja niska jäykistyvät 2–4 tunnissa. Kaikki lihakset ja koko ruumis on kangistunut, kun kuolemasta on kulunut 6–8 tuntia. Kuolonkankeus häviää, kun kuolemasta on kulunut 3–4 vuorokautta. Kuolonkankeudesta voidaan tehdä päätelmiä vainajan kuolinajasta.
- ruumiin jäähtyminen: Ruumis jäähtyy noin 1 °C:n verran tunnissa, kunnes se saavuttaa ympäristön lämpötilan. Lämpötila ei ole mitattavissa tavallisella lämpömittarilla.
- ruumiin hajoaminen ja mätäneminen: entsyymit aiheuttavat kudosten hajoamisen ja suolistosta peräisin olevat bakteerit mätänemisen. Hajoaminen ja mätäneminen alkavat vatsaontelosta ja sisäelimestä.

Ihminen on kuollut, kun tilan ja olosuhteiden vaatimat hoito- ja elvytystoimenpiteet on suoritettu ja elintärkeät aivotoinnot ovat niistä huolimatta peruuttamattomasti sammuneet hengityksen ja verenkierron pysähtymisen seurauksena. Tällaisia tilanteita ovat ne, joissa verenkierto ei elvytyksestä huolimatta ole käynnistynyt tai joissa elvytykseen ei ole ryhdytty potilaan perussairauden, tilan tai hoidon aloittamisen viivästymisen vuoksi. Ihminen on kuollut, kun hänen aivotointinsa on pysyvästi loppunut. Jos potilaan sydän vielä sykkii aivotoinnin loputtua, hän on aivokuollut. Kuoleman toteaminen sydämen vielä sykkiessä edellyttää, että aivotointien loppumisen syy on selvitetty ja että lääketieteellisin tutkimuksin on todettu kaikkien aivohermovasteiden puuttuminen. Riit-

tävän monipuolisen asiantuntemuksen ja arvioinnin varmistamiseksi vähintään kahden lääkärin tulisi osallistua aivokuoleman toteamiseen. Tavallisesti kyseeseen tulevat neurologi ja anestesioologi.

Potilaan kuoleman toteamisesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Merkinnästä tulee ilmetä kuoleman toteamisen ajankohta ja kuolinaika. Potilasasiakirjoihin merkitään lisäksi kuoleman toteamiseksi tehdyt tutkimukset, niiden ajankohta, tulokset ja tekijä. Kuoleman toteamisaika ei ole aina sama kuin tarkka kuolinhetki. Erityisesti silloin, kun kuolema on johtunut onnettomuudesta tai vainaja löydetään myöhemmin, kuolinhetken ja kuoleman toteamisajan välillä saattaa olla pitkäkin aika. Silloin, kun sairauskertomuksesta tai kuolemantapaukseen liittyvästä muusta taustatiedosta voidaan päätellä luotettavasti kuolinhetki, se merkitään kuolinajaksi. Hoitolaitoksissa on erilliset ohjeet siitä, mitä asiakirjoihin merkitään, jos kuolinaika ei ole tiedossa tai potilas on aivokuollut.

Toimenpiteitä potilaan kuoleman jälkeen:

- Potilasasiakirjoihin kirjataan päivämäärä ja kellonaika, jolloin kuolema havaittiin, ja tiedot kuolleen viimeisistä hetkistä, kuolintavasta ja läsnäolijoista sekä läheisille tiedottamisesta.
- Lääkäri toteaa kuoleman kuuntelemalla vainajan sydäntä ja keuhkoja, tunnustelemalla vainajaa ja mahdollisesti kokeilemalla tämän refleksejä.
- Lääkärille on ilmoitettava potilaan kuolemasta heti, jos kuolemaa edelsi esimerkiksi lääkehoidon virhe tai trauma.
- Yllättävästä kuolemasta on aina ilmoitettava heti lääkärille.



Lisätietoja kuoleman toteamisesta:

valvira.fi. Kuoleman toteaminen

sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta 27/2004

Kuolevan potilaan läheisten tukeminen ja ohjaus

Kuolema on aina iso muutos läheisten elämässä, ja jokainen ihminen reagoi siihen omalla tavallaan. Potilaalle ja hänen läheisilleen on kuoleman läheistyessä annettava riittävästi henkistä ja hengellistä tukea. Hoitajan taas on luotava rauhallinen ja kiireetön ympäristö. Jos kuolevan potilaan omaiset ja läheiset haluavat pysyä mahdollisimman paljon hänen vierellä, heidän tukemiseensa, lepoonsa ja ravintoonsa on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Omaisille on pyrittävä järjestämään mahdollisuus ruokailla hoitolaitoksessa ja saada vuode potilaan vuoteen viereen. Tarpeen mukaan lääkäri voi määrätä myös läheisille unilääkettä tai rauhoittavaa lääkettä. Jos läheiset ovat halukkaita osallistumaan potilaan hoitoon, hoitajan on tuettava ja kannustettava heitä kaikin keinoin, mutta läheisiltä ei kuitenkaan voi edellyttää hoitotoimiin osallistumista. Tavoitteena on potilaan omien todennäköisten toiveiden toteuttaminen.

Hoitajan on varattava riittävästi aikaa keskusteluun potilaan läheisten kanssa. Keskustelujen sisältö tulee kirjata potilasasiakirjoihin, jotta kaikki hoitoon osallistuvat tietävät, millaisia keskusteluja läheisten kanssa on käyty. Sairaalateologi on myös omaisia varten. Hoitajan on tiedotettava potilaan läheisille mahdollisuudesta keskustella sairaalateologin kanssa. Näissä tapaamisissa kunnioitetaan jokaisen uskonnollista vakaumusta ja elämäntavasta, ja myös sairaalateologia sitoo vastuuvelvollisuus. Sairaalateologi voi olla tukena surussa ja jäähyväisten jättöhetkellä, ja hän voi pitää myös saattohartausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on käynnistetty erilaisia kriisiryhmiä (esim. akuuttikriisiryhmä, psykologinen jälkipuinti- eli debriefing-ryhmä ja purkukokous eli defusing), jotka antavat kriisihoitoa kuolleen läheisille ja tarvittaessa myös ammattihenkilöille. Monilla paikkakunnilla järjestetään läheisille sururyhmiä ja läheisten iltoja, joissa läheiset saavat mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja jakaa kokemuksiaan.

Omaiset ovat usein läsnä potilaan kuollessa. Ellei läheisiä ole kuolinhetkellä paikalla, potilaan kuolemasta on ilmoitettava heille viipymättä. Myös voinnin heikkenemisestä on ilmoitettava viipymättä. Odotetuissa kuolemantapauksissa potilasasiakirjoissa on merkintä siitä, kenelle kuolemasta ilmoitetaan, ja toisinaan läheiset voivat esittää ilmoittamiseen liittyviä erityistoiveita, kuten toiveita siitä, miten mahdollisesta yöllä tapahtuvasta kuolemasta ilmoitetaan. Hoitajan, joka ilmoittaa läheisille potilaan kuolemasta, on tarkoituksenmukaista perehtyä potilaan viimeisten tuntien kulkuun, koska hänen on osattava vastata läheisten kysymyksiin potilaan viimeistä hetkistä. Läheisille on yleensä tärkeää tietää, millainen kuolinhetki oli, kuten kuoliko potilas rauhallisesti, oliko hän tajuissaan ja kuka oli läsnä kuoleman hetkellä. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on ohjeet siitä, kuka ilmoittaa potilaan kuolemasta läheisille. Tavallisesti se on joko lääkäri tai sairaanhoitaja. Kuolemasta ilmoittavan on varattava aikaa keskusteluun, tarkkailtava myös läheisen vointia ja toimittava sen mukaan. Läheisille on myös kerrottava erilaisista auttavista puhelimista ja palveluista. Lisäksi heille on korostettava, että he voivat ottaa yhteyttä vainajaa hoitaneeseen osaston henkilökuntaan keskustellakseen mieltään askarruttavista asioista.



Mattila, E. 2011. Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalahoidon aikana. Väitöskirja..Sairaanhoitajat käyttävät potilaan ja perheenjäsenen tuen tarpeen tunnistamisessa sanallisia ja sanattomia vuorovaikutusmenetelmiä. Sairaanhoitajat pyrkivät kokonaisvaltaiseen potilaan ja perheenjäsenen yksilöllisen tilanteen ymmärtämiseen.

Vainajasta huolehtiminen

Vainajan hoitaminen kuoleman jälkeen on hänelle tehtävä viimeinen palvelus. Vainajaan suhdaudutaan aina arvokkaasti ja hänen vakaumustaan kunnioittavasti. Vainajaa hoidettaessa luodaan kiireetön ja mahdollisimman hiljainen ilmapiiri. Koväänistä ja asiaankuulumatonta puhetta

tulee välttää. Kuoleman jälkeen vainaja siirretään rauhalliseen huoneeseen. Osastoilla tulisikin olla jäähyväishuone vainajaa ja läheisiä varten. Hoitaja tarkistaa potilasasiakirjoista potilaan ja tämän läheisten toiveet kuolemanjälkeisestä hoidosta, ruumiinavauksesta ja hautaamisesta. Hoitoyhteisö voi myös kunnioittaa potilaan kuolemaa järjestämällä suruliputuksen.

Potilaan kuolemanjälkeisestä hoidosta käytetään käsitettä vainajan laitto. Kun potilas on todettu kuolleeksi, hänet siirretään rauhalliseen huoneeseen, kuten jäähyväishuoneeseen. Jos potilas on yhden hengen huoneessa, hänet voidaan laittaa myös omassa huoneessaan. Läheiset voivat halutessaan laittaa vainajaa tai olla läsnä vainajan laitossa. Tavallisesti vainajan laitossa on mukana kaksi hoitajaa, ja he käyttävät kertakäyttötarvikkeita. Hoitajat varaavat itselleen tarvittavat suojavaatteet (esiliina, suojatakki, suu-nenäsuojus) ja tehdaspuhtaat kertakäyttökäsineet. Hoitolaitoksissa on tavallisesti valmiita exitussettejä vainajan laittoa varten. Lisäksi varataan vuodepesu- ja suunhoitovälineet. Vainaja laitetaan hoitolaitoksen ohjeiden mukaan. Tarttuvaa tautia sairastaneen vainajan laitossa on tutustuttava yksikkökohtaisiin ohjeisiin ja noudatettava sairaalan hygieniaohteja. Vainaja pyritään laittamaan mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen ennen kuin kuolonkaikkeutta ilmaantuu. Vainajapussia käytetään, jos vainaja on sairastanut jotakin tartuntatautia.

Vainajan tavarat ja vaatteet luetteloidaan tarkasti. Vainajan henkilökohtaiset tavarat ja vaatteet säilytetään häntä hoitaneella osastolla, kunnes omaiset tulevat noutamaan ne. Kaikista vainajan vaatteista ja tavaroista tulee aina neuvotella omaisten kanssa. Likaisia ja rikkinäisiä vaatteita ei hävitetä ilman omaisten lupaa. Omaiset voivat jättää jäähyväiset vainajalle yhden hengen potilashuoneessa, erityisessä saattohoituhuoneessa tai muussa rauhallisessa paikassa. Jäähyväisten jättöön tarkoitettun huoneen sisustukseen tulee kiinnittää huomiota. Huoneessa on hyvä olla esimerkiksi virsikirja, Raamattu, sähkökynttilä ja kukkia. Paikka tulee järjestää kauniiksi, rauhalliseksi ja ihmisarvoa kunnioittavaksi. Jäähyväishuoneena ei

saa käyttää esimerkiksi kylpyhuonetta tai tutkimushuonetta. Omaisten kanssa tulee keskustella siitä, haluavatko he, että hoitaja on läsnä jäähyväisten jätön hetkellä, vai haluavatko he viettää jäähyväishetken keskenään. Papin läsnäolo on myös tavallista. Omaisille on annettava riittävästi aikaa jäähyväisten jättöön.



Kuva 17.7 Exitussetti

Vainajan laitossa tarvittavat välineet:

- vuodepesuun tarvittavat välineet
- kaksi isoa kertakäyttölakanaa
- kertakäyttöinen vainajan kuolinpaita
- kaksi sideharsorullaa
- harsotaitoksia ja teippiä
- saniteettivaippa
- kasvoliina
- tunnustusranneke ja -kortti

Vainajan laitto:

1. Älä paljasta vainajaa laittamisen aikana turhaan. Suhtaudu vainajaan arvokkaasti ja hänen vakaumustaan kunnioittaen.
2. Älä poista vainajalta kanyyleja, dreenejä, katetreja, intubaatioputkea tai muita hoitoon liittyviä välineitä. Sulje ne sen sijaan korkeilla. Infuusionestepussit letkustoineen, virtsankeräyspussit, dreeneritepussit jne. taas voidaan poistaa ja eritemäärät voidaan kirjata.
3. Poista vainajalta korut (ellei vainajan läheisten kanssa ole toisin sovittu).
4. Jätä tai aseta paikoilleen pestyt hammasproteesit ja muut puhdistetut proteesit (esim. silmäproteesi). Puhdista tarvittaessa suu ja rasvaa huulet.
5. Aseta vainaja selälleen kädet sivuille ja vuode vaakatasoon.
6. Huolehdi vainajan puhtaudesta ja pese kaikki näkyvä lika pois. Peitä erittävät haavat ja dreeniaukot puhtailla sideharsotaitoksilla.
7. Aja vainajalta tarvittaessa parta ja kampa hänen hiuksensa ja partansa.
8. Poista vainajan vuoteesta vuodevaatteet ja levitä tilalle puhdas kertakäyttölakana ja nostolakana. Pue vainajalle hänen tai hänen läheistensä toivomusten mukaan kertakäyttöinen kuolinpaita tai omat vaatteet.
9. Sulje vainajan suu luonnolliseen asentoon joko erityisellä leukatuella tai sitomalla sideharsosidoksella alaleuka yläleukaan päälle. Leuka saadaan myös normaaliin asentoon käyttämällä pientä päänalustynyä.



Yleensä vainaja on kuoleman jälkeen osastolla muutamia tunteja sairaalan ohjeiden mukaan, minkä jälkeen hänet kuljetetaan kylmähuoneeseen. Sairaaloilla on omat ohjeet ja käytännöt vainajan kuljettamisesta osastolta kylmähuoneeseen. Vainaja kuljetetaan katetuilla ruumispaareilla tai potilasvuoteesta lakanalla peitettynä. Kun vainajaa kuljetetaan ja siirretään esimerkiksi vuoteesta paareille, henkilökuntaa on oltava riittävästi kunnioittavan vainajansiirron suorittamiseksi. Vainaja voi-

daan luovuttaa ruumishuoneelta vasta hautausluvan saamisen jälkeen. Hautausluvan saa tavallisesti vainajaa viimeksi hoitaneelta lääkäriltä, ja organisaatioilla on ohjeet menettelyä varten. Tavallisesti hautaus toimisto tai omaiset yhdessä hautaus toimiston kanssa huolehtivat vainajan siirrosta ruumishuoneelta siunauskappeliin.

Jos potilas kuolee kotona, paikalle voidaan kutsua terveyskeskuslääkäri, jonka hoidossa potilas on viimeksi ollut, ja poliisi. Lääkäri tekee potilaal-



10. Sulje vainajan silmät ja aseta niiden päälle kostutetut harsotaitokset. Aseta vainajan kasvoille kasvoliina.
11. Sido vainajan nilkat tarvittaessa harsorullalla kevyesti yhteen.



12. Kiinnitä vainajan käteen tunnistusranneke ja jalkaan tunnistuskortti. Molemmissa tulee olla vainajan nimi, henkilötunnus ja kuolinaika, osaston ja sairaalan nimi sekä tieto mahdollisista vierasesineistä.



13. Levitä vainajan ja koko vuoteen päälle kertakäyttölakana. Lakanaan voidaan taittaa risti, niin että ristin poikkipuu tulee sydämen tasolle. Risti symboloi ylösnousemusta ja sovitusta. Toisinaan käytetään myös tarrakiinnitteistä irtonaista lakanan päälle kiinnitettävää ristiä. Ristiä ei kuitenkaan käytetä, jos se ei ole vainajan elämäkatsomuksen mukaista tai se ei kuulu hänen uskontoonsa tai kulttuuriinsa. Päälyslakanan yläpään voidaan taittaa kolme laskosta poikittain, mikä symbolisoi Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Näin toimimalla hoitaja voi samalla hiljaisesti itsekseen siunata lähtijän. Vainajan rinnalle voidaan myös asettaa kukkia.
14. Lopuksi omaiset ja henkilökunta voivat viettää vainajan luona hiljaisen vainajaa kunnioittavan hetken.
15. Vainajaa laitettaessa kertynyt pyykki ja välineet viedään asianmukaisesti pyykkiin, pesukoneeseen ja jäteastiaan. Hoitoympäristö siistitään.

le ulkoisen ruumiintarkastuksen ja vastaa kuoleman toteamisesta. Poliisi taas antaa luvan siirtää vainaja sairaalaan tai menee itse tapahtumapaikalle ja päättää, tarvitaanko oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta. Vainaja siirretään tähän tarkoitukseen rekisteröidyllä autolla.

Omaisien neuvominen kuoleman jälkeen

Hoitava lääkäri kirjoittaa **kuolintodistuksen**. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta, josta käy ilmi kuolemansyy. Ilmoitus kuolemasta menee virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy muun muassa seurakuntaan, Kelan toimistoon ja pankkeihin. Sairaala lähettää kuolintodistuksen suoraan siihen lääninhallitukseen, jonka toimialueella vainajalla oli viimeinen kotikunta. Hautausluvan antaa vainajaa viimeksi hoitanut osasto, ja se annetaan hautaustoimistolle tai hautausta hoitavalle omaiselle. Hautausluvan antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri.

Jos potilaan **kuolemannsyytä** on selvitettävä eikä se ole ilmeinen eli sairaudesta tai vanhuudesta johtuva, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus. Sen tekemiseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Lääketieteellistä ruumiinavausta ei tehdä, jos siihen ei saada lupaa omaisilta tai vainajalla on ollut kielteinen asenne ruumiinavausta kohtaan. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista ruumiinavauksen liittyvistä kustannuksista.

Oikeuslääketieteellinen tutkimus- ja **ruumiinavaus** tehdään poliisin pyynnöstä, kun kuolemannsyytä ei tiedetä, vainaja ei ole ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana lääkärin hoidossa tai epäillään, että kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tai kuolema on sattunut yllättäen. Oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta ei voi kieltäytyä. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista vastaa valtio. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen hautausluvan, kuolintodistuksen ja ilmoituksen väestötietojärjestelmään tekee aina ruumiinavauksen tehnyt läänioikeuslääkäri. Omainen saa myös kuoleman-



Lähiomaisia pitää ohjata muun muassa seuraavissa asioissa:

- **hautausavustus:** Esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja valtion palveluksessa olleen vainajan omaiset voivat hakea vainajan edellisiltä työnantajilta hautausavustusta, jota myönnetään tietyin ehdoin. Varattoman vainajan hautauskuluihin voi anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalipalvelutoimistosta.
- **perhe-eläke:** Lakisääteisen perhe-eläketurvan tarkoituksena on turvata lähiomaisen toimeentulo perheen huoltajan kuollessa. Sitä haetaan vainajan viimeisen työnantajan työeläkelaitokselta.
- **ryhmähenkivakuutus:** Työntekijän ryhmähenkivakuutuksia voi tiedustella vainajan työnantajalta.
- **yksityinen henkivakuutus:** Jos vainajalla on ollut yksityinen henkivakuutus, omaiset ottavat yhteyttä vainajan vakuutusyhtiöön.
- **sairaalan hoitomaksu:** Maksuajoista ja maksukattoon liittyvistä asioista saa tietoa sairaalan potilastoimistosta, osastolta tai sosiaalihoitajalta.
- **perunkirjoitus:** Kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus, minkä jälkeen taas kolmen kuukauden kuluessa on toimitettava perunkirja verotoimistoon. Perunkirjoituslomakkeita saa kirjakaupoista ja hautaustoimistoista. Tarvittaessa perunkirjoituksessa voi käyttää apuna muun muassa lakitoimistoa, pankkeja tai oikeusaputoimistoa.
- **sururyhmät:** Seurakunnissa toimii seurakunnan työntekijöiden ohjaamia sururyhmiä, joissa läheisensä menettäneen voivat tavata toisiaan ja jakaa kokemaansa yhdessä. Seurakunnan työntekijät ovat myös käytettävissä luottamuksellisia sielunhoidollisia keskusteluja varten.

syyn selvittämislomakkeen, jolla hän voi tilata kuolintodistuksen ja lausunnon lääninhallitukselta.

Hautaukseen liittyvissä asioissa hautaustoimistosta saa monenlaista apua. Hautaustoimistolle pitää esittää hautauslupa. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta ja siirrosta kappeliin. Hautaustoimisto ottaa myös omaisten niin toivoessa yhteyden seurakuntaan ja varaa siunaustilaisuutta varten kappelin tai kirkon, sopii papin kanssa siunausajan ja varaa hautapaikan. Lisäksi hautaustoimiston kanssa voidaan sopia lehteen lähetettävästä kuolinilmoituksesta, sen sisällöstä ja muodosta. Myös muistotilaisuuden järjestelyn voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi. Omaiset voivat halutessaan myös hoitaa itse kaikki mainitut tehtävät. Jos omaiset järjestävät hautaamisen itse, heitä ohjataan ottamaan yhteys vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Hautaustoimiston kanssa voidaan sopia myös hautaukseen liittyvien tehtävien jakamisesta omaisten ja hautaustoimiston kesken. Hautaustoimistopalve-

lut ovat maksullisia. Osastolta annetaan kirjallisia ohjeita hautajaisvalmisteluihin ja muihin kuolemaan liittyviin asioihin. Sosiaalihoitajalta omaiset saavat ohjeita vainajan ja omaisten raha-asoiden hoitoon.

-  Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen: Kotihoidossa olevan aikuisen saattohoitopotilaan omaishoitajan kuormittuminen. www.hotus.fi
Käypä hoito -suositus. 2018. Kuolevan potilaan nielemisvaikeuden hoito. Duodecim. Ari Matila & Juha Saarnio
Käypä hoito -suositus. 2018. Neuropaattisen syöpäkivun hoito. Duodecim. Harri Tohmo
Terveyskylä.fi Mitä on vertaistuki?www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki
Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitotyön suositus 2018. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. Saatavilla www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus/

18

Hoidon ja jatkohoidon koordinointi

Tässä luvussa

- Tukipalvelut
- Jatkohoitopaikat
- Jatkohoidon järjestäminen
- Moniammatillinen yhteistyö
- Jatkohoidon suunnitelma



Potilastiedon arkisto eli **Kanta-palvelu** on terveydenhuollon tietojärjestelmä. Kanta-palveluun terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Palvelussa on mahdollista sähköisten potilastietojen arkistointi ja pitkäaikainen säilyttäminen. Kantapalveluun voi jokainen suomalaisia terveydenhuoltopalveluita käyttävä henkilö kirjautua omilla pankkitunnuksillaan. Palvelussa on nähtävissä omia terveystietoja.

Hoitoajat ovat lyhentyneet, mikä on luonut uusia haasteita ja vaatimuksia jatkohoidon suunnittelun ja terveystietojärjestelmän kannalta. Tavoitteena on, että kotiutuminen on prosessina sujuva, saumaton ja oikea-aikainen. Tämä edellyttää hoitopolun ja palvelu- ja hoitoketjujen saumattomuutta eli moitteetonta moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. **Tiedonkulun** tulee olla ajantasaista.

18.1 Hoitotyön jatkohoidon suunnitelman laatiminen

Potilaan jatkohoidon suunnitelma laaditaan aina, kun potilas siirtyy kotiin, kotisairaanhoidoon, kotisairaalaan, toiseen sairaalaan tai muuhun hoitoyksikköön. Lisäksi se laaditaan, jos potilas siirtyy saman hoitolaitoksen sisällä toiseen yksikköön. Jatkohoidon suunnitteleminen ja hoitosuhteen päättäminen ovat aina tavoitteellista ja suunnitelmallista hoitotyötä ja potilaan jatkohoidon turvallisuuden ja laadun perusta. Potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkohoitoa suunniteltaessa.

Lääkäri kotiuttaa potilaan ja päättää tämän siirtämisestä toiseen sairaalaan tai hoitolaitokseen. Hoitotyöntekijöiden tehtävänä on suunnitella jatkohoito **yksilöllisesti ja potilaslähtöisesti** ja huolehtia siirtoon liittyvistä toimista. Jatkohoitosuunnitelmaan vaikuttavat potilaan elämäntilanne, elämänvaihe, sairauden aste ja tuleva ympäristö. Hoitojakson päättyessä lääkäri laatii potilaasta hoitoyhteenvedon ja loppuarvioinnin eli epikriisin, joka on lyhyt ja arvioiva yhteenvedo potilaasta jatkohoitopaikkaan. Hoitotyöntekijä laatii jatkohoidon suunnitelman.



Jatkohoitosuunnitelma voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

- potilaan henkilötiedot
- omaisten yhteystiedot
- hoitoon tulon syy ja voinnissa tapahtuneet muutokset
- potilaan jokapäiväisten toimintojen toteutuminen, esimerkiksi liikkuminen, syöminen, erittäminen ja aistitoiminnot
- yhteenvedo potilaalle annetusta hoidosta
- hoitojakson keskeiset tapahtumat, esimerkiksi erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet, ja potilaalle ja hänen omaisilleen tai läheisilleen annettu neuvonta ja ohjaus
- lääkehoito ja sen toteuttaminen hoitojakson aikana
- potilaan mieliala ja tunteet hoitojakson aikana
- potilaan vointi ja seurantatiedot
- arviointi hoidon tavoitteista
- potilaan ja mahdollisesti omaisten tai läheisten näkemys potilaan hoidosta.

Jatkohoidon suunnitelmaan on monia eri malleja, ja sen sisältö riippuu potilaan voinnista ja jatkohoitopaikasta. Suunnitelma tehdään joko sähköisesti tai paperille.

Jatkohoitopaikan henkilökunta saa suunnitelman perusteella yleiskuvan potilaan tilanteesta ja hoidoista. Jatkohoidon järjestämisestä koskevat tiedot käsittävät potilaan jatkohoidon syyn, jatkohoitopaikan, palvelualan ja palvelut. Jatkohoidon suunnitelman lisäksi lähettävän osaston tai organisaation henkilökunta soittaa vastaanottavan organisaation henkilökunnalle. Tästä syntyy hoitokeskustelu, jossa potilaasta ja hänen voinnistaan voidaan esittää kysymyksiä ja saada vastauksia.

Potilastietojen luovuttaminen toiseen hoitolaitokseen tai toiseen hoito-organisaatioon edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksella tarkoitetaan potilaalle annettuun riittävään tietoon



Hoitotyön yhteenvedossa käsitellään

- potilaan tulotiedot, henkilö- ja taustatiedot sekä hoitopaikka
- hoidon suunnittelu eli hoidon tarve
- hoidon toteutus eli hoidon toiminnot
- hoidon arviointi eli hoidon tulokset ja potilaan jatkohoito.

perustuvaa vapaaehtoista, yksilöityä tietoista tahdonilmaisua, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen tulee olla allekirjoitettu omakätisesti tai sähköisesti. Potilaan luvalla sairaalasta toimitetaan lähettäneelle lääkärille yhteenveto sairauden hoidosta ja jatkohoitotarpeesta. Suullisella suostumuksella voidaan toiselle terveydenhuollon palvelujen antajalle luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja, yhteenveto annetusta hoidosta ja ne haketiedot, joita potilas ei ole kieltänyt luovuttamasta. Kirjallisesta suostumuksesta laaditaan suostumusasiakirja, ja suullisesta suostumuksesta tulee merkintä potilasrekisteriin.

Hoitotyöntekijä laatii jatkohoidon suunnitelmaan hoitotyön yhteenvedon hoitoprosessin mukaisesti.

18.2 Jatkohoidon ja kontrollikäyntien järjestäminen

Jatkohoidon järjestämistä koskeviin tietoihin merkitään tieto hoitotahdon olemassaolosta ja potilaan mukana olevista arvoesineistä sekä tieto siitä, että potilaan omaisille on kerrottu jatkohoitoon siirtymisestä. Monien sairauksien hoito edellyttää potilaalta kontrolli- eli seurantakäyntejä erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. **Kontrollikäynnit** voivat olla joko kertaluonteisia tai toistuvia. Tyypillinen kertaluonteinen kontrollikäynti tehdään jonkin leikkauksen jälkeen. Tällaisissa

tapauksissa käynnistä käytetään usein nimitystä **jälkitarkastus**.

Yhteistyössä potilaan kanssa selvitetään, kuka varaa ajan kontrollikäynnille tai jälkitarkastukseen. Ajanvarauksen voi hoitaa sairaala tai hoitolaitos tai potilas tai hänen omaisensa. Jos kontrollikäynnille tarvitaan lähete (esim. röntgentutkimukseen), on selvitettävä, kuka kirjoittaa sen ja tehdäänkö se sähköisenä paperisena lähetteenä. Potilaan, hoitolaitoksen ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että kontrollikäynnit ovat hyvin valmisteltuja. On tärkeää varmistaa, että kaikki käynnillä tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja ajantasaisia. Näin vältetään potilasta kuormittavilta turhilta ja yhteiskunnan kannalta kalliilta kontrollikäynneiltä.

Sote-uudistus tuo mukanaan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskukset eli sote-keskukset. Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa asikkaan valinnanvapautta. Asiakas voi nykyistä vapaammin valita sosiaali- ja terveyskeskukseen, jossa asioi.

Terveyskeskuksissa on palveluyksiköitä ja lääkärijohtoisia yksiköitä. Esimerkkejä lääkärijohtoisista yksiköistä ovat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, ajanvaraus- ja päivystysvastaanotot ja terveyskeskusten vuodeosastot. Terveyskeskuksen sairaalassa hoidetaan potilaat, jotka tarvitsevat sairaalahoittoa mutteivät erikoissairaanhoitoa. Potilaat voivat olla joko pitkäaikaispotilaita tai akuutisti sairastuneita.

Kotisairaanhoito antaa terveyspalveluita kotiin sairaille, jatkohoidon tarpeessa oleville ja vammaisille. Kotisairaanhoito auttaa potilasta asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Terveyskeskuksen kotisairaanhoito on lääkärijohtoisia. Potilas saa terveyskeskuslääkäriltä tai sairaalasta lähetteen kotisairaanhoitoon, johon on kirjattu hoidon tarve ja tavoitteet. Kotisairaanhoito luo potilaalle yhteyksiä erilaisiin kotona asumista tukeviin palvelukokonaisuuksiin, esimerkiksi apuvälinelainaamoihin, ateriapalveluihin ja kotipalveluun.

Neuvola on terveydenhuoltopalvelu, jonka tavoitteena ovat väestön ja yhteisön terveyden edistäminen ja terveysongelmien ehkäisy. Neuvolat tu-

kevat syntymättömien ja alle kouluikäisten lasten perheitä ja seuraavat lasten kehitystä. Neuvoloita ovat myös esimerkiksi ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola. Neuvoloissa järjestetään terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, erilaisia ryhmävalistustilaisuuksia ja joukkotarkastuksia. Neuvolat ohjaavat asiakkaita itsehoidossa ja seuraavat heidän terveydentilansa muutoksia.

Kunnissa järjestetään **päiväkeskuspalveluita** arkipäivisin. Palvelut on tarkoitettu erityisesti vanhuksille, pitkäaikaissairaille sekä päihde- ja mielen-terveysasiakkaille. Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on tukea näiden asiakasryhmien kotona asumista ja heidän omaistensa jaksamista. Tyypillisiä päiväkeskuspalveluita ovat viriketoiminta, kuntouttava toiminta, sosiaalisten kontaktien tukeminen ja ruokailu- ja peseytymispalvelut.

Kunnalliset **kotipalvelut** auttavat asiakasta, kun hän tarvitsee sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin päivittäisistä toimita selviytymiseksi. Kotipalvelussa hoiva- ja hoitotyöntekijät seuraavat asiakkaidensa vointia ja kotona selviytymistä ja neuvovat eri palveluihin liittyvissä asioissa. Tyypillisiä kotipalvelun palveluita ovat asiointiapu, hygieniapalvelut, lääkkeiden jakaminen ja ruoanlaitto. Ateriapalvelut voidaan järjestää tuomalla ateriat kotiin lämpiminä tai jäädytettynä tai tarjoamalla ateriointimahdollisuus palvelutaloissa tai muissa kunnan toimipisteissä (esim. päiväkodeissa).

Laboratoriossa otetaan ja tutkitaan näytteitä, jotka lääkäri tai sairaanhoitaja on pyytänyt potilaasta. Laboratorioon päästäkseen potilas tarvitsee lääkärin tai hoitajan tekemän lähetteen. Ainoastaan HIV-testiin voi hakeutua ilman lähetettä ja nimettömästi. Laboratoriot voivat toimia joko ilman ajanvarausta tai ajanvarauslaboratorioina. Kuvantamisyksikössä tehdään monenlaisia potilaan hoitoon liittyviä tutkimuksia. Röntgentutkimuksiin tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete ja kuvantamisyksikön toiminnasta vastaa röntgenlääkäri eli radiologi.

Tukihenkilöt ovat tavallisesti vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan vaikeissa elämäntilanteissa olevien lähimmäisten

kanssa. Tukihenkilö sitoutuu pitämään tuettavansa asiat luottamuksellisina. Tukihenkilöllä on aina taustallaan järjestö tai viranomainen, joka saattaa tukihenkilön ja tuettavan yhteen. Tukihenkilötoiminnassa sosiaalinen toiminta ja kanssakäyminen ovat tärkeitä. Tukihenkilöiden tärkeänä tehtävänä on kuuntelemalla ja keskustelemalla saada luottamuksellinen ja turvallinen yhteys tuettavaan. Tukiperhe tekee vapaaehtoistyötä tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden kanssa. Tällaisia tilanteita lapsiperheissä saattavat olla esimerkiksi avioero, yksinhuoltajuus, sairastuminen ja vanhempien päihdeongelmat. Lapset vierailevat tukiperheessä säännöllisesti esimerkiksi viikonloppuisin. Tukiperhe saa koulutuksen tehtävänsä.

Potilasjärjestöt ovat kolmannen sektorin toimijoita. Potilasjärjestöjä on Suomessa runsaasti. Niitä ovat esimerkiksi syöpäjärjestöt, Parkinsonliitto, Sydäntautiliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Hengitysliitto Heli, Vanhustyön keskusliitto ja SLE-yhdistys. Potilasjärjestöjen toimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) varoilla, ja niiden tarjoamat palvelut ovat joko maksullisia tai maksuttomia. Potilasjärjestöt järjestävät koulutusta, tiedotus- ja julkaisu-toimintaa sekä kuntoutus- ja virkistyspalveluja ja tekevät tutkimus ja kehittämistyötä. Vertaistukiryhmiä pitää aina koulutettu ohjaaja.

Omaiset hoitavat usein pitkäaikaissairasta, vaikeavammaista lasta tai vanhusta kotona. Tällöin kunta maksaa omaishoitajalle omaishoidon tukea. Toimintaa ohjaa laki omaishoidon tuesta. Laki edellyttää omaisen ja kunnan solmimaa omaishoitosopimusta, johon liittyy hoito- ja palvelusuunnitelma. Laki edellyttää kuntia järjestämään omaishoitajille vapaaviikonloppuja ja päivävapaita, jolloin he voivat palautua raskaasta hoitamisesta. Kunta järjestää myös hoidon tukemiseksi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yhteiskunnan tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan jakaa julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin. Yksityinen palveluntuotanto täydentää julkista palveluntuotantoa, ja kunnat voivat ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta lakisääteisiä palveluita kuntalaiselle. Kolmannen sektorin palvelut täydentävät julkisia

ja yksityisiä palveluita, ja ne ovat yleensä vapaaehtoisuuteen perustuvia. Keskeisin palvelumuodoista on kirkon tarjoama **diakoniatyö**. Siinä on mukana seurakunnan työntekijöitä ja aktiivisia vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Nykyisin kirkon merkitys sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäjänä on suuri ja seurakunnat kouluttavat itse vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Diakoniatyössä annetaan hoitotyön lisäksi myös sielunhoitoa. Kirkko pitää yllä perheasiain neuvottelukeskusta, jonka palvelut ovat maksuttomia. Neuvottelukeskus auttaa aikuisia ihmissuhdeongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Merkittävä palvelumuoto on Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä **palveleva puhelin**. Se on toiminnassa lähes ympärivuorokautisesti, ja siihen voi soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Puhelin tarjoaa keskustelua apua elämän vaikeissa tilanteissa.

18.3 Jatkohoitoon liittyvä ohjaus

Riittävän ajoissa aloitettu jatkohoidon suunnittelu edistää merkittävästi potilaan jatkohoidon ja kotiutumisen onnistumista. Monet eri ammattiryhmät antavat potilaalle ohjausta, ja erityisesti hoitolaitoksesta toiseen tai kotihoitoon siirryttäessä tiedon määrä lisääntyy. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että **suullisesti annettun ohjauksen** lisäksi potilas voisi palata ohjeisiin myöhemmin esimerkiksi sähköisesti. Ennen potilaan kotiutumista tai siirtymistä toiseen hoitolaitokseen lääkäri ja hoitohenkilökunta antavat sairauden hoitoon liittyvät ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. **Kirjalliset hoito-ohjeet** käydään aina suullisesti potilaan kanssa läpi ja varmistetaan, että potilas on ymmärtänyt ne. Potilaalle tulee varata riittävästi aikaa hoito-ohjeisiin perehtymiseen, jotta hän ehtii tehdä epäselvistä kohdista kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Hoito-ohjeissa tulee olla osaston tai sairaalan yhteystiedot, jotta potilas voi aina kääntyä henkilökunnan puoleen ja varmistaa hänelle epäselvät asiat.

Sairaalassaoloajat ovat lyhentyneet, ja potilaat kotiutuvat yhä huonokuntoisempina. Jo tämän vuoksi **kotiutuksen onnistumisen merkitys** potilaalle ja yhteiskunnalle on korostunut. Potilaan

jatkohoitoa valmisteltaessa tulee keskustella potilaan ja tarvittaessa myös hänen omaistensa kanssa. Keskustelussa selvitetään jatkohoidon tarve ja mahdollisuudet ja suunnitellaan yhdessä tarvittava ohjaus, siirtyminen ja kuljetus. Kun potilas siirtyy **toiseen hoitolaitokseen**, hänelle ja hänen omaisilleen tulee kertoa siirrosta. Lisäksi siirrosta tulee sopia vastaanottavan hoitolaitoksen kanssa ja järjestää tarkoituksenmukainen kuljetus. Ennen siirtoa tarkastetaan, että potilas on siirtokunnossa. Jos hänellä on vaippa, tarkistetaan, että se on puhdas. Mahdolliset likaiset sidokset vaihdetaan puhtaisiin. On tärkeää huolehtia, että potilas saa mukaansa kaikki henkilökohtaiset tavaransa ja paperinsa (lähetteet ja epikriisit). Siirron ajankohta tulee suunnitella niin, että potilas ehtii ruokaila ja saa päivän lääkkeet, ellei ruokailulle ja lääkkeidenotolle ole estettä. Potilasasiakirjoihin merkitään tiedot potilaan siirtymisestä toiseen hoitolaitokseen.

Kotiinlähtöpäivänä kerrataan potilaan kanssa hoito-ohjeet, varmistetaan jatkohoito, varataan tarvittavat kontrollikäynnit ja sovitaan tarvittavista yhteydenotoista. Potilaan kanssa käydään läpi reseptit, todistukset (esim. sairauslomatodistus), hoito- ja tutkimusmääräykset (esim. verikokeet) ja Kelan matkakorvausmääräykset. Potilaalle annetaan ohjeet jatkohoidosta, tarvittavista jatkotutkimuksista ja niihin valmistautumisista. Kotiin lähtiessään potilas saa mukaansa kaikki henkilökohtaiset tavaransa ja hoitoon liittyvät asiakirjat (esim. röntgenkuvat ja lääkemääräykset), jotta hän on tuonut mukanaan sairaalaan. Potilaalle annetaan **kirjallisena osaston yhteystiedot**, jotta hän voi tarvittaessa ottaa vointiinsa liittyvissä asioissa yhteyttä osastoon. Potilasta kannustetaan ottamaan yhteyttä, jos hänen voinnissaan tapahtuu muutoksia.

Kotiutukseen liittyvää ohjausta potilaalle antavat muun muassa lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Kaikkien potilaiden ja erityisesti yksinasuvien osalta on varmistettava, että potilas voi palata kotiin turvallisesti. Kotona pitää olla ruokaa ja tarvittavat lääkkeet, ja kodin pitää olla lämmin ja siisti. Potilaan kotiutuessa otetaan tar-

vittaessa yhteyttä hänen omaisiinsa tai läheisiinsä. Jos heitä ei ole tai he eivät voi auttaa potilasta (esim. pitkän välimatkan vuoksi), hoitotyöntekijän velvollisuutena on hyvän kotiutumisen takaamiseksi ottaa yhteyttä **sosiaali- ja terveydenhuollon** erilaisiin **tukipalveluihin**.

Kotiutuminen sairaalasta on yhteistyötä potilaan, hänen läheistensä ja ammattihenkilöiden kesken. Kasvokkaiset hoitoneuvottelut ovat tehokas yhteistyö- ja vuorovaikutustapa. Yhteistyötä, riittävää tiedonkulkua ja vuorovaikutusta tarvitaan potilaan tai omaisen ja hoitohenkilökunnan välillä, henkilökunnan välillä sairaalassa ja sairaalahenkilökunnan ja kotihoidon välillä. Jos kotiutuva potilas ei pysty kaikilta osin huolehtimaan itsestään, on tärkeää, että omaiset saavat riittävästi tietoa ja ohjausta potilaan sairaudesta, toipumisesta, levosta ja liikunnasta, lääkityksestä, kivunhoidosta sekä jatkohoidosta. Omaisten ja läheisten tulee tietää, keneen he voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä potilaan vointiin liittyvissä asioissa. Tämä lisää sekä potilaan että hänen läheistensä turvallisuuden tunnetta. Hoitotyöntekijöiden arviointiin kuuluu myös sen arviointi, miten mahdollinen omainen tai läheinen kykenee avustamaan potilasta fyysisesti tai tukemaan sosiaalisesti.

- Aalto, K. & Gothoni, R. 2009. Ihmisen lähellä. Hengellisyys hoitotyössä. Kirjapaja, Helsinki.
- Aarnio, A. 2005. Täydennyskoulutus terveydenhuollossa. Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/2005. Tehy ry, Helsinki.
- Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. 2010. Monikulttuurinen hoitotyö. WSOYpro Oy, Helsinki.
- Aho, A. 2009. Hoitotietojen kirjaamisen etiikka. Sairaanhoidaja 12, 38–39.
- Ahonen, A. & Helenius V. 2013. Neurokirurgisen potilaan tajunnantasoon vaikuttavat tekijät ja tajunnantasoon tarkkailu. Tietotesti sairaanhoitajille. Laurea ammattikorkeakoulu.
- Ahonen, J. 2011. Iäkkäiden lääkehoito – Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Ahtiala, M. 2011. Jackson/Cubbin-painehaavariskin arviointimittarin käyttö TYKS:n aikuisten teho-osastolla. Tehohoito 2.
- Alahuhta, S., Alakokko, T., Kiviluoma, K., Perttilä, J., Ruokonen, E. & Silfvast, T. 2006 Nestehoito. Duodecim, Helsinki.
- Althen, G. 1994. Learning Across Cultures. Nafsa Association of International Educators, USA.
- Anttila, V.-J. 2008. Sairaalahygienian seitsemän haastetta. Suomen sairaalahygienialehti 1, 13–5.
- Anttila, V.-J., Kanerva, M., Kuronen, M., Kurvinen, T., Lyytikäinen, O., Rantala, A., Vuento, R. & Ylipalosaari, P. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Arifulla, D., Ollgren, J., Veltheim, J. & Lyytikäinen, O. 2017. Infektioiden torjunta suomalaisissa akuutissairaloissa. Suomen sairaalahygienialehti 35, 237–238.
- Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2014. Ravitsemustiede. Duodecim, Helsinki.
- Arvola, P. & Vuorihuhta, M. 2010. MRSA-torjuntahanke. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 1/2011.
- Aston, L., Wakefield, J. & McGown, R. (toim.) 2011. The Student Nurse Guide to Decision making in Practice. McGraw-Hill Companies, UK.
- Bachmann, M. & Haanpää, M. 2008. Krooninen kipu. Duodecim 124, 142–5.
- Barker, J., Linsley, P. & Kane, R. 2016. Evidence-based practice for nurses & healthcare professionals. Sage publ., Los Angeles.
- Beairisto, B. 1996. Professional Growth and Development: What is it and how do we know if it's working? Teoksessa P. Ruohotie & P. Grimmet (toim.): Professional Growth and Development: Directions, Delivery and Dilemmas. University of Tampere and Simon Fraser University.
- Braun, T. Lynne. 2012. People with hyperlipidemia who followed a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods achieved a greater reduction in LDL cholesterol over 6 months than those who received advice to follow a low-saturated fat diet. Evidence-Based Nursing 15 (2), 57–8.
- Brooker, C. & Nicol, M. (toim.) 2003. Nursing adults. The practice of caring. Mosby, Toronto.
- Brunou, S. 2009. Sairaanhoidajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat. Väitöskirja. Turun yliopisto, Turku.
- Bullpitt, H. & Deane, M. (toim.) 2009. Connecting Reflective Learning, Teaching and Assessment. Health Sciences & Practice Centre Higher Education Academy, London.
- Burns, S. & Bulman, C. 2000. Reflective Practice in Nursing. The Growth of the Professional Practitioner. Blackwell Science, Edinburgh.
- Campbell, F. A. & Burchinal, M. R. 2008. Early childhood interventions: The Abecedarian project. Teoksessa P. C. Kyllonen, R. D. Roberts & L. Stankov (toim.), Extending intelligence: Enhancement and new construct, 51–70. Routledge, New York.
- Christie, J. 2013. Swedish nursing students report that campus education supports research utilisation more than clinical education, but support varies between universities. Evidence-Based Nursing 16 (1), 29–30.
- Conoxia®, lääkkeellisen hapen käyttöopas. 2018. Linde Healthcare. http://www.linde-healthcare.fi/fi/images/Conoxia%20ka%CC%88ytto%CC%88opas%202018%20%28compr%29_tcm633-116875.pdf
- Diabetesliitto. 2012. Jalkojen terveys. Saatavilla osoitteesta http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/lisasairaudet/jhttp://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/lisasairaudet/jalat/
- Donnelly, P. L. 2000. Ethics and cross-cultural nursing. Journal of Transcultural Nursing 11 (2), 119–126.

Duttey, J. Kiyan. 2013. Greater intake of Western fast food among Singaporean adults is associated with increased risk of diabetes and heart-disease-related death. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 25–6.

Effective practitioner, Clinical decision making. NHS Education for Scotland. Saatavilla osoitteesta www.effectivepractitioner.nes.scot.nhs.uk

Elo, S., Saarnio, R. & Isola, A. 2013. Hoitajien näkemyksiä muistisairaana fyysisestä hoitoympäristöstä. *Tutkiva hoitotyö* 11 (3), 17–25.

Elomaa, L. & Mikkola, H. 2010. Näytön jäljillä – Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. *Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja* 12, 5., uud. painos. Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Eloranta, S. & Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2014. Toiteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. *Hoitotiede* 26 (1), 65–73.

Eloranta, S., Vähätalo, M., Rasmus, M., Elomaa, L. & Johansson, K. 2010. Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. *Tutkiva hoitotyö* 1, 4–11.

European Pressure Ulcer Advisor Panel 2004. Nutritional guidelines for pressure ulcer prevention and treatment. Saatavilla osoitteesta www.epuap.org.

Fagerström, V. 2009. Potilasnostimien toimivuus vanhustenhuollossa ja apuvälineiden käytön tukeminen. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Turku.

Fagerström, V. & Tamminen-Peter, L. 2009. Potilas-siirtojen ergonomiakortti – keino lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Työterveyslaitos. Saatavilla osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/1274.

Fagerström, V. & Tamminen-Peter, L. 2010. Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä. *Hoitotiede* 2.

Fernández, M. M., Herrero, M. I. P., Manzanares, E. G., Rodríguez, S. L. & Serrano, J. L. C. 2016. Nursing intervention: Stoma marking. *The World Council of Enterostomal Therapists Journal* 1, 17–22.

Furnham, A. & Bochner, S. 1986. *Culture Shock. Psychological reactions to unfamiliar environments.* Routledge, London.

Gerlander, M., Kivinen, T., Isotalus, P. & Kettunen, T. 2013. Potilaan osallistuminen lääkehoidosta keskustelemiseen. *Tutkiva hoitotyö* 11 (2), 14–22.

Giger, J. & Davidhizar, R. 2002. The Giger and Davidhizar transcultural assessment model. *Journal of Transcultural Nursing* 13(3), 185–8.

Grenshaw, J. T. & Champion, J. D. 2013. Newly graduated Swedish nurses show a trend for increasing research use in the 5 years following qualification, with the trend after the second year. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 27–8.

Gustafsson, M.-L., Leino-Kilpi, H. & Suhonen, R. 2009. Yksilöllistä hoitoa edistävät tekijät – hoitohenkilöstön näkökulma. *Tutkiva hoitotyö* 4, 4–11.

Haapasaari, M. 2009. Osastolla huollettavat välineet: desinfektio vai pesu? *Suomen Sairaalahygienialehti* 26.

Haavisto, E. 2017. Terveysthuollon ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen akateemisenä kumppanuutena. *Tutkiva hoitotyö* 15 (2), 41–42.

Haaramo, P. 2014. Insomnia, ill health and work disability: a longitudinal study among employees. *Väitöskirja. Helsingin yliopisto.*

Haglund, B., Huupponen, T., Ventola, A.-L. & Hakala-Lahtinen, P. 2011. Ihmisen ravitseminen. WSOY, Helsinki.

Hagström, K., Alanko, C., Lähdesmäki, I. & Hantikainen, V. 2014. Kinestetiikka tehohoitopotilaan kuntoutuksessa. *Tehohoito* 2014, 31 (1).

Haho, A. 2006. Hoitamisen olemus. Hoitotyön historiasta, teoriasta, tulkinnasta hoitamista kuvaaviin teoreettisiin väittämiin. *Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu.*

Hakkarainen, P. 2017. Type 1 diabetes and work. Publication of the university of Eastern Finland. Dissertations in health sciences 437. Pysyvä linkki julkaisuun <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2642-5>

Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. *Geriatría – arvioinnista kuntoutukseen.* Edita, Helsinki.

Hautero, U. 2017. Raskauden aikainen ravitseminen ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja kehitykselle. *Väitöskirja. Turun yliopisto.*

Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesin hoito. *Suomen Hammaslääkärilehti* 2003:6, 270–6.

Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. *Geriatría. Arvioinnista kuntoutukseen.* Edita Prima Oy, Helsinki.

Heikkilä, H. & Keränen, T. 2011. Hoitokimput ja hoitokäytännöt: mitä ne ovat ja toimivatko ne. *Suomen Sairaalahygienialehti* 2.

- Helakorpi, S., Prättälä, R. & Uutela, A. 2008. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007 (Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2007). Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 6/2008. Kansanterveyslaitos, Helsinki.
- Hellán, A. & Helakorpi, S. 2014. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2014. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN_ISBN_978-952-302-447-2.pdf?sequence
- Heller, B. R., Oros, M. T. & Durney-Crowley, J. 2000. The future of nursing education: 10 trends to watch. *Nursing and Health Care Perspectives* 21(1), 9–13.
- Hellstén, S. 2005. Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.
- Hentinen, K., Ilja, A. & Mattila, E. (toim.) 2009. Kuuntele minua – mielenterveystyön käytännön menetelmiä. Tammi, Helsinki.
- Hietamäki, M. 2013. Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen. Tutkimus lääkäreiden ja sairaanhoitajien työ- ja organisaatiositoutumisesta. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Hietanen, H., Iivanainen, A., Seppänen, S. & Juutilainen, V. 2005. Haava. WSOY, Helsinki.
- Hietavala E.-M. 2018. Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.
- Hofstede, G. 2005. Cultures and organizations. Software of The Mind. Mc Graw-Hill Company, London.
- Hokkanen, H., Häggman-Laitila, A. & Eriksson, E. 2006. Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen – katsaus tutkimuskirjallisuuteen. *Gerontologia* 1, 12–20.
- Holmström, P. & Puolakka, J. 2017. Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen ja seuranta. Teoksessa: Kuisma, M., Holmström P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. 2017. Ensihoito. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Holopainen, A. 2010. Lääkkeiden väärinkäyttö. Saatavissa osoitteesta www.paihdelinkki.fi.
- Husu, P., Sievänen, H., Tokola, K., Suni, J., Vähä-Ypyä, H., Mänttari, A. & Vasankari, T. 2018. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30.
- Huttunen, A., Kvist, T. & Partanen, P. 2009. Sairaanhoidajien työmotivaatio ja siihen yhteydessä olevat tekijät. *Tutkiva hoitotyö* 2, 21–7.
- Huttunen, J. Alkoholi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla osoitteesta https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01120
- Huttunen, R., Syrjänen, J. & Vuento, R. 2013. Resistentit bakteerit – haaste sairaalan jokaisessa potilaskontaktissa. *Katsaus. Suomen lääkärilehti* 13–14/2013.
- Hyvönen, T. 2010. Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus. Hoitajien näkemys kehitysvammaisten seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Rovaniemen AMK. Saatavilla osoitteesta www.theseus.fi
- Hämäläinen, P. 2005. Suu ja hampaat kertovat paljon yleisestä terveydentilasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki.
- Hänninen, M.-R. 2014. Masked hypertension in Finland – an independent cardiovascular risk factor? Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Härkänen, M. 2011. Lääkityspoikkeamat – Internet-pohjaisen raportointijärjestelmän hyödyntäminen lääkityspoikkeamien ymmärtämisessä organisaatiotasolla. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.
- Härkänen, M., Turunen, H., Saano, S. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Terveystieteiden henkilöstön näkemykset lääkityspoikkeamien estämisestä erikoissairanhoidossa. *Hoitotiede* 25 (1), 49–61.
- Häyrinen, K. 2011. Kliininen tieto hoitoprosessissa. Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Iivanainen, A. & Syväoja, P. 2016. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro, Helsinki.
- Iivanainen, A., Grek-Stjernberg, P., Kallio, H., Korhonen, A. & Pukki, T. 2014. Miten käsihygienia toteutuu. *Haava* 1/2014.
- Ilmonen, Tuisku. 1997. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja seksuaalisuus. Teoksessa H. Nikkola & A. Niinistö (toim.) *Halu rakastaa*. Julkaisusarja C:7:1997. Pro nursing ry, Turku.
- Inkinen, R., Volmanen, P. & Hakoinen, S. 2015. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkahoitosuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 14/2015.
- Isoherranen, K. 2015. Avanteen ympärysihon ongelmat. *Haava* 2.

- Jalava, J., Hakanen, A., Kauranen, J., Lindholm, L., Rantakokko-Jalava, K., Rissanen, A.-M., Tarkka, E., Vaara, M., Vuento, R., Vuopio, J. & Österblad, M. 2018. Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta. Suomen sairaalahygienialehti 36, 29–35
- Jamieson, E., Whyte, L. & McCall, J. 2007. *Clinical Nursing Practices*. Elsevier, Edinburgh.
- Johansson, J. 2011. Optimal Schedule for Home Blood Pressure Measurements and Clinical Significance of the Variability in Home-Measured Blood Pressure and Heart Rate. Väitöskirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
- Johns, C. 1995. The value of reflective practice of nursing. *Journal of Clinical Nursing* 4, 23–30.
- Jokinen, J. J., Sipponen, A., Lohi, J. & Salo, H. 2009. Haavanhoidon uusia ja vanhoja tuulia. *Suomen Lääkärilehti* 24.
- Jylhä, V. 2017. Information management in health care: a model for connecting information culture and patient safety. Tiedonhallinta terveydenhuollossa: Malli tietokulttuurin ja potilasturvallisuuden yhteydestä. Itä-Suomen yliopisto.
- Jyrkkä, J. 2011. *Drug Use and Polypharmacy in Elderly Persons*. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Kainulainen, K. 2010. Levitätkö mikrobeja, tartutanko tauteja – käsien merkitys laitosinfektioiden torjunnassa. *Suomen Sairalahygienialehti* 3.
- Kalso, E. & Vainio, A. 2002. (toim.). *Kipu*. Duodecim. Gummerus, Jyväskylä.
- Kanste, O. & Lipponen, K. & Kyngäs, H. & Ukkola, L. 2007. Potilasohjauksen kehittäminen alueellisena verkostoyhteistyönä yli organisaatiorajojen. *Tutkiva hoitotyö* 3, 30–3.
- Kanerva, A. 2015. ”Minusta potilasturvallisuus on potilaan oikeus ja meidän velvollisuus”. Potilasturvallisuuden kehittäminen systeeminäkökulmasta psykiatrisen erikoissairanhoidon yksiköissä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Karhe, L. & Kari, J. 2011. Aseptiikkapassi vähentää sairaalainfektioita. *Sairaanhoitaja* 6–7.
- Karjalainen, M., Norrgård, M., Peltomaa, M., Pirneskoski, J., Rantala, H. & Tirkkonen, J. 2018. Suositus peruselintoimintojen arvioinnista ja seurannasta. *Lääkärilehti* 12-13/2018, s. 786–788
- Karstinen, S., Keskihannu, I., Manner, H., Mäkeläinen, P., Peurasaari, S. & Vilmi-Johansson, L. 2007. Tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu.
- Karttunen, M. 2012. Lihaksensisäinen injektio vatsanpuoleiselle pakaralihasalueelle. *Sairaanhoitaja* 3.
- Karvinen I. 2010. AVAUS-malli potilaan henkisten ja hengellisten terveystarpeiden selvittämisessä. Saatavilla osoitteessa <https://satakunta.sairaanhoitajaliitto.fi/luentomateriaali>.
- Karvinen, I. 2009. Henkinen ja hengellinen terveys – Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä. *Kuopion yliopiston julkaisuja*, D. Lääketiede 451.
- Kasanen, A. 2010. Hengitysteiden puhdistaminen. Teoksessa A. Kaarlola & M. Larmila & H. Lundgren-Laine & A. Pyykkö & T. Rantalainen & M. Ritmala-Castren (toim.). *Teho- ja valvontahoitotyön opas*. Duodecim, Helsinki.
- Kauhanen, J., Erkkilä, A., Korhonen, M., Myllykangas, M. & Pekkanen, J. 2018. *Kansanterveystiede*. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Kela, E. 2011. Infektioiden torjuntapassilla lisää laatua sairaalahygieniaan. *Suomen Sairalahygienialehti* 4.
- Keskin, D., Borman, P., Ersöz, M., Kurtaran, A., Bodur, H. & Akyüz, M. 2008. The risk factors related to falling in elderly females. *Geriatr Nurs* 29 (1), 58–63. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. Saatavissa osoitteesta <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18267178>.
- Keskinen, P. 2008. Hyvä kotiutuminen terveyskeskussairaalaan – katkeamaton hoitoketju. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Stadia, Helsinki.
- Kiilholma, P. & Päivärinta, E. 2007. *Inkontinenssin ABC-opas hyvään hoitoon*. Sairaanhoitajaliitto.
- Kinnunen, M. 2010. Lääkekortti lisää potilasturvallisuutta. *Sairaanhoitaja* 3.
- Kinnunen, M. 2012. Mikä on teidän nimenne ja syntymäaikanne? *Sairaanhoitaja* 2, 51–3.
- Kinnunen, U.-M. 2013. Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliniseen hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

- Kiura, E. 2007. Painehaavojen ehkäisy ja hoito. Saatavilla osoitteessa <http://lib.stakes.fi/ohtanen/tarkastele.aspx?id=296>
- Kiviaho-Tiippa, A. 2012. Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa. Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.
- Kivimäki, T. 2010. Ikääntymisen vaikutus näköön ja kuuloon – aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kohtaamistarinoita-opas. Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta <http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/>.
- Kokko, R. 2008. Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Koivula, I., Laatto, M., Mauranen, R. & Gröker, H. 2010. Katetriperäiset virtsatie-infektiot ja niiden torjunta. Teoksessa: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.
- Koivunen, M., Luotola, E. & Asikainen, P. 2013. Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Satakunnan erikoissairaanhoidossa. Haava 4.
- Koivunen, M., Luotola, E., Hautaoja, P., Laine, K.-M. & Asikainen, P. 2014. Painehaavojen ehkäisy, osaaminen ja koulutustarpeet erikoissairaanhoidossa – pilottitutkimus hoitohenkilökunnalle. Tutkiva hoitotyö 12 (3), 14–22.
- Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt potilaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämiseksi – Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 3 (29), 180–194.
- Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt – potilaiden näkökulma. Tutkiva hoitotyö 3 (15), 12–19.
- Konttinen, M.-K. & Marttinen, A. 2005. Tyypin 2 diabeetikoiden ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymisen muutosprosessi. Hoitajien rohkaisukeinot terveysneuvonnassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kontula, O. 2013. Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2013 (3). Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos.
- Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Skhole Oy, Helsinki.
- Korhonen, A., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2010. Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta. Tutkiva hoitotyö 8 (3).
- Korhonen, A., Ojanperä, H., Järvinen, R., Puhto, T., Keijonen, P. & Holopainen, A. 2014. Käsihygienian toteutumisen arviointi – KhYHKÄ-toimintamalli. Saatavissa osoitteesta http://www.hotus.fi/system/files/K%C3%A4sihygienian%20toteutumisen%20seuranta_k%C3%A4sikirja%2030_5_%202014.pdf.
- Korhonen, A., Ojanperä, H., Järvinen, R., Puhto, T., Keijonen, P. & Holopainen, A. 2015. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen. Saatavissa osoitteesta http://www.hotus.fi/system/files/KhYHKÄ_toimintamalli_2015.pdf.
- Korhonen, E.-S., Meriö-Hietaniemi, I., Rekola, L. & Taponen, R.-M. 2011. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen projektityhteistyössä. Suomen Sairaalahygienia-lehti 4.
- Korhonen, T. 1999. Portfolio sairaanhoitajan ammatitaidon edistäjänä ja jatkuvan oppimisen välineenä työelämässä. Teoksessa K. Tossavainen & H. Turunen (toim.): Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa. Kirjayhtymä, Helsinki.
- Korhonen, T., Holopainen, A., Keijonen, P., Meretoja, R., Eriksson, E. & Korhonen, A. 2015. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva hoitotyö 13 (1), 44–51.
- Kortteisto, T. 2014. Neuvova potilaskertomus. Käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
- Kosonen, A. & Puhakainen, S. 2014. Käsihygienian toteutumisessa puutteita. Haava 1/2014.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. Harvey, S. & Morgan-Samuel, H. 2012. Fundamentals of Nursing. Concepts, process and practice. Pearson Education Limited, Harlow.
- Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/>
- Kukko, H. 2010. Toukat haavahoidossa. Haavalehti 2.
- Kullaa, A. 2006. Suun ja hampaiden hoito. Parkinson postia 3/06. Saatavilla osoitteesta www.parkinson.fi/julkaisut/artikkelit/suun-ja-hampaiden-hoito-306.

- Kuokkanen, L. 2005. Sairaanhoidajan tehtävät ja osaaminen. *Tutkiva hoitotyö* 3, 8–23.
- Kuokkanen, L., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2010. Sairaanhoidajien kokemat eettiset ongelmat hoitotyössä. *Hoitotiede* 22, 26–35.
- Kuokkanen, L., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2012. Sairaanhoidajien käsitykset valtaistumisestaan ja siihen liittyvistä tekijöistä työssään. *Hoitotiede* 24 (1), 82–91.
- Kuronen, M. 2017. Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross sectional study in home care and residential care. Iäkkäiden muistipotilaiden käytösoireet, psyykenlääkkeet sekä fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa. Itä-Suomen yliopisto.
- Kuuri-Riutta, A. 2010. Hengityksen hallinta. Teoksessa M. Castren & S. Aalto & E. Rantala & P. Sopanen & A. Westergård (toim.). *Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle*. WSOY, Helsinki.
- Kurtash, M., Short, M., Shea, J. & Martinez, M. 2009. The lift team's importance to a successful safe patient handling program. *The journal of nursing administration* 4.
- Kuusinen, P. 2004. Ei se kipu sinänsä masenna vaan sen seuraukset. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kvist, T. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2007. Vastavalmistuneiden sairaanhoidajien osaaminen erikoissairanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana. *Tutkiva hoitotyö* 3, 4–9.
- Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät. *Tutkiva hoitotyö* 4, 10–15.
- Kääriäinen, M., Lahdenperä, T. & Kyngäs, H. 2005. Kirjallisuuskatsaus: Asiakaslähtöinen ohjausprosessi. *Tutkiva hoitotyö* 3, 27–31.
- Laapio, E., Koivula, M. & Salminen, L. 2013. Tutkimustiedon käyttö hoitotyön opetuksessa opiskelijoiden arvioimana. *Hoitotiede* 26 (1), 50–62.
- Laatikainen, O., Sneck, S., Oukka, A.-L. & Turpeinen, M. 2016. Look Alike/Sound Alike -lääkkeet lääkärin työssä. *Lääkärilehti* 25–32, 1884–1887.
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Saatavilla osoitteessa www.finlex.fi
- Lauri, S. & Salanterä, S. 2002. Hoitotyön päätöksen tekoteoria. *Hoitotiede* 14 (4), 158–66.
- Lavander, P. & Kyngäs, H. 2006. Hankekuvaus. Hoitoisuusluokituksen kehittäminen sädehoito-osastolla. *Tutkiva hoitotyö* 3, 30–33.
- Lehtovirta, J. & Vuokko, R. (toim.) 2014. *Terveystieteiden rakenteisen kirjaamisen opas*. Osa 1. THL 1/2014.
- Leininger, M. 1994. Transkulttuurinen teoria. Teoksessa A. Marriner-Tomey: *Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä*. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala.
- Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2015. *Etiikka hoitotyössä*. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Lepistö, M. 2004. *Pressure Ulcer Risk Assessment in Long-term Care. Developing an Instrument*. Turun yliopisto, Turku.
- Liimatainen, T. 2007. Avanneleikatun potilaan ja läheisten tuensaanti ja selviytyminen hoitojakson aikana läheisen kuvaamana. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Liimatainen, T., Mattila, E., Koivula, M. & Åstedt-Kurki, P. 2011. Avanneleikattujen potilaiden läheisten tuensaanti hoitojakson aikana. *Hoitotiede* 3, 175–184.
- Lihavainen, K. 2012. Kipu vie iäkkään tasapainon – kohdennettu kuntoutus kannattaa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Liljamo, P., Kinnunen, U.-H. & Ensio, A. 2012. *FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas*. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 1.0. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Liljamo, P., Kaakinen, P. & Ensio, A. 2008. *Opas FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöön hoitotyön sähköisen kirjaamisen mallissa*. Kuopion yliopisto, Kuopio.
- Lindfors, K. & Korhonen, A. 2011. Käsihygieniassa on parantamisen varaa. *Sairaanhoidaja* 6–7.
- Lipponen, K. 2014. Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Saatavilla osoitteesta <http://herkules.oulu.fi/isbn9789526203720/isbn9789526203720.pdf>
- Ludwick, R., Silva, M. C. 2000. "Ethics: Nursing Around the World: Cultural Values and Ethical Conflicts" *Online Journal of Issues in Nursing* Vol. 5 No. 3.
- Lumiala, L. 2006. "Laiskamato pyssyy kauempana, kun ei ota sitä mukkaan": neljä tapauskertomusta ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto

- Luukkainen, S. & Uosukainen, L. 2011. Koulutus asian-
tuntijuuden perustana. Teoksessa I. Ranta (toim.): Sai-
raanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011.
Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki.
- Lyytikäinen, O., Ruutu, P., Kuusi, M. & Puumalainen, T.
2017. Uusi tartuntatautilaki ja -asetus – muutoksia
aiempaan. Suomen sairaalahygienialehti 35, 288–293
- Matikainen, A.-M., Miettinen, M. & Wasström, K.
2016. Näytteenoton käsikirja. Edita Prima Oy, Helsinki.
- Mattila, E. 2011. Aikuispotilaan ja perheenjäsenen
emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalahoidon aika-
na. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Mattila, E. & Niemi, R. 2011. Katse kynsiin. Suomen
Sairaalahygienialehti 3.
- Mattila, L.-R., Melender, H.-L. & Häggman-Laitila, A.
2014. Tutkimusklubi näyttöön perustuvan hoitotyön
edistämässä ja implementoinnissa. Tutkiva hoitotyö
2, 23–35.
- Mezirow, J. (toim.) 1995. Uudistava oppiminen. Kriitti-
nen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsinki.
- Miettinen, S., Miettinen, M., Nousiainen, I. & Kuokka-
nen, L. 2000. Itsensä johtaminen sosiaali- ja terveys-
alalla. WSOY, Helsinki.
- Monikulttuurisuus Suomen terveydenhuollossa. 2004.
ETENE-julkaisuja 11. Sosiaali- ja terveysministeriö. Yli-
opistopaino, Helsinki.
- Muhonen, R. 2017. Nesteensiirtopotilaan hoito. Teok-
sessa M. Mustajoki, A. Alila, E. Matilainen, M. Pellikka,
M. Rasimus & P. Könönen (toim.): Sairaanhoitajan käsi-
kirja 2018. Duodecim, Helsinki.
- Mustajoki, P. 2005 Hoitoon liittyvät virheet ja niiden
ehkäisy. Peijaksen sairaalan projekti. Suomen Lääkäre-
lehti 23.
- Mustajoki, P. 2003. Miten potilas motivoituu hoitonsa
aktiiviseksi osapuoleksi? Suomen Lääkärilehti 42.
- Mustajoki, M. & Alila, A. & Matilainen, E. & Rasimus,
M. (toim.). 2010. Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim.
Helsinki.
- Murtola, E. 1999. Lääkehoidon osaaminen: Kartoitus
valmistuvien sairaanhoitaja- ja terveyden-hoitajaopis-
kelijoiden lääkehoidon osaamisesta. Lisensiaatin tutki-
mus. Turun yliopisto.
- Mustonen, S., Vento, S. & Tuorila, H. 2007. Hajuaistin
toiminnan mittaaminen. Suomen Lääkärilehti 36.
- Mäkelä-Bengs, P., Virkkunen, H. & Vuokko, R. 2014.
Lääkemerkin tekeminen ja tietosisältö 2016. Toi-
minnallinen määrittely 5/2014. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos.
- Männikkö, L. 2010. Sähköisiltä aalloilta unen eheyttä-
ville laineille – tutkimus suomalaisten yhdeksäsluokka-
laisten nuorten elektronisen median käytöstä, nukku-
misesta ja itsetunnosta sekä näiden välisistä yhteyksis-
tä. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla osoitteesta [https://
jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN
%3ANBN%3Afi%3Aju-201007042245.pdf](https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN%3ANBN%3Afi%3Aju-201007042245.pdf)
- Mänty, M., Sihvonen, S., Hulkko, T. & Lounamaa, A.
(toim.) 2007. Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapatur-
mat Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B29. Kansanelä-
kelaitos, Helsinki.
- Mäntyharju, E. 2010. Monikulttuurisen asiakkaan koh-
taaminen – hoitohenkilöstö- ja asiakasnäkökulma.
Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, Tam-
pere.
- Mölsä, A. 1989. Sairaanhoitajakoulutuksen pääaine ja
sen looginen eteneminen opetussuunnitelmassa. Suo-
men sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki.
- Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus – dialoginen asia-
kastyö. Edita, Helsinki.
- Nauright, L. 1984. Politics and Power: A New Look At
Florence Nightingale. Nursing Forum 21 (1), 5–8.
- Naukkarinen, E.-L. 2008. Potilaan itsemääräämisen
ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa.
Kuopion yliopisto, Kuopio.
- Niemi-Murola, L. & Pöyhä, R. 2012. Kipu, kieli ja kult-
tuuri. Finnanest 1/2012. [www.finnanest.fi/files/niemi-
murola_kipu.pdf](http://www.finnanest.fi/files/niemi-murola_kipu.pdf)
- Nightingale, F. 1987. Sairaanhoidosta. WSOY, Helsinki.
- Nikula, A. 2011. Vaccination competence – the concept
and evaluation. Department of Nursing Science, Faculty
of Medicine. University of Turku, Turku.
- Nillson, C.-G. 2011. Naisen virtsatieongelma. Teoksessa
O. Ylikorkala & J. Tapanainen (toim.): Naistentaudit ja
synnytykset. Duodecim, Helsinki.
- Numminen, O. 2010. Nursing Ethics Education in Fin-
land from the Perspective of Codes of Ethics. Väitöskir-
ja. Turun yliopisto.

- Nuutinen, O., Siljamäki-Ojansuu, U., Mikkonen, R., Pelto, T., Silaste, M.-L., Uotila, H., Sarlio-Lähteenkorva, S. & Kara, R. (toim.) 2010. Ravitsemushoito – suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
- Ojala, T. 2016. The essence of the experience of chronic pain: A phenomenological study. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä.
- Ojanperä, J., Keränen, T. & Syrjä, H. 2017. Internet-pohjainen 5 tilanteeseen perustuva käsihygienian reaalitietoinen seuranta: Lupaavat tulokset hoitajilla, mutta ei vielä lääkäreillä. Suomen sairaalahygienialehti 35, 239–241
- Olli, S. 2008. Diabetes elämäntapa- ja nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumista kuvaava substansiivinen teoria. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
- OPM. 2006. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopinnot.
- Ora-Hyytiäinen, E. 2004. Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi: ammattikorkeakouluopiskelijan kasvu ja kehittyminen ammattiin. Acta Universitatis Tampensis. 1032. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Ovaskainen, M.-L. & Paturi, M. 2011. Näyttää hoitotyöhön. Rasvakeskustelu haastaa ammattilaiset. Sairaanhoitaja 11, 51–53.
- Paananen, S. 2012. Kompressiohoito, teoriassa helppoa, käytännössä haastavaa. Haava 4.
- Pahkala, T., Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M. 2013. Hoitotyön opiskelijoiden kliininen osaaminen. Hoitotiede 25 (1), 12–23.
- Pajula, S. 2012. IKINÄ-opas. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Papadopoulos, I. & al. 2016. Developing tools to promote culturally competent compassion, courage, and intercultural communication in healthcare. Journal of Compassionate Health Care 2016.
- Potilaiden erilaiset maailmankuvat hoitotyössä. Saatavilla osoitteesta <https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/potilaiden-erilaiset-maailmankuvat-hoitotyossa/>
- Peltari, P. 1997 Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvaifikaatiovaatimukset. Stakes, Helsinki.
- Pietilä, A.-M., Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U., Paavilainen, E., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. Hoitotiede 2012. SanomaPro, Helsinki.
- Pudas-Tähkä, S.-M. 2018. Tehohoitopotilaan kivun arviointimittarin validointi ja käyttöönotto. Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto.
- Pulpit, H. & Deane, M. (toim.) 2009. Connecting and reflective learning, teaching and assessment. Occasional paper 10. Health Sciences and practice center. Higher education Academy. King's College, London.
- Päivärinta, A. 2012. Muistisairaahan kivun arviointi: Hoitajien kokemuksia PAINAD-kipumittarin käytöstä. Saatavilla osoitteesta <https://bestprac.fi/2017/02/28/kipumittareiden-kaytto-vanhuksilla/>
- Pölkki, T. 2011. Inhimillisuus hoitotyössä. Tutkiva hoitotyö 2, 3.
- Raivio, R. 2017. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Duodecim 133: 1563–1569.
- Rappe, E. 2005. The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki.
- Rautava-Nurmi, H., Vaula, E., Sjövall, S., Vuorisalo, S. & Westergård, A. 2010: Neste- ja ravitsemushoito. WSOY, Helsinki.
- Reese, J. B., Finan, P. H., Hayworthwaite, J. A., Kadan, M., Regan, K. R., Herman, J. M., Herman, E. J., Diaz Jr, L. A. & Azad, N. S. 2014. Gastrointestinal ostomies and sexual outcomes: a comparison of colorectal cancer patients by ostomy status. Support Care Cancer 22, 461–468.
- Reijonen, K. 2014. Monikulttuurisen hoitotyön kulmakivet. Opas hoitotyön ammattilaisille. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Saatavilla osoitteesta www.theseus.fi.
- Rintala, E. & Routamaa, M. 2013. Hyvä käsihygienia sairaalassa – suositus vai velvollisuus? Suomen lääkäri-lehti 15, 1120–1121.
- Riski, H.-M. 2004. EKG-rekisteröinti. EKG-käyrän tekniikan laadun arviointi. Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Ritmala-Castrén, M. 2005. Viisas oppii lääkehoidon virheistä. Sairaanhoitaja 2.

- Rummukainen, M.-L. 2013. Antimicrobial Use and Infections in Finnish Long-Term Care Facilities THL Research 110: 9
- Ruohotie, P. 1998. Kokemus on paras opettaja – jos vain otamme oppia siitä. Teoksessa A. Räisänen (toim.): Hal- litaanko ammatti? Pätevyyden määrittelyä arvioinnin perustaksi. Opetushallitus. Yliopistopaino, Helsinki.
- Ruusunen, A. 2013. Diet and Depression. An epidemio- logical study. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2018. Lääkehoidon kä- sikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjel- ma 2016–2019. Saamelaiskäräjät. Saatavilla osoitteesta <https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/>.
- Saarnio, R. 2009. Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhus- ten laitoshoitossa. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu.
- Sahlström, M., Partanen, P. & Turunen, H. 2012. Po- tilaiden näkemyksiä potilasturvallisuudesta ja osallis- tumisesta sen edistämiseen. Tutkiva hoitotyö 10 (4), 4–13.
- Sailo, E. & Vartti, A.-M. (toim.) 2000. Kivunhoito. Tam- mi, Helsinki.
- Sairaanhoitajajohtoiset interventiot aikuisten sydänsai- rauksien riskitekijöiden vähentämiseksi: [www.hotus.fi/ joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset](http://www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset)
- Salo, V. 2012. Kotipalvelun työntekijät tarvitsevat iäk- käiden ravitsemukseen liittyvää koulutusta. Väitöskir- ja. Turun yliopisto.
- Sajaniemi, P. 2017. Sairaanhoitajattarena Suomessa vuosina 1933–1940. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos.
- Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) 2003. Päihdelääketiede. Duodecim, Helsinki.
- Salmi, R. 2014. Iäkkäiden suun terveys ja kotihoito. Kohteena Tampereen kaupungin kotihoito. Hammas- lääketieteenlaitos, Turun yliopisto.
- Sandvik, A.-H. 2015. Becoming a caring nurse: the heart of the matter in nurse education. Åbo Akademi University.
- Santalahti, T. 2018. Opettajan opas – Nuorten seksuaa- lisuus ja seksuaaliterveys. Duodecim, Koulun terveys- kirjasto. Saatavilla osoitteesta www.koulunterveyskir- jasto.fi.
- Sarajärvi, J. 2017. Sairaanhoitajien tiedot ja taidot poti- laan suun terveyden ylläpitämiseksi. Kyselytutkimus me- disiinisellä tulosalueella työskenteleville sairaanhoitajille.
- Sarajärvi, A., Mattila, L.-R. & Rekola, L. 2010. Näyt- töön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymi- seen. WSOY, Helsinki.
- Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja. 2011. Fioca Oy, Helsinki. Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki.
- Sheppard, M. & Wright, M. 2006. Principles and prac- tice of high dependency nursing. Foreword by Adam S. Elsevier, London.
- Seksuaalisuudesta selkokielellä. Seteke-projektin (Sek- suaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti) verkkosi- vut. www.seteke.fi.
- Sipola-Kauppi, I. 2009. ”Apua, minäkö tein virheen?” Sairaanhoitajien kokemuksia lääkityspoikkeamista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
- Sneck, S. 2016. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaami- nen ja osaamisen varmistaminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Soini, H. 2017. Vanhuksen ravitseminen. Teoksessa M. Mustajoki, A. Alila, E. Matilainen & M. Rasimus (toim.): Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim, Helsinki.
- Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaiseen hoitotyön historiaan. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämis- oikeus. 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportte- ja ja muistioita 27/2018. Sosiaali- ja terveysministe- riö. Saatavilla osoitteesta: http://julkaisut.valtioneu- vosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM_R_27_ Asiak_itsemaaramisoikeus_sos_terv_huollossa.pdf
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2013. Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitys- työryhmän kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveys- ministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2011. Lääkepolitiikka 2020. Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukais- ta ja taloudellista lääkkeiden käyttöä. Sosiaali- ja ter- veysministeriön julkaisuja 2011:2. Sosiaali- ja terveys- ministeriö, Helsinki.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2007. Liikuta – hyvin- vointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisten terveyslii- kunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveys- ministeriö, Helsinki.

- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Terveysten edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19. Yliopistopaino, Helsinki.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2005. Arkea helpottavat välineet. Opas ikäihmisille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:25.
- Sulosaari, V. 2016. Medication competence of nursing students in Finland. Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Sulosaari, V., Erkkö, P. & Ojala, S. 2011. Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 60.
- Sulosaari, V., Erkkö, P. & Walta, L. 2010 Valmistuvan sairaanhoitajan lääkehoito-osaamisen vaatimukset. Kohti kansallista konsensusta. Turun ammattikorkeakoulu, Puheenvuoroja 54.
- Suominen, M.-H., 2007. Nutrition and Nutritional Care of Elderly People in Finnish Nursing Homes and Hospitals. Academic Dissertation. University of Helsinki, Helsinki.
- Sutinen, T. 2010. Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto
- Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.
- Suvikas-Peltonen, E. 2017. Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla. Väitöskirja. Farmakologian ja lääkehoidon osasto. Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto.
- Sygeplejeråd, D. & Vauhkonen, O. 1978. Terveystenhuollon historia. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä.
- Tamminen-Peter, L. 2007. Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppilaitoksissa. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:22. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
- Tamminen-Peter, L. 2006a. Potilaan ottama tuki ja ro-
taatio keventävät avustajan työtä. Fysioterapia 53.
- Tamminen-Peter, L. 2006b. Uudet potilassiirtomenetelmät parempia hoitajille ja potilaille. Sairaanhoitaja 6–7.
- Tamminen-Peter, L. 2005. Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa – kolmen siirtomenetelmän vertailu. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja C 228. Turun yliopisto, Turku.
- Tamminen-Peter, L., Eloranta, M.-B., Kivivirta, M.-L., Mämmelä, E., Salokoski, I. & Ylikangas, A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
- Tamminen-Peter, L., Moilanen, A. & Fagerström, V. 2010. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työ-terveyslaitos, Tampere.
- Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot: Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos, Helsinki. Saatavilla osoitteesta www.julkari.fi/handle/10024/137082.
- Tasa-arvo- ja seksuaaliterveystietoa aikuisille maahanmuuttajille -koulutusmateriaali. Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/.
- Taylor, C., Lillis, C. & Le Mone, P. 2005. Fundamentals of nursing. The Art & Science of Nursing Care. Barnes & Noble, New York.
- Tehyn eettinen toimikunta. 2007. Hoidon turvallisuuden kahdet kasvot. Turvallisuus on hoitajan ja hoidettavan oikeus. Tehy 9.
- Tella, S. 2015. Learning about patient safety in pre-registration nursing education: comparing Finnish and British nursing students' evaluations. Potilasturvallisuuden oppiminen hoitotyön koulutuksessa – suomalaisten ja englantilaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioiden vertailua. Itä-Suomen yliopisto.
- Terveysten ja hyvinvoinnin laitos 2016. Turvallinen lääkehoito.
- Tiisanoja, A. 2018. Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Tilles-Tirkkonen, T. 2016. Kouluikäisten lasten ja nuorten rukailutottumukset ja niiden tasapainoisuuteen vaikuttaminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Edita, Helsinki.
- Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014. Terveysten ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.
- Vesterinen, A., Komulainen, K., Hiller-Ikonen, A., Latvala-Korpela, I. & Collander, T. 2014. Hoitotyön opiskelijoiden ammatillinen osaaminen. Tutkiva Hoitotyö 2, 14–22.

Valkama, K. 2012. Asiakkuuden dilemma. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Valta, M. 2013. Sähköisen potilastietojärjestelmän so-
siotekninen käyttöönotto. Seitsemän vuoden seuranta-
tutkimus odotuksista omaksumiseen. Väitöskirja. Itä-
Suomen yliopisto.

Varjonen, V. Huumetilanne Suomessa 2014. THL. Saa-
tavilla osoitteesta [www.julkari.fi/bitstream/hand-
le/10024/125568/THL_RAP01_2015_web%20
%281%29.pdf](http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAP01_2015_web%20%281%29.pdf)

Varpula, T. & Linko, R. & Pettilä, V. 2010. Äkillisen hen-
gitysvajauksen esiintyvyys, hoito ja ennuste Suomessa
– FINNALI-tutkimus. Duodecim 19, 2239–46.

Veräjänkorva, O. 2003. Sairaanhoidajien lääkehoitotai-
dot, Lääkehoitotaitojen arviointimittarin ja täydennys-
koulutusmallin kehittäminen. Turun yliopiston hoito-
tieteen laitos. Sarja C, osa 200. Turun yliopisto, Turku.

Veräjänkorva, O. & Palta, H. 2008. Turvallinen lääke-
hoito osana potilasturvallisuutta. Teoksessa O. Veräjän-
korva (toim.): Sairaanhoidajien lääkehoito-osaaminen
yliopistosairaalassa. Turun ammattikorkeakoulun ra-
portteja 72. Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Huupponen, U.,
Kaukkila, H.-S. & Torniainen, K. 2009. Lääkehoito hoi-
totyössä. WSOY, Helsinki.

Virtanen, E. 2018 Chronic dental diseases and systemic
health: Cardiovascular diseases and cancer. Väitöskirja.
Helsingin yliopisto.

Vuokko, R., Suhonen, J., Hyppönen, K. & Porrasmaa, J.
2014. Potilastiedon suostumuksenhallinta ja yhteisen
potilastietorekisterin liittyminen Kantaan. THL.

Waldén, A. 2006. Muurinsärkijät. Tutkimus neurologi-
sesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymi-
sen tukemisesta. Väitöskirja. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Warden V., Hurley, A. C. & Volicer, L. 2003. Develop-
ment and psychometric evaluation of the Pain Assess-
ment in Advanced Dementia. J Am Med Dir Assoc 4 (1).

Åsted-Kurki, P. & Kaunonen, M. 2010. Hyvä hoitami-
nen vaatii yhteistyötä. Hoitotiede 2, 81–2.

Ärling, M. 2010. Romanit terveyspalveluiden käyttäji-
nä. Romanipotilas vuodeosastolla -opas. Opinnäytetyö.
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hakemisto

A

ADH 305
adherenssi 105
afasia 40, 398
ahdistuneisuus 388
aikakäsitys 45
aivoverenkiertohäiriö 398
aivoverenkiertohäiriöpotilaan
 asentohoito 212
ajanvarauspoliklinikka 77
ajurin asento 324
aktiivinen immunitetti 107
aktiivinen liikeharjoitus 208
aktivaattori-injektiopullo 154
aktiiviteettia edistävä toiminta 221
akuutti haava 226, 228, 229
akuutti kipu 97
akuuttityöryhmä 76
alapaine 353
allilämpöinen potilas 373
aliravitsemus 254
alkoholi 66, 379
alkoholinkäyttö 66, 367
alkuperäisvalmiste 133
alkureitin metabolia 142
alkuvirtsä 272
ammattillinen kasvu 15, 17
ammattillinen opettajankoulutus 20
ammattietiikka 23
ammattikorkeakoulussa suoritettu
 perustutkinto 18
ampulli 151
ampullissa olevan lääkeaineen
 valmistelu 152
anafylaksian oireet 163
anafylaktinen sokki 163
anestesiaosasto 78
annossyöttö 262
antiseptiikka 119
antropometrinen mittaus 246
anuria 273
apuväline 168, 204, 205, 206, 217,
 221, 252, 279, 382
apuvälineyksikkö 78
asentohoito 210
aseptiikka 105, 122
aseptinen 337
aseptinen omatunto 110
aseptinen työjärjestys 122, 193
aseptinen työskentely 138
aspiraatoriskipotilas 301
astmapotilas 327
asystole 355
AUDIT-testi 67
autismi 39

avanneleikkaus 298
avannepotilaan hoito 297
avannepussi 298
avannesidoksen vaihtaminen 299
avannesidos 298
AVAUS-malli 393
AVH-potilas 212
A-vitamiini 173
avoin ammattikorkeakouluopetus 19

B

bakteeri 105
bakteriuria 273
bioanalytiikka 76
biokemiallinen määrittäminen 246
biologinen hyötyosuus 142
BIPAP 346
BMI 248
bolusruokinta 262
Bradenin riskimittari 235
bukkaalinen 148
bulimia 300
B-vitamiini 173

C

Cheyne-Stokesin hengitys 321
CPAP-laite 346
CRPS 98
C-vitamiini 174

D

Davidhizar 42, 45
dehydraatio 300, 315
desinfiointi 119
diabeettinen jalkahaava 230
diakoniatyö 418
diakonissa 11
diffuusio 306
dorsogluteaalinen pakaralihasalue
 161
dosetti 168
dreeni 311
duaalimalli 18
Durewall-menetelmä 203
dysartria 398
dysfagia 398
dysfasia 398
dysfonia 398
dysleksia 398
dyspnea 321
dyspraksia 398
dysuria 273

E

EKG 355, 359
EKG-nauha 356, 359

elektrolyytti 306
elektrolyyttitasapaino 305, 306
elintavat 393
elinympäristö 393
elohopeamillimetri 353
elämäntapa 33
elämäntapa 33
elämänlaatu 394
embolia 366
energia 244
ensihoitaja 75
enteraalinen 314
enteraalinen ravitsemus 257, 262
enterovalmiste 149
epäsuora rajoittamismuoto 379
ergonomia 202, 204
ergonomiayhteyshenkilö 219
ergonominen avustusmenetelmä
 203
ergonominen perusasento 204
erikoissairaanhoido 72
eristyshoidon toteuttaminen 126
eristyskortti 127
eristysluokat 125, 126
eritetahradesinfiointi 120
erittäminen 271
erityisruokavalio 252
Escherichia coli 288
E-vitamiini 174

F

farmakokinetiikka 141
FIM-mittari 202
FinCC 54
Finnish Care Classification (FinCC)
 53
Florence Nightingale 12, 174
Ford-kävelypöytä 217
fysioterapeutti 75, 209, 325
fysioterapia 223
fyysinen kuormitus 202
fyysinen rajoite 380, 381
fyysinen sitominen 380
fyysinen toimintakyky 222
fyysinen ympäristö 174

G

gastrostooma 264
Geerd Hofstede 41
geneerinen substituoitu 133
geriatriinen tuoli 213, 214
Giger 42, 45
Glasgow'n kooma-asteikko 102
glukosuria 273
granula 149

H

- haamukipu 98
- haavainfektiio 230, 241
- haavan paranemisen vaiheet 227
- haavapotilaan hoito 226
- haavasidos 239
- haavatulehdus 227
- haittavaikutus 144
- hajataitaisuus 86
- hajuaisti 91
- hammasproteesi 198
- hammasproteesin puhdistaminen 198
- hampaiden hoito 195
- hampaiden ja suun puhdistus 196
- hankittu immunitaetti 107
- hopen antaminen 329
- hopenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus 335
- hopenpuute 344
- hopenvaraajapussi 331
- happikylläisyyden seuranta 328
- happimaski 329, 331
- happinaamari 329
- happinenä 332
- happipullo 333
- happiviikset 329, 331
- happo-emästasapaino 305, 307
- hartialihas 160
- heilahduskäynti 219
- hematuria 273
- hengellinen tuki 393
- hengelliset tarpeet 392
- hengellisyys 392
- hengenahdistus 321
- hengityksensuojain 118
- hengityselimistö 319
- hengitysfrekvenssi 320
- hengitysilman kostutus 333, 341
- hengityspysähdys 323, 346
- hengitystaajuus 320
- hengitystapa 321
- hengitystekniikan ohjaaminen 325
- hengitysvajauspotilas 337, 343, 345, 346
- hengityssänet 321
- henkilöhygieniä 116
- henkisen tuen tarve 391
- henkitorviavanne 340
- hiilihydraatit 243
- hiusten pesu 191
- hivenaine 174
- hoidon arviointi 54, 58
- hoidon inhimillisyys 23
- hoidon jatkuvuuden periaate 30
- hoidon tarve 54, 56
- hoidon tavoitteet 54, 57
- hoidon toteutus 54, 58
- hoidon turvallisuus 377
- hoitoisuus 59
- hoitoisuusluokitus 59
- hoitoisuusmittari 59
- hoitoprosessi 53
- hoitosuhde 37, 401
- hoitosuunnitelma 15, 55
- hoitotieteen opiskelu yliopistossa 20
- hoitotyö 14
- hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset 25
- hoitotyön kirjaaminen 49, 56
- hoitotyön opiskelu ja tutkimukset ammattikorkeakouluissa 18
- hoitotyön periaatteet 26
- hoitotyön prosessi 54, 55, 56
- hoitotyön yhteenvedo 58, 416
- hoitovirhe 183
- hoitoympäristö 13, 174, 401
- Holter-EKG 356
- huoltohuone 122
- huonokuuloinen 84, 85
- huulirakohengitys 326
- huumausaine 68, 136, 379
- hygieniä 105
- hygieniahoitaja 124
- hyperhydraatio 315
- hyperkalemia 307
- hyperkalsemia 307
- hyperkapnia 308
- hypernatremia 306
- hypertoninen dehydraatio 315
- hyperventilaatio 321
- hypokalemia 307
- hypokalsemia 307
- hypoksemia 344
- hypomagnesemia 307
- hyponatremia 306
- hypotoninen dehydraatio 315
- hypoventilaatio 321
- hypovolemia 309
- häkä 328
- hönkiminen 325
- höyryhengitys 332, 347
- ihon ja kynsien hoitaminen 116
- ihon kerrokset 225
- ihon perushoito 173
- ihonsisäisen injektion antaminen 155
- ihopoimimittaus 246
- ikäkuulo 82
- ikäntyvien seksuaalinen hyvinvointi 35
- ilmaeristys 125
- ilmatartunta 107
- ilmavaivat 291, 293
- imeskelytabletti 148
- immunitaetti 107
- imukatri 336
- imulaite 337
- infektiio 105, 370
- infektion vuoksi eristäminen 125
- infektioimikunta 124
- inhalaatiosumute 165
- inhaloitava lääke 164
- inhimillinen virhe 384
- injection annon komplikaatiot 163
- injection antaminen peräsuoleen 164
- injection antaminen rektaalisesti 164
- injectioneula 151
- injection käyttöön saattaminen 149, 150
- injectionruisku 150
- insuliinihoito 157
- insuliinikynä 157
- insuliinin pistäminen 156
- insuliinipumppu 158
- insuliiniruisku 151, 157
- intimihygieniä 189
- intimiteettisuoja 400
- intraadermaalisen injection antaminen 155
- intrakutaanisen injection antaminen 155
- intramuskulaarisen injection antaminen 158
- intraoraalinen 148
- intravenoosinen lääkitys 162
- intubaatio 339
- invasiivinen 339
- invasiivisuus 105
- ionipumppumekanismi 306
- ISBAR-menetelmä 384
- iskiashermon vaurio 163
- isotoninen dehydraatio 315
- iso verenkierto 351
- istuma-asento 211
- istumaharjoitus 213
- itsehoitolääke 133
- itsekatriointi 287
- itsemääräämisoikeuden periaate 27

J

jalkaterapeutti 76
jalkineet 200
jalkojenhoitaja 76
jalkojen hoito 199
jatkohoidon suunnitelma 415
jatkuva syöttö 262
jauheannostelija 165
julkinen sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmä 71
juoppohulluus 68
jälkitarkastus 416
jälkitiputtelu 279
jätehuolto 123
jätteiden jaottelu 123

K

kaksoistarkistus 140
kalium 307
kalsium 307
kansallinen rokotusohjelma 108
Kanta-palvelu 415
katetrointi 282, 285
kaukotaittoisuus 86
kauppanimi 133
kehityskriisi 34
kehitysvaihe 34
kehitysvamma 35, 39
kehollinen ilmaisu 39
kehonkuva 388
kemiallinen desinfiointi 120
kemiallinen rajoittaminen 380
kertakatetrointi 287
keskittymiskyky 326, 397
kestokatetrin poistaminen 286
kestokatetrointi 282
kestokatetrointi miehelle 283
kestokatetrointi naiselle 284
keuhkohtaumatauti 343
keuhkopöhö 316
keuhkotuuletus 319
keuhkoverenkierto 351
keuhkoödeema 316
kielellinen häiriö 399
kielellinen ilmaisukyky 38
kinesteettinen menetelmä 203
kinestetiikka 203
kipu 94
kipukynnys 95
kipulääke 100
kipumittari 100
kipupoliklinikka 99
kirjaaminen 49
kirjallinen hoito-ohje 418
kirjallisuus- ja runoterapia 397
kirurginen haava 228

kivennäisaineet 174, 243
kivun arviointi 95, 99
kivunhoito 99, 101, 229
kivun lääkehoito 100
kivun mittaaminen 99
kognitiivinen häiriö 399
kohoasento 211, 324, 366
kohottautumisteline 207
kokonaishoidon periaate 29
kolmas sektori 73
kolmipistekävely 219
kolonisaatio 105
koneellinen lääkkeiden annosjakelu 168
kontaktisidos 239
kontaminaatio 105
kontrollikäynti 416
Korotkoffin äänet 360, 361, 363
korujen ja kellon käyttäminen 116
korvahuuhtelu 83
kosketus 402
kosketustartunta 106
kosketusvaroitimet 125
kotihappihoito 334
kotipalvelu 417
kotisairaanhoido 416
kotiutus 418
kotiutushoitaja 76
krooninen haava 226, 229
krooninen kipu 97
kuiva suu 195
kulttuuri 40
kulttuurikompetenssi 42
kulttuurisensitiivisyys 39
kulutuskortti 136
kunnioittamisen periaate 27
kuntouttava työote 222, 253
kuntoutusohjaaja 76
kuoleman pelko 392
kuorsaus 180
Kussmaulin hengitys 321
kuuloaisti 81
kuuloasema 77
kuulohoitaja 83
kuulokoje 83
kuulon apuväline 82, 85
kuulovammainen 84
kuunteleminen 38
kuuro 84
kuvantamisyksikkö 78
kuvataideterapia 397
kylkiasento 212, 325
kystiitti 288
käsiensinifiointi 112
käsiensinifiointi 110
käsihygieniä 301

kättilö 75
kävelyn avustaminen 217
kävelypöytä 217
Käypä hoito -suositukset 60
käytännön harjoittelu 16
käytösore 389
kääntölevy 205

L

laboratorio 417
laboratoriotutkimus 257, 311
laboratorioyksikkö 78
lagenula 153
lagenulassa olevan lääkkeen valmistelu 153
laiteturvallisuus 378
laki potilaan asemasta ja oikeuksista 50
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 50
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 53
laksatiivi 293
larynxmaski 339
laskimonsisäinen lääkitys 162
laskimosuoniperäinen säärihaava 230
laskimoverinäyte 316
leikkausosasto 78
leikki 222
lemmikkieläin 394
letkuruokinnan komplikaatiot 263
letkuruokinta 257, 261
lievä kohoasento 211
lihaksensisäisen injektion antaminen 158, 161
liikkumisen rajoittaminen 380
liikkumisessa avustaminen 203
liikunnallinen toimintakyky 206
liikunta 65, 222
liikuntasuositus 65
liinavaatteet 122, 178, 236
Liitu 2016 -tutkimus 65
likaisten käsiensinien riisuminen 115
likapyykki 123
likitaittoisuus 86
liman erittyminen 322
liman imeminen 336
lisäravinne 255
liukulakana 205
liukulevy 205
liukupatja 205
LIV-kaappi 136, 150
lohtu 402
lukittava lääkehuone 136

läheisyys 400
 läheltä piti -tapahtuma 377
 lähete 51
 lähihoitaja 75, 77
 lämpödesinfiointi 119
 lämpömittari 370
 lämpöraja 365
 lämpötilan mittaaminen 370
 läsnäolo 401
 lääke 133
 lääkeaine 133
 lääkeaineen imeytyminen 141
 lääkeannostelija 168
 lääkehoidon ohjaus 169
 lääkehoidon riskikohdat 146
 lääkehoito 134, 135, 137, 170, 253
 lääkehoitosuunnitelma 135
 lääkejäte 123
 lääkekortti 169
 lääkepurukumi 149
 lääketurvallisuus 134
 lääkevaste 144
 lääkinnällinen hoitosukka 232
 lääkityspoikkeama 146
 lääkitysturvallisuus 134, 155
 lääkkeen määrääminen 137
 lääkkeiden antaminen emättimen kautta 166
 lääkkeiden antaminen hengitysteihin 164
 lääkkeiden antaminen iholle 165
 lääkkeiden antaminen injektiona 149
 lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta 166
 lääkkeiden antaminen ruiskeena 149
 lääkkeiden antaminen suun kautta 147
 lääkkeiden jakaminen 138
 lääkkeiden väärinkäyttö 69
 lääkkeiden yhteisvaikutus 137
 lääkäri 75

M

magnesium 307
 mahalaukkuavanne 264
 makuasti 92
 mansetti 341, 363
 metabolinen alkaloosi 308
 metabolinen asidoosi 308, 321
 MIDAS -muistisääntö 102
 mielenterveys 402
 mielialaongelmat 401
 mieliruoka 254
 migreeni 300
 mikstuura 149
 minäkuva 33, 387

monikulttuurinen hoitotyö 40, 44
 monimuotoisuus 38
 moniresistentti mikrobi 124
 monitydyttymätön rasvahappo 174
 MRSA 124, 361
 muistelu 396
 muistihäiriö 387
 muistisairas potilas 395
 muistot 396
 munuainen 271, 305
 musiikkiterapia 397
 MUST-menetelmä 255

N

Nancy Roper 59
 narkolepsia 181
 natrium 306
 nekroosi 233
 nelipistekävely 219
 nenäkatetri 329
 nenä-mahaletku 262
 nenä-mahaletkun laitto 257, 259
 nenäsiipihengitys 321
 nenäsumute 168
 nenäviikset 331
 nestehukan korvaaminen 297
 nestelista 312
 nestetasapaino 296, 305
 nesteytys 314
 neurogeeninen rakkohäiriö 279
 neuropaattinen kipu 98
 neuvola 416
 NEWS-pisteytysjärjestelmä 320, 373, 374
 nielemisvaikeus 253
 normaalifloora 105
 Nortonin riskimittari 235
 nosiseptiivinen kipu 98
 nostoryhmä 219
 nukkumisergonomia 184, 210
 nykturia 273
 näköaisti 85
 näkökeskus 77
 näkökyvyn selvittäminen 86
 näkövammaisuus 88, 90, 91
 näyttö 59
 näyttöön perustuva hoitotyö 59
 näöntarkkuus 88

O

ohjaus 37, 69, 195, 240, 367, 397
 ohjauslomake 398
 oliguria 273
 omahoitaja 221
 omahoitajakeskustelu 389
 omainen 389, 417

omatoimisuuden periaate 29
 ominaispaino 273
 ongelmajäte 123
 oppimisvaikeudet 387
 oraalliluuos 149
 oraalinen lääkitys 148
 ortostaattinen hypotensio 365
 orvaskesi 225
 osastonhoitaja 77
 osmoosi 306

P

paasto 251
 pahoinvointilääke 301
 paikallishoitoaine 226
 PAINAD-mittari 96
 painehaava 233, 236
 painehaavan ennaltaehkäisy 237
 painehaavan riskiluokittelu 235
 painehaavan syvyyssluokitus 235
 painoindeksi 248
 pakaralihas 160
 pakkoinkontinenssi 279
 palovamma 228
 palpaatiomenetelmä 363
 palpoini 355
 palveleva puhelin 418
 Papadopoulos 44
 parasiitti 106
 parasomnia 182
 parenteraalinen 314
 parenteraalinen lääkitys 162
 parenteraalinen ravitsemus 265
 parenteraalinen ravitsemushoito 251
 parranajo 192
 passiivinen immuniteetti 108
 passiivinen liikeharjoitus 209
 patogeenisuus 105
 PEF-mittaus 327
 PEF-seuranta 327
 PEG 264
 pelastussuunnitelma 378
 PEP-pullopuhallus 326
 perhekeskeinen työskentelyote 389
 perhekeskeisyyden periaate 28
 perheterapia 397
 perifeerinen lämpö 370
 peristaltiikka 291
 perkutaaninen 165
 perspiraatio 311
 perustäläkevalikoima 135
 perustarpeet 388
 perusvoide 226
 peräpuikko 164
 peräpuikon antaminen 295
 peräruiske 164, 293

peräruiskeen antaminen 294
 peseytymisessä avustaminen 187
 peseytymistottumukset 188
 pieni verenkierto 351
 pienoisperäruiske 293, 294
 pienoisperäruiskeen antaminen 294
 pihkahoito 232
 piilolinssit 87
 pisaratartunta 107
 pisaravarotoimet 125
 pitkäaikainen kipu 97
 pleuriittinen 322
 PLISSIT-malli 36
 PLV 275, 276
 pneumaturia 273
 pneumonia 322
 poikkeama 377
 pollakisuria 273
 polttava kiputila 98
 polyuria 273
 ponnistusinkontinenssi 279
 potilaan avustaminen pyörätuoliin 215
 potilaan avustaminen suihkussa 192
 potilaan henkilökohtainen omaisuus 378
 potilaan kaatuminen 382
 potilaan syöttäminen 254
 potilaanvierusraportti 61
 potilaan yksilöllisyys 398
 potilasasiakirja 49, 52, 53
 potilasasiakirjamerkintä 51
 potilasjärjestö 417
 potilaskertomus 50, 51, 52, 53
 potilaskohtainen
 lääkehoitosuunnitelma 137
 potilaspöytä 176
 potilassiirrot 202
 Potilassiirtojen Ergonomiakortti® 219
 potilastietojen luovuttaminen 415
 potilastietorekisteri 53
 potilasturvallisuus 377, 384
 potilasvuode 175
 potilasvuoteen lisävarusteet 206
 prioni 106
 proteiini 243
 Pseudomonas 361
 psoas-asento 212
 psykologi 76
 psykoterapeutti 76
 psyykinen hyvinvointi 387
 psyykinen sairaus 401
 psyykinen toimintakyky 222
 puhdas kirurginen haava 239
 puhdistus 119

puheen tuottamisen häiriö 399
 puheen ymmärtämisen häiriö 399
 puhelimesta annettava neuvonta 169
 puheterapeutti 39, 76
 puhetta korvaava keino 39
 puhtaasti laskettu
 keskisuihkuvirtsanäyte 275
 puhtaustottumukset 187
 pukeutumisessa avustaminen 193
 pukeutumistottumukset 188
 pulssioksimetri 328
 puoli-istuva asento 366
 pyelonefriitti 288
 pyuria 273
 pyörätuoli 213
 päihteiden käyttö 66
 päivystyspoliklinikka 77
 päiväkeskuspalvelu 417
 päänsärky 97, 293

R

raajakytkentä 358
 rae 149
 rakkoavanne 287, 288
 raportti 61
 rasitus-EKG 359
 rasva 243
 RAVA-indeksi 202
 ravinnottaolo 257
 ravintoaine 243, 244
 ravintoaineryhmä 243
 ravintoanamneesiksi 245
 ravintokuitu 243
 ravintovalmiste 258, 265
 ravitsemus 173, 244
 ravitsemuskartoitus 245
 ravitsemusneuvonta 64
 ravitsemusohjaus 64, 249, 250
 ravitsemussuositus 64, 249
 ravitsemusterapeutti 76
 ravitsemustila 244
 reflektio 15
 reflektiomalli 17
 reflektioiva kirjoittaminen 16
 reisilihas 159
 rektioli 164
 renkaaton kävelyteline 218
 reseptilääke 133
 resoribletti 148
 respiratorinen alkaloosi 308
 respiratorinen asidoosi 308
 retentio 263, 287
 rinnakkaisvalmiste 133
 rintakipu 97
 rintakytkentäelektrodi 358
 ripuli 291

ripuloivan potilaan hoito 296
 riskijuominen 67
 riskilääke 136
 rokote-immuniteetti 107
 rokotuskattavuuden lasku 108
 rollaattori 217
 RR 353
 ruoansulatuskanava 244
 ruokailuasento 252
 ruokailun järjestäminen 252
 ruumiinlämmön nousu 372
 rytmihäiriö 356
 röntgenhoitaja 76

S

sairaala-apteekki 135
 sairaalahygieniatoimikunta 124
 sairaalainfektio 109
 sairaalainfektioiden seurantaohjelma 123
 sairaalakoulu 78
 sairaalateologi 77
 sairaanhoitaja 75, 77
 sairaanhoitajan eettiset ohjeet 23
 sairaanhoitopiiri 72
 sairas iho 226
 SAS-hoitaja 76
 seisomaan nousussa avustaminen 216
 seisomaharjoitus 216
 sekamuotoinen inkontinenssi 279
 seksuaalisuus 34, 388
 seksuaaliterveys 35
 selkokieli 40
 selkääsento 211, 366
 selviytyminen 222, 387, 389, 397
 selänpuoleinen pakaralihasalue 161
 sidonta 238
 sidontatekniikka 239
 sidostyytit 238
 sieni 106
 silmälasit 87
 silmäsuojus 118
 sisäinen voimavara 390
 sisäkorvaistute 83
 Snoezelen-toimintaympäristö 223
 sopeutuminen 46, 222
 SOPMAS-mittari 219, 220
 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 74
 sosiaalinen toimintakyky 222
 sosiaalinen voimavara 390
 sosiaalipalvelut 71
 sosiaalityöntekijä 75
 sote-uudistus 72, 74
 steriilien käsineiden pukeminen 114

steriilin pöydän tekeminen 129, 130
sterilointi 121
stetoskooppi 321, 360
stooma 297
subkutaanisen injektion antaminen 155
sublinguaalinen 148
suihkupaarit 192
suodattuminen 306
suojaeristyksen toteuttaminen 128
suojakäsineiden käyttö 113
suojavaatetus 117
suola 249
suoliavanne 297
suoliäänet 291
suora rajoitusmuoto 379
suora reisilihas 159
suprapubinen kystostomia 287
suru 392
suulämpö 371
suu-nenäsuojus 117
suun hoito 195, 265
suunnitellut toiminnot 54, 57
suusumute 149
sydämen sykkeen seuranta ja mittaus 355
sydänasento 366
sydänfilmi 356, 358
sydänekäyrä 355
sydänsähkökäyrä 356
sykkeen tunnuslukohdat 355
sykähdytys 353
syllisyys 391
syöpään liittyvä kipu 99
sähköinen potilastietojärjestelmä 52
sähköinen resepti 133
säärihaava 229, 231

T

tabletinmurskain 138
tabletti 149
tablettien nielemisvaikeus 146
tablettileikkuri 138
tajunnanhäiriö 101
tajunnan tason seuranta 101
tajuton 101
tapaturmarekisteri 382
tapaturmariski 382
tartunnan kantaja 106
tartunnan lähde 106
tartuntaportti 107
tartuntatapa 106
tartuntatie 106
tartuntavaarallinen jäte 123
tasapainoasti 93
tavanomaiset varotoimet 109, 110, 125

tehdaspuhtaat suojakäsineet 114
teho-osasto 78
tehostetun valvonnan yksikkö 78
telemetria-EKG 356
terapeuttinen leveys 142
terveet elämäntavat 63
terve iho 173
terveydenhoitaja 75
terveydenhuoltolaki 52
terveys 13
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 69, 70
terveyserot 63, 64
terveyskeskeisyyden periaate 29
terveyskeskus 71, 416
terveysneuvonta 69
terveystieteiden kandidaatin tutkinto 20
terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 21
terveystieteiden maisterin tutkinto 21
tiedonkulkua 415
tietosuojat 49
toimenpidealueen ihon desinfiointi 130, 131
toimenpidehuone 122
toiminnallinen kuntoutus 223
toimintakyky 388, 390, 397
toimintakyvyn mittari 202
toimintaterapeutti 75
toimintaterapia 223, 397
toistokatetrointi 287
toivo 390, 393, 402
toukkahoito 232
trakeostomia 340
trakeostooma 340
trakeostoomakanyylista imeminen 342
transdermaalinen 165
transkulttuurinen hoitotyö 45
trauma 228
traumaperäinen stressireaktio 43
traumaterapia 397
Trendelenburgin asento 367
trombi 366
tukihenkilö 417
tukipalvelu 419
tukisauva 218
tukiviittominen 40
tulkki 39, 77, 399
tuntidiureesi 272
tuntoasti 92
tupakointi 66, 367
turvallisuuden periaate 28
turvaruisku 151
turvotus 247

tutkimustieto 60
tyhjän potilasvuoteen sijaaminen 177
työasu 117
työn aiheuttama terveysriski 202
työpistekohtainen työasu 117
täydennyskoulutus 19, 20
täydennysravintovalmiste 255

U

ulostaminen 291
ulostenäyte 296
ulostuslääke 293
ummetus 293
ummetuspotilaan hoito 293
unettomuus 179, 180, 184
uniapnea 180, 182
unihygienian parantaminen 184
unihygieniohjeet 185
uni- ja valvetilan seuranta 178
unilääke 184, 185
unisykli 179
univaihe 179
unta edistävä toiminta 183
urostooma 287

V

vaaratapahtuma 377
vaikutunut hengitys 321
vaipan vaihtaminen vuodepotilaalle 280
vajaaravitsemus 245
vakuuminäytteen otto 317
vakuumitekniikka 276, 316
valtimoperäinen säärihaava 230
varotoimet 126
VAS-kipujana 99
vastustuskyky 107
vatsa-asento 211
vatsanpuoleinen pakaralihas 158
vektoritartunta 107
ventilaatio 319, 343
ventrogluteaalinen alue 158
ventrogluteaalinen pakaralihas 160
ventrogluteaalisen pistoskohdan paikallistaminen 160
venturimaski 331
verenkierto 351
verenpaine 353
verenpaineen mittaus 360
verenpainemittari 360
verenpainetason luokittelu 363
verikaasuanalyysi 308, 329
verinahka 225
veritapaturma 163
veritapaturman ehkäisy 164
verivarotoimet 125

vertaistuki 391
 vesi 243
 vesiperäruiske 293, 294
 vesiperäruiskeen antaminen 295
 viilennyshoito 372
 virikeohjaaja 222
 viriketoiminta 222
 virtausmittari 333
 virtsaaminen 272
 virtsaamisen apuvälineet 277, 278
 virtsa-avanne 287, 288, 297
 virtsaelimistön rakenne 271
 virtsaelimistön toiminta 271
 virtsainkontinenssi 279
 virtsankarkailu 279
 virtsan tarkkailu 272
 virtsarakko 271
 virtsatestiliuskakoe 274
 virtsatieinfektio 273, 286
 virtsatietulehduspotilaan hoito 288
 virtsaumpi 273, 278
 virulenssi 105
 virus 106
 viskeraalinen kipu 98
 viskeraalinen rasva 247
 vitamiinit 243
 voimavara 13, 188, 204, 387
 voimavarakeskeinen ajattelu 389
 vuodeosasto 77
 vuodepesu 189
 vuodepotilaan liikkumisessa
 avustaminen 206
 vuorokausimittaus 364
 vuorotahtikävely 219
 vuorotyö 183
 vuorovaikutus 37, 39, 400
 vuoteen lisävarusteet 175
 välinehuoltokeskus 78, 121

W

WHO:n ohje ripulijuoman
 valmistukseen 297

Y

ydinlämpö 370, 373
 yhteispäivystys 77
 yksilöllisyyden periaate 27
 yksilön kehitys 33
 yksinäisyyden kokemus 400
 yksityinen sosiaali- ja
 terveydenhuoltojärjestelmä 73
 yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
 73
 yksityisyyden periaate 28
 yksityisyys 400
 yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 388

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 19
 ylivuotoinkontinenssi 279
 yläpaine 353
 ympäristön voimavara 13, 390
 yskimistekniikka 325
 yskös 322

Ä

äkillinen hengitysvajaus 344
 äkillinen suoliston tulehdus 300
 älykäs lääkeannostelija 169
 ääreislämpö 370, 371

Piirroksat ja kuvat:

Antero Airos (s. 17, 44, 94, 140)

Eduard Müller (s. 111, 118, 120, 139 kuvat 8.1 ja 8.2, 141, 142, 148, 151 kuva 8.10, 152-153, 156-157 kuvat 8.12 ja 8.13, 166-167, 175-178, 192-193, 196-201, 205-206, 208-210, 214-217, 243, 252, 259-263, 265, 266, 268 ylh., 271, 278, 280-281, 285, 288, 294-296, 299, 302, 326 ylempi, 328-332, 336, 338-340, 351, 355 kuva 15.2, 356, 360, 410, 411)

Seija Rusanen (s. 14, 18, 45, 55, 72, 81, 82, 85, 87, 88 alempi, 100, 101, 107, 110, 112, 114, 115, 127, 130, 141, 139 kuva 8.3, 151 kuva 8.9, 154, 156 vasemmanpuoleinen, 159-162, 165, 175 kuva 9.1, 189-190, 194, 211-212, 218, 225, 228, 231, 233, 235, 239, 245, 254-255, 276, 283-284, 286, 317, 321, 324, 333, 346, 355 kuva 15.3, 358, 366)

Eila Sinivuori (s. 267, 361 ja 376)

Muut kuvalähteet:

- s. 10 Helsingin kaupunginmuseo / Väinö Kannisto
- s. 22 Monkey Business Images / Shutterstock
- s. 32 Monkey Business Images / Shutterstock
- s. 38 Mirja Ojala
- s. 48 Shutterstock
- s. 62 Slawomir Kruz / Shutterstock
- s. 80 AdobeStock
- s. 88 Jouko Vatanen / Näkövammaisten liitto ry.
- s. 104 Andrey Popov / AdobeStock
- s. 132 Jan Mika / PantherMedia via Sanoma Pro Oy
- s. 146 Linde Healthcare
- s. 172 Diana Drubig / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 219 Työterveyslaitos
- s. 224 gpointstudio / Shutterstock
- s. 230 AdobeStock
- s. 242 AdobeStock
- s. 268 kesk. ja alh. Sanoma Pro Oy
- s. 270 Madhouse / Shutterstock
- s. 304 Budimir Jevtic / AdobeStock
- s. 318 Andrey Popov / Shutterstock
- s. 326 alempi kuva, Sanoma Pro Oy
- s. 327 Sanoma Pro Oy
- s. 335 Linde Healthcare
- s. 350 Shutterstock
- s. 362 Sanoma Pro Oy
- s. 374 Sairaanhoidon koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy
- s. 376 Arno Massee / AdobeStock
- s. 384 Suomen sairaanhoitajaliitto ry.
- s. 386 Sergey Smolyaninov / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 395 ylh. Shutterstock
- s. 395 kesk. Simone Werner-Ney / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 395 alh. Leonid / AdobeStock
- s. 396 vas. AdobeStock
- s. 396 oik. kirjan tekijät
- s. 400 Barbro Wickström / Rodeo via Sanoma Pro Oy
- s. 414 AdobeStock

Kirjan valokuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity tekstiin.

